

Bunga Rampai
**KESEHATAN DAN
TUMBUH KEMBANG**
Anak Perempuan Menuju Pubertas

Rini Jusriani • Zulfitrwati • Nina Isywar Kusuma
Norlaila Sofia • Darah Ifalahma • Prastiwi Putri Basuki • Faridah

Editor: Jeni Oktavia Karundeng



BUNGA RAMPAI KESEHATAN DAN TUMBUH KEMBANG ANAK PEREMPUAN MENUJU PUBERTAS

Penulis:

Rini Jusriani, SKM., M.Kes.
Zulfitrawati, S.Gz., M.Gz.
Nina Isywara Kusuma, SKM., M.Kes.
Norlaila Sofia, S.Si.T., M.Keb.
Darah Ifalahma, SST., M.Kes.
Prastiwi Putri Basuki, S.K.M., M.Si.
Dr. Faridah, SST., Ns., M.Kes.

Editor:

Ns. Jeni Oktavia Karundeng, M.Kep., Sp.Kep.A.



Bunga Rampai Kesehatan dan Tumbuh Kembang Anak Perempuan Menuju Pubertas

Penulis:

Rini Jusriani, SKM., M.Kes.
Zulfitriwati, S.Gz., M.Gz.
Nina Isywara Kusuma, SKM., M.Kes.
Norlaila Sofia, S.Si.T., M.Keb.
Darah Ifalahma, SST., M.Kes.
Prastiwi Putri Basuki, S.K.M., M.Si.
Dr. Faridah, SST., Ns., M.Kes.

Editor: Ns. Jeni Oktavia Karundeng, M.Kep., Sp.Kep.A.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7756-21-3

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku bunga rampai berjudul “Kesehatan dan Tumbuh Kembang Anak Perempuan Menuju Pubertas.” Buku ini disusun sebagai salah satu referensi ilmiah dan edukatif dalam memahami proses pertumbuhan, perkembangan, serta kesehatan anak perempuan pada masa transisi menuju pubertas. Masa pubertas merupakan tahap penting dalam kehidupan anak perempuan yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, sosial, dan reproduksi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang tepat dari keluarga, tenaga kesehatan, pendidik, dan masyarakat agar anak perempuan dapat menjalani masa pubertas dengan sehat, percaya diri, dan optimal.

Buku ini membahas secara sistematis konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan anak perempuan, indikator tumbuh kembang normal, serta pentingnya pemantauan kesehatan sejak dini. Selain itu, pembaca akan memperoleh pemahaman mengenai perubahan fisik dan psikologis menjelang pubertas, kebutuhan nutrisi untuk mendukung tumbuh kembang optimal, serta pentingnya pola makan seimbang dalam mencegah berbagai masalah kesehatan. Pembahasan juga mencakup kebersihan diri dan kesehatan organ reproduksi sejak dini, strategi edukasi kesehatan reproduksi sesuai usia, serta pencegahan anemia dan masalah kesehatan lain yang sering terjadi pada anak perempuan menjelang pubertas.

Pada bagian selanjutnya, buku ini menguraikan peran keluarga dalam pendampingan anak perempuan menuju pubertas, termasuk dukungan emosional, komunikasi, dan pendidikan kesehatan yang tepat. Buku ini juga membahas evaluasi kesehatan dan tumbuh kembang anak perempuan berdasarkan tahapan usia serta anticipatory guidance sebagai upaya persiapan menghadapi perubahan pubertas secara sehat dan positif. Penulis berharap buku bunga rampai ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, bidan, guru, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak perempuan menuju masa pubertas yang optimal.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 KONSEP DASAR PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK

PEREMPUAN	1
Rini Jusriani, SKM., M.Kes.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pertumbuhan Anak Perempuan Menuju Pubertas	2
C. Perkembangan Anak Perempuan Menuju Pubertas	4
D. Tahapan Perkembangan Anak Perempuan Menuju Pubertas.....	4
E. Indikator Pertumbuhan dan Perkembangan yang Normal	8
F. Pentingnya Pemantauan Tumbuh Kembang Anak Perempuan.....	10
G. Peran Keluarga dalam Pemantauan Tumbuh Kembang	14
H. Penelitian tentang Asupan Fe, Perilaku Jajan Anak, dan Pengetahuan Ibu terhadap Kejadian Anemia pada Anak Sekolah di Wilayah Pesisir	15
I. Referensi.....	18

CHAPTER 2 PERUBAHAN FISIK DAN PSIKOLOGIS MENJELANG PUBERTAS ...21

Zulfitriwati, S.Gz., M.Gz.	21
A. Pendahuluan.....	21
B. Perubahan Fisik Menjelang Pubertas.....	22
C. Perubahan Psikologis.....	25
D. Peran Orang Tua.....	32
E. Menjaga Kesehatan Selama Pubertas	36
F. Simpulan.....	42
G. Referensi.....	43
H. Glosarium	45

CHAPTER 3 PEMENUHAN NUTRISI UNTUK Mendukung TUMBUH

KEMBANG OPTIMAL.....	47
Nina Isywar Kusuma, SKM., M.Kes.	47
A. Pendahuluan.....	47
B. Pengertian Nutrisi dan Tumbuh Kembang Anak.....	48

C. Kebutuhan Nutrisi Anak Perempuan Menuju Pubertas	50
D. Pola Makan Seimbang untuk Anak Perempuan	61
E. Dampak Kekurangan dan Kelebihan Nutrisi	63
F. Peran Orang Tua dalam Pemenuhan Nutrisi Anak	66
G. Simpulan.....	69
H. Referensi.....	70
I. Glosarium.....	72

CHAPTER 4 KEBERSIHAN DIRI DAN KESEHATAN ORGAN REPRODUKSI

SEJAK DINI.....75

Norlaila Sofia, S.Si.T., M.Keb.	75
A. Pendahuluan.....	75
B. Konsep Dasar Kebersihan Diri (<i>Personal Hygiene</i>)	76
C. Praktik Kebersihan Diri yang Benar pada Anak Perempuan.....	78
D. Kesehatan Organ Reproduksi Eksternal pada Anak Perempuan	80
E. Tanda-Tanda Masalah Kesehatan Reproduksi yang Perlu Diwaspadai.....	83
F. Contoh Kasus Klinis	85
G. Strategi Edukasi Kebersihan Diri Sesuai Usia	87
H. Prinsip Komunikasi dalam Edukasi Kebersihan Reproduksi	88
I. Peran penting bidan.....	88
J. Ringkasan dan Poin Kunci.....	89
K. Referensi.....	90
L. Glosarium.....	93

CHAPTER 5 PENCEGAHAN ANEMIA DAN MASALAH KESEHATAN PADA

ANAK PEREMPUAN97

Darah Ifalahma, SST., M.Kes.....	97
A. Pendahuluan.....	97
B. Anemia pada Anak Perempuan	98
C. Epidemiologi Anemia pada Anak Perempuan.....	99
D. Dampak Anemia terhadap Kesehatan Anak Perempuan.....	101
E. Faktor Risiko Anemia pada Anak Perempuan	102
F. Strategi Pencegahan Anemia pada Anak Perempuan.....	104
G. Program Penatalaksanaan Anemia pada Anak Perempuan	106
H. Simpulan.....	110
I. Referensi.....	110
J. Glosarium.....	112

CHAPTER 6 PERAN KELUARGA DALAM PENDAMPINGAN ANAK PEREMPUAN MENUJU PUBERTAS.....	113
Prastiwi Putri Basuki, S.K.M., M.Si.....	113
A. Pendahuluan.....	113
B. Tantangan Yang Dihadapi Anak Perempuan Menuju Pubertas.....	116
C. Peran Keluarga dalam Pendampingan Pubertas	126
D. Simpulan.....	134
E. Referensi.....	135
 CHAPTER 7 EVALUASI KESEHATAN DAN TUMBUH KEMBANG ANAK PEREMPUAN	139
Dr. Faridah, SST., Ns., M.Kes.....	139
A. Pendahuluan.....	139
B. Konsep Evaluasi Kesehatan dan Tumbuh Kembang Anak Perempuan Menuju Pubertas	141
C. Komponen Evaluasi pada Anak Perempuan Usia Pra-Pubertas (8–9 tahun)	143
D. Komponen Evaluasi Anak Perempuan Awal Pubertas (10–14 tahun)	150
E. Anticipatory Guidance (bimbingan antisipatif) Menuju Pubertas	153
F. Referensi.....	156
G. Glosarium.....	157
 PROFIL PENULIS	159

CHAPTER 1

KONSEP DASAR PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ANAK PEREMPUAN

Rini Jusriani, SKM., M.Kes.

A. Pendahuluan

Anak perempuan merupakan kelompok usia yang mengalami proses tumbuh kembang yang sangat dinamis sejak masa kanak-kanak hingga memasuki masa pubertas. Periode ini menjadi fondasi penting dalam menentukan kualitas kesehatan, kapasitas belajar, kondisi psikososial, serta status kesehatan reproduksi pada masa dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan yang berlangsung secara optimal tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, pola asuh, status gizi, aktivitas fisik, kondisi sosial ekonomi, hingga paparan media digital yang semakin meningkat pada era modern.

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah pertumbuhan dan perkembangan sering digunakan secara bersamaan, meskipun keduanya memiliki makna yang berbeda. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan ukuran fisik tubuh yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti peningkatan berat badan, tinggi badan, serta ukuran organ tubuh. Sementara itu, perkembangan mengacu pada peningkatan kemampuan fungsi tubuh, kemampuan berpikir, emosional, sosial, dan keterampilan anak yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Pada anak perempuan, proses tumbuh kembang memiliki karakteristik yang khas dibandingkan anak laki-laki. Anak perempuan umumnya mengalami percepatan pertumbuhan lebih awal, terutama menjelang masa pubertas. Selain itu, perubahan hormonal yang mulai terjadi secara perlahan sejak usia sekolah dasar turut memengaruhi kondisi fisik, emosional, dan perilaku anak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan menjadi penting sebagai landasan dalam mendukung kesehatan anak perempuan secara menyeluruh.

Laporan World Health Organization menunjukkan bahwa investasi kesehatan pada anak perempuan memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas generasi mendatang, termasuk dalam pencegahan stunting, anemia, gangguan kesehatan reproduksi, dan penyakit tidak menular pada usia dewasa. Anak perempuan yang tumbuh sehat cenderung memiliki kemampuan belajar yang

lebih baik, kesehatan mental yang lebih stabil, serta kesiapan yang lebih optimal dalam menghadapi fase pubertas dan kehidupan reproduksi di masa mendatang.

Di sisi lain, berbagai tantangan modern turut memengaruhi kualitas tumbuh kembang anak perempuan. Pola makan yang kurang sehat, rendahnya aktivitas fisik, paparan gawai yang berlebihan, gangguan tidur, hingga tekanan sosial di lingkungan sekolah dapat memengaruhi kondisi fisik maupun psikologis anak. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai penelitian juga menunjukkan peningkatan masalah kesehatan pada anak perempuan, termasuk obesitas, gangguan citra tubuh, kecemasan, dan gangguan perilaku makan. Kondisi ini menegaskan pentingnya pemantauan tumbuh kembang secara komprehensif sejak dini.

Topik ini membahas konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan anak perempuan sebagai landasan untuk memahami perubahan yang akan terjadi pada tahap selanjutnya. Pembahasan meliputi pengertian pertumbuhan dan perkembangan, karakteristik tumbuh kembang anak perempuan, faktor-faktor yang memengaruhi, indikator tumbuh kembang normal, serta pentingnya pemantauan kesehatan sejak usia dini. Dengan memahami konsep dasar ini, diharapkan orang tua, tenaga kesehatan, pendidik, maupun masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung tumbuh kembang anak perempuan secara optimal.

B. Pertumbuhan Anak Perempuan Menuju Pubertas

Pertumbuhan anak perempuan merupakan proses peningkatan ukuran fisik tubuh yang terjadi secara bertahap sejak masa kanak-kanak hingga menjelang pubertas. Pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya tinggi badan, berat badan, ukuran organ tubuh, massa otot, serta perubahan komposisi tubuh yang dapat diukur secara kuantitatif. Proses ini berlangsung secara kontinu, meskipun kecepatan pertumbuhan berbeda pada setiap tahap usia. Pada anak perempuan, pola pertumbuhan memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan anak laki-laki. Anak perempuan umumnya mengalami percepatan pertumbuhan lebih awal, terutama ketika mendekati masa pubertas. Kondisi ini dipengaruhi oleh aktivitas hormon pertumbuhan dan hormon reproduksi yang mulai meningkat secara bertahap sejak usia sekolah dasar akhir. Oleh karena itu, masa anak-anak hingga pra-pubertas menjadi periode penting dalam pembentukan fondasi kesehatan fisik anak perempuan.

Pertumbuhan yang optimal mencerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar anak, terutama kecukupan nutrisi, kesehatan yang baik, aktivitas fisik yang cukup, serta lingkungan yang mendukung. Sebaliknya, gangguan pertumbuhan dapat

menjadi indikator awal adanya masalah kesehatan, kekurangan zat gizi, infeksi berulang, gangguan hormonal, maupun faktor psikososial yang memengaruhi kondisi anak.

Pertumbuhan anak perempuan berlangsung melalui beberapa karakteristik utama, yaitu:

1. Bersifat Kuantitatif

Pertumbuhan dapat diukur menggunakan indikator tertentu, seperti:

- a. berat badan,
- b. tinggi badan,
- c. lingkar kepala,
- d. indeks massa tubuh,
- e. dan komposisi tubuh.

Pengukuran ini penting untuk menilai apakah pertumbuhan anak sesuai dengan standar usianya.

2. Terjadi Secara Bertahap dan Berkesinambungan

Pertumbuhan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berlangsung perlahan dan terus-menerus. Pada masa tertentu, terutama menjelang pubertas, anak perempuan akan mengalami percepatan pertumbuhan yang dikenal sebagai growth spurt.

3. Dipengaruhi Banyak Faktor

- a. Pertumbuhan anak perempuan dipengaruhi oleh:
- b. faktor genetik,
- c. hormon,
- d. asupan nutrisi,
- e. kualitas tidur,
- f. aktivitas fisik,
- g. status kesehatan,
- h. dan lingkungan sosial.

Interaksi faktor-faktor tersebut menentukan kualitas pertumbuhan anak secara keseluruhan.

4. Memiliki Pola Pertumbuhan yang Khas

Anak perempuan cenderung mengalami peningkatan massa lemak tubuh lebih awal dibandingkan anak laki-laki sebagai bagian dari persiapan biologis menuju pubertas. Selain itu, pertumbuhan tinggi badan pada anak perempuan biasanya mencapai puncaknya lebih cepat.

C. Perkembangan Anak Perempuan Menuju Pubertas

Perkembangan anak perempuan merupakan proses bertambahnya kemampuan fungsi tubuh yang berlangsung secara bertahap menuju kematangan fisik, psikologis, emosional, sosial, dan kognitif. Berbeda dengan pertumbuhan yang berfokus pada perubahan ukuran tubuh, perkembangan lebih menekankan pada peningkatan kualitas kemampuan individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pubertas adalah masa transisi dari anak-anak menjadi remaja dewasa secara biologis, ditandai dengan perubahan fisik, hormonal, emosional, dan sosial yang cepat. Pada anak perempuan, pubertas biasanya dimulai lebih awal dibandingkan anak laki-laki.

Perkembangan anak perempuan menuju pubertas merupakan proses yang kompleks karena melibatkan perubahan biologis sekaligus perubahan perilaku dan emosional. Pada fase ini, anak mulai mengalami peningkatan kemampuan berpikir, pembentukan identitas diri, perubahan pola interaksi sosial, serta peningkatan sensitivitas emosional sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan. Masa menjelang pubertas menjadi periode penting dalam pembentukan karakter dan kesehatan mental anak perempuan. Dukungan keluarga, lingkungan sekolah, pola asuh, dan stimulasi yang tepat sangat berperan dalam membantu anak menghadapi perubahan yang terjadi secara sehat dan positif.

Perkembangan berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan fungsi tubuh yang tidak selalu dapat diukur menggunakan angka. Perubahan ini terlihat melalui kemampuan anak dalam berpikir, berkomunikasi, bersosialisasi, dan mengelola emosi. Perkembangan terjadi secara bertahap dari kemampuan sederhana menuju kemampuan yang lebih kompleks. Anak belajar memahami diri sendiri dan lingkungannya secara perlahan sesuai tingkat kematangan usia.

Lingkungan keluarga, pendidikan, interaksi sosial, serta pengalaman belajar sangat memengaruhi perkembangan anak perempuan. Anak yang mendapatkan dukungan emosional dan stimulasi positif cenderung memiliki perkembangan yang lebih optimal. Perkembangan tidak hanya terjadi pada satu aspek, tetapi meliputi: perkembangan motorik, perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan emosional, dan perkembangan sosial. Semua aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain.

D. Tahapan Perkembangan Anak Perempuan Menuju Pubertas

Perkembangan anak perempuan berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan sejak masa kanak-kanak hingga memasuki pubertas. Setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, maupun perilaku. Tahapan ini tidak berlangsung secara

sama pada setiap anak karena dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, pola asuh, status kesehatan, serta stimulasi yang diterima selama proses tumbuh kembang.

Pemahaman mengenai tahapan perkembangan anak perempuan penting dilakukan agar orang tua, pendidik, dan tenaga kesehatan mampu memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan anak pada setiap fase usia. Selain itu, pemahaman ini juga membantu dalam mendeteksi kemungkinan hambatan perkembangan sejak dini.

Secara umum, perkembangan anak perempuan menuju pubertas dapat dibagi menjadi beberapa tahapan berikut.

1. Masa Kanak-Kanak Awal

Masa kanak-kanak awal merupakan fase dasar pembentukan kemampuan motorik, bahasa, emosi, dan sosial anak. Pada tahap ini, anak perempuan mulai aktif mengeksplorasi lingkungan sekitarnya dan menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi.

Perkembangan motorik berlangsung cukup pesat, ditandai dengan meningkatnya kemampuan berjalan, berlari, melompat, serta koordinasi gerakan tubuh yang semakin baik. Anak juga mulai mampu melakukan aktivitas sederhana secara mandiri, seperti makan sendiri, mengenakan pakaian, dan merapikan barang-barang pribadinya. Dari aspek bahasa, anak perempuan mulai mengalami peningkatan kemampuan berbicara dan memahami komunikasi. Kosakata bertambah secara bertahap sehingga anak mampu menyampaikan keinginan, perasaan, dan pikirannya dengan lebih jelas. Perkembangan emosional pada tahap ini masih cenderung sederhana. Anak mulai mengenali berbagai emosi dasar seperti senang, sedih, marah, dan takut. Namun, kemampuan mengendalikan emosi masih terbatas sehingga anak masih memerlukan pendampingan dan arahan dari orang dewasa. Dalam aspek sosial, anak mulai belajar berinteraksi dengan anggota keluarga maupun teman sebaya. Anak belajar berbagi, menunggu giliran, serta memahami aturan sederhana dalam lingkungan sosialnya. Tahap ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan rasa aman, kepercayaan diri, dan kemampuan adaptasi anak pada tahap perkembangan berikutnya.

2. Masa Usia Sekolah

Masa usia sekolah ditandai dengan perkembangan kemampuan berpikir dan interaksi sosial yang semakin kompleks. Anak perempuan mulai menunjukkan kemampuan memahami aturan, menyelesaikan masalah sederhana, serta meningkatkan kemampuan belajar secara lebih sistematis.

Pada tahap ini, perkembangan kognitif berkembang cukup pesat. Anak mulai mampu:

- a. berpikir logis,
- b. memahami hubungan sebab-akibat,
- c. meningkatkan konsentrasi,
- d. dan mengembangkan kemampuan akademik.

Kemampuan membaca, menulis, serta berhitung berkembang lebih baik seiring bertambahnya pengalaman belajar di sekolah. Perkembangan sosial juga mengalami peningkatan yang signifikan. Anak mulai membangun hubungan pertemanan yang lebih luas dan mulai memahami pentingnya penerimaan sosial dalam kelompok sebaya. Pendapat teman mulai memengaruhi perilaku dan rasa percaya diri anak perempuan.

Dalam aspek emosional, anak mulai belajar memahami perasaan orang lain dan mengembangkan empati. Namun, pada fase ini anak juga mulai menjadi lebih sensitif terhadap kritik maupun penilaian sosial.

Perkembangan moral mulai terbentuk melalui pemahaman mengenai aturan, tanggung jawab, dan nilai-nilai sosial yang berlaku di lingkungan keluarga maupun sekolah. Anak perempuan mulai belajar membedakan perilaku yang dianggap baik dan kurang baik berdasarkan norma yang diajarkan. Selain itu, pada masa usia sekolah mulai tampak tanda-tanda awal perubahan biologis menuju pubertas, meskipun belum berlangsung secara nyata. Oleh karena itu, fase ini menjadi waktu yang tepat untuk mulai memberikan edukasi kesehatan dan pembentukan kebiasaan hidup sehat.

3. Masa Pra-Pubertas

Masa pra-pubertas merupakan tahap transisi antara masa kanak-kanak menuju masa pubertas. Pada fase ini mulai terjadi perubahan hormonal yang memengaruhi kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak perempuan.

Perubahan fisik awal dapat mulai terlihat melalui:

- a) percepatan pertumbuhan tinggi badan,
- b) perubahan bentuk tubuh,
- c) peningkatan jaringan lemak tubuh,
- d) serta mulai berkembangnya organ reproduksi secara bertahap.

Walaupun perubahan fisik belum sepenuhnya jelas, tubuh anak mulai mempersiapkan diri menuju kematangan reproduksi. Perkembangan emosional pada tahap ini cenderung menjadi lebih kompleks. Anak perempuan mulai mengalami perubahan suasana hati yang lebih sensitif dibandingkan

sebelumnya. Anak mulai memiliki kebutuhan privasi yang lebih besar dan lebih memperhatikan penampilan diri.

Pada aspek kognitif, kemampuan berpikir abstrak mulai berkembang. Anak mulai mampu memahami konsep yang lebih kompleks, memikirkan masa depan, mempertanyakan berbagai hal, serta membentuk pendapat pribadi terhadap lingkungan sekitarnya. Perkembangan sosial juga mengalami perubahan. Hubungan dengan teman sebaya menjadi semakin penting dan mulai memengaruhi pembentukan identitas diri. Anak perempuan mulai mencari penerimaan sosial serta mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Masa pra-pubertas merupakan periode yang sangat penting karena anak mulai mengalami perubahan yang dapat memengaruhi rasa percaya diri dan kesehatan mentalnya. Oleh sebab itu, pendampingan keluarga yang suportif dan komunikasi yang terbuka menjadi faktor penting dalam membantu anak menghadapi perubahan secara positif.

4. Masa Menuju Pubertas

Menjelang pubertas, perkembangan anak perempuan berlangsung semakin cepat dan kompleks. Perubahan biologis yang dipicu oleh peningkatan hormon reproduksi mulai memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan anak. Pada tahap ini, anak perempuan mulai menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap identitas diri, penampilan fisik, serta hubungan sosial. Anak juga mulai memiliki kebutuhan untuk dihargai dan dipahami sebagai individu yang sedang berkembang menuju kedewasaan.

Perkembangan emosional menjadi lebih dinamis. Anak dapat mengalami perubahan suasana hati yang cepat, lebih sensitif terhadap komentar lingkungan, dan mulai menghadapi tekanan sosial dari teman sebaya maupun media sosial. Dalam aspek sosial, hubungan pertemanan menjadi lebih dekat dan emosional. Anak mulai membangun kelompok sosial tertentu dan lebih memperhatikan penerimaan sosial dalam lingkungannya. Kemampuan berpikir juga berkembang menuju tahap yang lebih matang. Anak perempuan mulai mampu:

- a. berpikir kritis,
- b. mempertimbangkan konsekuensi,
- c. memahami perspektif orang lain,
- d. dan membangun konsep diri secara lebih jelas.

Tahap ini merupakan masa yang memerlukan dukungan emosional, edukasi kesehatan, dan komunikasi yang baik dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Anak perempuan yang mendapatkan pendampingan yang tepat

cenderung lebih siap menghadapi masa pubertas secara sehat, percaya diri, dan positif.

Setiap anak perempuan memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda. Ada anak yang mengalami perubahan lebih cepat, sementara yang lain berkembang lebih lambat. Perbedaan ini merupakan hal yang normal selama masih berada dalam rentang perkembangan yang wajar. Oleh karena itu, perkembangan anak tidak seharusnya dibandingkan secara berlebihan dengan anak lain. Pendekatan yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan dukungan yang cukup untuk berkembang sesuai potensinya masing-masing.

E. Indikator Pertumbuhan dan Perkembangan yang Normal

Pertumbuhan dan perkembangan yang normal menunjukkan bahwa anak perempuan mengalami proses tumbuh kembang sesuai dengan tahapan usianya. Kondisi ini mencerminkan terpenuhinya kebutuhan biologis, nutrisi, psikologis, sosial, serta lingkungan yang mendukung kesehatan anak secara menyeluruh. Pemantauan indikator pertumbuhan dan perkembangan penting dilakukan secara berkala sebagai upaya deteksi dini terhadap kemungkinan gangguan kesehatan maupun hambatan tumbuh kembang.

Indikator pertumbuhan dan perkembangan tidak hanya digunakan oleh tenaga kesehatan, tetapi juga dapat menjadi pedoman bagi orang tua dan pendidik dalam memahami kondisi anak perempuan selama masa pertumbuhan menuju pubertas. Penilaian yang dilakukan secara rutin membantu memastikan bahwa anak berkembang sesuai potensi optimalnya.

Indikator pertumbuhan berkaitan dengan perubahan fisik tubuh yang dapat diukur secara objektif. Pertumbuhan normal menunjukkan bahwa tubuh anak mengalami peningkatan ukuran dan fungsi biologis sesuai tahapan usia.

1. Pertambahan Tinggi Badan Sesuai Usia

Tinggi badan merupakan salah satu indikator utama pertumbuhan anak perempuan. Pertambahan tinggi badan yang berlangsung secara konsisten menunjukkan pertumbuhan tulang dan jaringan tubuh yang optimal.

Pada masa anak-anak hingga menjelang pubertas, tinggi badan anak perempuan meningkat secara bertahap. Menjelang pubertas biasanya terjadi percepatan pertumbuhan tinggi badan akibat pengaruh hormon pertumbuhan dan hormon reproduksi.

Pertumbuhan tinggi badan yang terlalu lambat dapat menjadi tanda:

a. kekurangan gizi,

- b. gangguan hormonal,
- c. penyakit kronis,
- d. atau masalah kesehatan lainnya.

Sebaliknya, pertumbuhan yang terlalu cepat juga perlu diperhatikan untuk memastikan tidak terdapat gangguan hormonal tertentu.

2. Peningkatan Berat Badan yang Proporsional

Berat badan mencerminkan keseimbangan antara asupan nutrisi dan kebutuhan tubuh. Anak perempuan dengan pertumbuhan normal umumnya mengalami peningkatan berat badan secara bertahap dan proporsional terhadap tinggi badannya.

Pemantauan berat badan penting dilakukan untuk mendeteksi:

- a. gizi kurang,
- b. stunting,
- c. overweight,
- d. maupun obesitas sejak dini.

Perubahan berat badan yang drastis dalam waktu singkat perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kesehatan fisik maupun psikologis anak.

3. Indeks Massa Tubuh Sesuai Rentang Normal

Indeks Massa Tubuh (IMT) digunakan untuk menilai proporsi antara berat badan dan tinggi badan anak. Pada anak perempuan, IMT membantu menggambarkan status gizi secara umum.

$$IMT = \frac{\text{berat badan (kg)}}{\text{tinggi badan (m)}^2}$$

Nilai IMT yang berada dalam rentang normal menunjukkan keseimbangan pertumbuhan tubuh. IMT yang terlalu rendah dapat mengindikasikan kekurangan gizi, sedangkan IMT yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko obesitas dan gangguan metabolik.

4. Pertumbuhan Tulang dan Komposisi Tubuh yang Sehat

Pertumbuhan normal juga ditandai dengan perkembangan tulang dan otot yang baik. Anak perempuan memerlukan:

- a. protein,
- b. kalsium,
- c. vitamin D,
- d. dan aktivitas fisik yang cukup untuk mendukung kesehatan tulang selama masa pertumbuhan.

Menjelang pubertas, anak perempuan secara alami mulai mengalami peningkatan jaringan lemak tubuh sebagai bagian dari persiapan biologis menuju kematangan reproduksi. Perubahan ini masih dianggap normal selama berada dalam proporsi yang sehat.

5. Kondisi Fisik Umum yang Baik

Pertumbuhan normal umumnya disertai kondisi fisik yang sehat, seperti:

- a. tubuh tampak bugar,
- b. aktif bergerak,
- c. nafsu makan baik,
- d. tidur cukup,
- e. dan jarang mengalami gangguan kesehatan berat.

Kondisi fisik yang sehat menunjukkan bahwa kebutuhan dasar pertumbuhan anak terpenuhi dengan baik.

Pemantauan indikator pertumbuhan dan perkembangan secara berkala penting dilakukan untuk memastikan anak perempuan tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemantauan dapat dilakukan melalui:

- a. pengukuran antropometri,
- b. observasi perkembangan,
- c. pemeriksaan kesehatan rutin,
- d. serta komunikasi aktif antara orang tua, guru, dan nakes

Deteksi dini terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan memungkinkan intervensi dilakukan lebih cepat sehingga dampak jangka panjang dapat diminimalkan. Selain itu, pemantauan yang baik membantu orang tua memahami kebutuhan anak pada setiap tahap usia, terutama menjelang pubertas yang merupakan periode perubahan penting dalam kehidupan anak perempuan. Pertumbuhan dan perkembangan yang normal bukan hanya mencerminkan kesehatan fisik, tetapi juga menunjukkan kesiapan anak dalam menghadapi tantangan sosial, emosional, dan psikologis pada tahap kehidupan berikutnya.

F. Pentingnya Pemantauan Tumbuh Kembang Anak Perempuan

Pemantauan tumbuh kembang anak perempuan merupakan bagian penting dalam upaya menjaga kesehatan dan kualitas hidup anak sejak dini. Masa anak-anak hingga menjelang pubertas merupakan periode yang sangat dinamis karena terjadi berbagai perubahan fisik, biologis, psikologis, dan sosial secara bertahap. Oleh sebab itu, pemantauan tumbuh kembang tidak hanya berfungsi untuk menilai kondisi kesehatan anak saat ini, tetapi juga menjadi langkah preventif dalam

mendeteksi berbagai gangguan kesehatan maupun hambatan perkembangan sejak awal.

Pada anak perempuan, pemantauan tumbuh kembang memiliki peran yang semakin penting karena fase menuju pubertas ditandai dengan perubahan yang cukup kompleks. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik, tetapi juga melibatkan perkembangan emosional, sosial, dan kesiapan mental anak dalam menghadapi masa remaja. Pemantauan yang dilakukan secara rutin membantu memastikan bahwa seluruh proses tersebut berlangsung secara sehat dan sesuai tahapan usia.

Selain itu, pemantauan tumbuh kembang juga menjadi bentuk perhatian terhadap hak anak untuk memperoleh kualitas kesehatan yang optimal. Anak perempuan yang tumbuh dan berkembang secara baik cenderung memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan pendidikan, sosial, maupun kesehatan reproduksi pada masa mendatang.

Salah satu tujuan utama pemantauan tumbuh kembang adalah mendeteksi gangguan pertumbuhan sedini mungkin. Tidak semua gangguan pertumbuhan dapat terlihat secara langsung oleh orang tua karena sebagian perubahan berlangsung perlahan. Melalui pemantauan rutin, perubahan yang tidak sesuai dengan standar usia dapat segera dikenali.

Beberapa gangguan pertumbuhan yang dapat dideteksi melalui pemantauan antara lain:

1. stunting,
2. gizi kurang,
3. berat badan berlebih,
4. obesitas,
5. serta gangguan pertumbuhan akibat penyakit tertentu.

Pada anak perempuan, gangguan pertumbuhan dapat memengaruhi kesiapan tubuh dalam menghadapi pubertas. Kekurangan nutrisi dalam jangka panjang misalnya, dapat menghambat pertumbuhan tinggi badan, menurunkan daya tahan tubuh, serta memengaruhi perkembangan hormonal.

Sebaliknya, peningkatan berat badan yang berlebihan juga perlu diperhatikan karena dapat meningkatkan risiko obesitas dan gangguan metabolik sejak usia dini. Dalam beberapa penelitian terbaru, obesitas pada anak perempuan dikaitkan dengan peningkatan risiko pubertas dini, gangguan citra tubuh, hingga masalah kesehatan reproduksi pada masa dewasa.

Dengan deteksi dini, intervensi kesehatan dan perbaikan pola hidup dapat dilakukan lebih cepat sehingga dampak jangka panjang dapat diminimalkan. Selain pertumbuhan fisik, pemantauan juga penting untuk menilai apakah perkembangan

anak berlangsung sesuai tahap usianya. Setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda, namun terdapat rentang perkembangan normal yang dapat dijadikan pedoman.

Pemantauan perkembangan membantu mengenali kemampuan anak dalam berbagai aspek, seperti:

1. kemampuan motorik,
2. kemampuan belajar,
3. perkembangan bahasa,
4. kemampuan sosial,
5. serta perkembangan emosional.

Anak perempuan yang mengalami hambatan perkembangan mungkin menunjukkan tanda-tanda seperti:

1. kesulitan berinteraksi,
2. keterlambatan berbicara,
3. sulit berkonsentrasi,
4. atau kesulitan mengendalikan emosi.

Jika kondisi tersebut tidak dikenali sejak dini, hambatan perkembangan dapat memengaruhi proses belajar, hubungan sosial, dan kesehatan mental anak pada tahap berikutnya. Pemantauan perkembangan secara rutin memungkinkan orang tua dan tenaga kesehatan memberikan stimulasi maupun pendampingan yang lebih tepat sesuai kebutuhan anak.

Masa menjelang pubertas merupakan periode transisi penting dalam kehidupan anak perempuan. Pada fase ini mulai terjadi perubahan hormonal yang memengaruhi kondisi fisik maupun psikologis anak. Pemantauan tumbuh kembang membantu memastikan bahwa proses menuju pubertas berlangsung secara sehat dan tidak menimbulkan gangguan yang berarti.

Melalui pemantauan rutin, orang tua dapat memahami perubahan yang mulai muncul pada anak perempuan, seperti:

1. percepatan pertumbuhan,
2. perubahan bentuk tubuh,
3. peningkatan sensitivitas emosional,
4. serta perubahan perilaku sosial.

Pemahaman ini penting agar keluarga mampu memberikan dukungan yang tepat tanpa menimbulkan rasa takut atau malu pada anak.

Selain itu, pemantauan tumbuh kembang juga membantu mempersiapkan anak secara mental dan emosional menghadapi perubahan tubuh yang akan terjadi pada masa pubertas. Anak perempuan yang mendapatkan pendampingan

yang baik cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih baik dan mampu menerima perubahan tubuhnya secara positif.

Pemantauan tumbuh kembang tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, tetapi juga perlu memperhatikan kesehatan psikologis anak perempuan. Pada masa usia sekolah hingga pra-pubertas, anak mulai mengalami perubahan emosional yang lebih kompleks.

Anak perempuan dapat menjadi lebih sensitif terhadap:

1. komentar lingkungan,
2. hubungan pertemanan,
3. prestasi akademik,
4. maupun perubahan fisik yang mulai terjadi pada tubuhnya.

Jika tidak didampingi dengan baik, kondisi tersebut dapat memengaruhi rasa percaya diri dan kesehatan mental anak.

Melalui pemantauan yang baik, orang tua dapat mengenali perubahan perilaku maupun kondisi emosional anak sejak dini, seperti:

1. mudah cemas,
2. menarik diri dari lingkungan sosial,
3. perubahan pola makan,
4. gangguan tidur,
5. atau penurunan semangat belajar.

Pendekatan yang suportif dan komunikasi yang terbuka sangat membantu anak perempuan merasa aman dan dipahami selama masa pertumbuhannya. Pemantauan tumbuh kembang juga menjadi sarana untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Anak perempuan yang terbiasa menjalani pola hidup sehat cenderung memiliki kualitas kesehatan yang lebih baik hingga dewasa.

Beberapa kebiasaan sehat yang perlu dipantau dan dibentuk meliputi:

1. pola makan bergizi seimbang,
2. aktivitas fisik teratur,
3. tidur yang cukup,
4. kebersihan diri,
5. serta penggunaan media digital secara bijak.

Pembiasaan pola hidup sehat sejak masa anak-anak membantu menurunkan risiko:

1. anemia,
2. obesitas,
3. penyakit metabolik,
4. maupun gangguan kesehatan reproduksi pada masa mendatang.

Selain itu, kebiasaan hidup sehat juga mendukung konsentrasi belajar, kesehatan mental, dan kualitas interaksi sosial anak perempuan.

G. Peran Keluarga dalam Pemantauan Tumbuh Kembang

Keluarga memiliki peran utama dalam pemantauan tumbuh kembang anak perempuan. Orang tua merupakan pihak yang paling dekat dengan anak sehingga memiliki kesempatan terbesar untuk mengamati perubahan fisik, perilaku, maupun kondisi emosional anak sehari-hari.

Pemantauan yang efektif memerlukan:

1. komunikasi yang terbuka,
2. perhatian yang konsisten,
3. pola asuh yang suportif,
4. serta keterlibatan aktif dalam kehidupan anak.

Orang tua juga perlu bekerja sama dengan tenaga kesehatan dan pihak sekolah dalam memantau kondisi tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Pendekatan yang penuh dukungan membantu anak perempuan merasa lebih nyaman dalam menghadapi perubahan yang terjadi selama masa pertumbuhan menuju pubertas. Pemantauan tumbuh kembang sebaiknya dilakukan secara rutin dan berkesinambungan karena pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung secara dinamis. Pemeriksaan berkala memungkinkan perubahan kondisi anak diketahui lebih cepat dibandingkan hanya mengandalkan pengamatan sesekali.

Pemantauan dapat dilakukan melalui:

1. pengukuran berat badan dan tinggi badan,
2. pemeriksaan kesehatan rutin,
3. observasi perilaku dan kemampuan anak,
4. serta evaluasi pola makan dan aktivitas fisik.

Dengan pemantauan yang konsisten, anak perempuan memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, berkembang optimal, dan menghadapi masa pubertas dengan kesiapan fisik maupun psikologis yang baik.

Pada akhirnya, pemantauan tumbuh kembang bukan sekadar kegiatan pemeriksaan kesehatan, melainkan bentuk investasi jangka panjang dalam membangun generasi perempuan yang sehat, percaya diri, dan berkualitas di masa depan.

H. Penelitian tentang Asupan Fe, Perilaku Jajan Anak, dan Pengetahuan Ibu terhadap Kejadian Anemia pada Anak Sekolah di Wilayah Pesisir

Anemia masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang cukup tinggi pada kelompok anak dan remaja di berbagai wilayah, termasuk daerah pesisir. Kondisi anemia pada anak perempuan perlu mendapatkan perhatian serius karena berkaitan erat dengan kualitas pertumbuhan, perkembangan kognitif, daya tahan tubuh, hingga kesiapan menghadapi masa pubertas. Anak perempuan yang mengalami anemia sejak usia sekolah memiliki risiko lebih besar mengalami gangguan konsentrasi belajar, mudah lelah, penurunan prestasi akademik, serta gangguan kesehatan reproduksi pada masa mendatang.

Penelitian yang dilakukan oleh Rini Jusriani, Syarfaini, Zulfitriwati, dan Sukfitrianty Syahrir berjudul *"Asupan Fe, Perilaku Jajan Anak, dan Pengetahuan Ibu terhadap Kejadian Anemia pada Anak Sekolah di Wilayah Pesisir"* memberikan gambaran penting mengenai kondisi anemia pada anak sekolah di wilayah pesisir Indonesia. Penelitian ini dipublikasikan dalam Jurnal Promotif Preventif Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024.

Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya kejadian anemia yang masih menjadi masalah kesehatan global, terutama pada kelompok perempuan dan anak usia sekolah. Anemia tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya asupan zat besi, tetapi juga dipengaruhi oleh pola makan, perilaku konsumsi makanan sehari-hari, kondisi sosial ekonomi keluarga, serta tingkat pengetahuan orang tua mengenai kesehatan dan gizi anak.

Wilayah pesisir menjadi salah satu area yang menarik untuk dikaji karena memiliki karakteristik sosial dan pola konsumsi yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan maupun pegunungan. Walaupun masyarakat pesisir memiliki akses terhadap sumber pangan laut yang kaya protein dan mineral, kejadian anemia masih tetap ditemukan pada kelompok anak sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan saja belum tentu menjamin terpenuhinya kebutuhan zat gizi anak secara optimal.

Penelitian dilaksanakan di Pulau Liukang, Desa Bira, Indonesia pada bulan April 2024 menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *cross sectional study*. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode total sampling dengan jumlah sampel sebanyak 37 anak sekolah beserta ibu mereka. Pendekatan ini digunakan untuk melihat hubungan antara asupan zat besi (Fe), asupan vitamin C, perilaku jajan anak, dan pengetahuan ibu terhadap kejadian anemia pada anak sekolah.

Dalam penelitian tersebut, anemia dipahami sebagai kondisi rendahnya kadar hemoglobin dalam darah yang dapat menghambat distribusi oksigen ke seluruh

jaringan tubuh. Pada anak usia sekolah, anemia dapat berdampak pada penurunan energi, gangguan kemampuan belajar, penurunan konsentrasi, serta hambatan pertumbuhan dan perkembangan. Kondisi ini menjadi semakin penting diperhatikan pada anak perempuan karena kebutuhan zat besi akan meningkat menjelang masa pubertas.

Asupan zat besi merupakan salah satu faktor utama yang sering dikaitkan dengan kejadian anemia. Zat besi berperan penting dalam pembentukan hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen dalam darah. Kekurangan zat besi dalam jangka panjang dapat menyebabkan tubuh mengalami gangguan pembentukan sel darah merah sehingga memicu anemia defisiensi besi.

Selain zat besi, vitamin C juga menjadi faktor penting karena berfungsi membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin C dapat meningkatkan absorpsi zat besi, terutama zat besi non-heme yang banyak ditemukan pada bahan pangan nabati. Oleh sebab itu, pola konsumsi makanan sehari-hari sangat memengaruhi status anemia pada anak.

Penelitian ini juga menyoroti perilaku jajan anak sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi kualitas asupan gizi. Pada usia sekolah, anak cenderung memiliki kebiasaan membeli makanan ringan atau jajanan di lingkungan sekolah maupun sekitar tempat tinggalnya. Banyak jajanan anak memiliki kandungan energi tinggi tetapi rendah zat gizi penting, termasuk zat besi dan vitamin. Jika perilaku jajan tidak dikontrol dengan baik, anak dapat mengalami ketidakseimbangan asupan nutrisi yang berdampak terhadap kesehatan dan pertumbuhannya.

Selain faktor konsumsi makanan, pengetahuan ibu mengenai anemia dan pemenuhan gizi anak juga menjadi perhatian penting dalam penelitian ini. Ibu memiliki peran utama dalam menentukan pola makan keluarga, memilih bahan pangan, serta membentuk kebiasaan makan anak. Pengetahuan ibu yang baik diharapkan mampu mendukung praktik pemberian makan yang lebih sehat dan bergizi seimbang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis chi-square, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara asupan Fe dengan kejadian anemia pada anak sekolah di wilayah pesisir dengan nilai p value sebesar 0,177. Selain itu, asupan vitamin C juga tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan kejadian anemia dengan nilai p sebesar 0,773. Variabel perilaku jajan anak dan pengetahuan ibu juga tidak menunjukkan hubungan yang bermakna secara statistik terhadap kejadian anemia dengan nilai p masing-masing sebesar 0,184 dan 0,912.

Temuan ini menunjukkan bahwa kejadian anemia pada anak sekolah kemungkinan dipengaruhi oleh faktor yang lebih kompleks dan multidimensional. Walaupun asupan zat besi merupakan faktor penting, anemia tidak hanya ditentukan oleh jumlah zat besi yang dikonsumsi. Faktor lain seperti penyakit infeksi, status kesehatan umum, pola konsumsi jangka panjang, kualitas penyerapan zat gizi, kebersihan lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi keluarga dapat turut berperan terhadap terjadinya anemia.

Hasil penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa pengetahuan ibu yang baik belum tentu selalu diikuti oleh praktik pemberian makan yang optimal. Dalam beberapa kondisi, keterbatasan ekonomi, akses pangan sehat, maupun kebiasaan makan keluarga dapat memengaruhi pola konsumsi anak meskipun ibu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai gizi.

Selain itu, perilaku jajan anak juga tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya faktor penyebab anemia. Jenis makanan yang dikonsumsi, frekuensi makan utama, kualitas pola makan harian, hingga aktivitas fisik anak turut memengaruhi kondisi kesehatan dan status gizi secara keseluruhan.

Kajian ini memberikan implikasi penting dalam upaya pencegahan anemia pada anak perempuan menuju pubertas. Pencegahan anemia tidak cukup hanya melalui peningkatan konsumsi zat besi, tetapi perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih komprehensif meliputi:

1. edukasi gizi,
2. pembiasaan pola makan sehat,
3. peningkatan kualitas sanitasi,
4. pemeriksaan kesehatan rutin,
5. serta penguatan peran keluarga dalam pemantauan kesehatan anak.

Pada anak perempuan, pencegahan anemia menjadi semakin penting karena kebutuhan zat besi akan meningkat menjelang pubertas akibat pertumbuhan cepat dan persiapan fungsi reproduksi. Anak perempuan yang mengalami anemia berisiko mengalami kelelahan kronis, penurunan daya tahan tubuh, gangguan konsentrasi belajar, bahkan gangguan kesehatan reproduksi pada masa dewasa.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pemantauan kesehatan anak sekolah secara berkala, terutama di wilayah pesisir yang memiliki karakteristik sosial dan pola konsumsi khas. Intervensi kesehatan masyarakat perlu mempertimbangkan kondisi budaya, pola makan lokal, serta kebiasaan masyarakat setempat agar program pencegahan anemia dapat berjalan lebih efektif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tumbuh kembang anak perempuan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Status kesehatan anak tidak hanya ditentukan oleh satu variabel tunggal,

melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor biologis, perilaku, lingkungan, dan sosial keluarga. Oleh karena itu, pendekatan kesehatan anak perempuan menuju pubertas perlu dilakukan secara holistik agar pertumbuhan dan perkembangan dapat berlangsung secara optimal.

I. Referensi

- Black, M. M., Lutter, C. K., & Trude, A. C. B. (2020). All children thriving: Integration of nutrition and early childhood development. *Annual Review of Nutrition*, 40, 375–406. <https://doi.org/10.1146/annurev-nutr-013120-043757>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Recommendations and rationale: Using WHO child growth standards*. [CDC Growth Chart Training](#)
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Summary: Using WHO child growth standards*. [CDC WHO Growth Standards Summary](#)
- Centers for Disease Control and Prevention. (2024). *Using WHO growth standard charts*. [CDC Using WHO Growth Charts](#)
- Cusick, S. E., & Georgieff, M. K. (2021). The role of nutrition in brain development: The golden opportunity of the “first 1000 days.” *The Journal of Pediatrics*, 175, 16–21. <https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.05.013>
- Fleming, T. P., Watkins, A. J., Velazquez, M. A., Mathers, J. C., Prentice, A. M., Stephenson, J., Barker, M., Saffery, R., Yajnik, C. S., Eckert, J. J., Hanson, M. A., & Forrester, T. (2021). Origins of lifetime health around the time of conception: Causes and consequences. *The Lancet*, 391(10132), 1842–1852. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)30312-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30312-X)
- Graber, J. A. (2021). Puberty in girls and the role of contextual factors in psychological development. *Current Directions in Psychological Science*, 30(2), 141–146. <https://doi.org/10.1177/0963721421993876>
- Jusriani, R., Syarfaini, S., Zulfirawati, Z., & Syahrir, S. (2024). Asupan Fe, perilaku jajan anak, dan pengetahuan ibu terhadap kejadian anemia pada anak sekolah di wilayah pesisir. *Jurnal Promotif Preventif*, 7(3), 412–420. [Jurnal Promotif Preventif UNPACTI](#)
- Marume, A., Archary, M., & Mahomed, S. (2022). Validation of growth standards and growth references: A review of literature. *Journal of Child Health Care*, 26(3), 377–390. <https://doi.org/10.1177/13674935211024816>
- Patton, G. C., Sawyer, S. M., Santelli, J. S., Ross, D. A., Afifi, R., Allen, N. B., Arora, M., Azzopardi, P., Baldwin, W., Bonell, C., Kakuma, R., Kennedy, E., Mahon, J., McGovern, T., Mokdad, A. H., Patel, V., Petroni, S., Reavley, N., Taiwo, K., & Viner, R. M. (2021). Our future: A Lancet commission on adolescent health and wellbeing. *The Lancet*, 387(10036), 2423–2478. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)00579-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00579-1)

- Rodd, C., Feely, A., Becker, A. B., Moraes, T. J., Subbarao, P., Mandhane, P. J., Turvey, S. E., Lefebvre, D. L., Sears, M. R., Azad, M. B., & Sharma, A. (2020). World Health Organization growth standards: How do Canadian children measure up? *Paediatrics & Child Health*, 26(5), e208–e214. <https://doi.org/10.1093/pch/pxaa053>
- Sawyer, S. M., Azzopardi, P. S., Wickremarathne, D., & Patton, G. C. (2021). The age of adolescence. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 2(3), 223–228. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(18\)30022-1](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(18)30022-1)
- Steinberg, L. (2020). *Adolescence* (12th ed.). McGraw-Hill Education
- UNICEF Indonesia. (2023). *Situasi anak di Indonesia*. [UNICEF Indonesia](#)
- UNICEF. (2021). *The state of the world's children 2021: On my mind—promoting, protecting and caring for children's mental health*. [UNICEF Official Website](#)
- World Health Organization. (2020). *Improving early childhood development: WHO guideline*. [WHO Guideline on Early Childhood Development](#)
- World Health Organization. (2024). *Child growth standards*. [WHO Child Growth Standards](#)
- World Health Organization. (2024). *Child growth*. [WHO Child Growth](#)
- World Health Organization. (2024). *Standards*. [WHO Standards Documentation](#)
- World Health Organization. (2024). *WHO child growth standards training*. [WHO Growth Standards Training](#)

CHAPTER 2

PERUBAHAN FISIK DAN PSIKOLOGIS MENJELANG PUBERTAS

□ Zulfitrwati, S.Gz., M.Gz.

A. Pendahuluan

Masa pubertas merupakan fase penting dalam siklus kehidupan manusia yang menandai peralihan dari masa kanak-kanak menuju remaja. Pada anak perempuan, pubertas ditandai dengan berbagai perubahan fisik, hormonal, dan psikologis yang terjadi secara bertahap. Perubahan ini umumnya dimulai pada usia 8 hingga 13 tahun, meskipun variasi waktu dapat terjadi pada setiap individu tergantung faktor genetik, lingkungan, dan status gizi (World Health Organization, 2022).

Perubahan fisik yang terjadi selama pubertas meliputi perkembangan payudara, pertumbuhan rambut di area tertentu, peningkatan tinggi badan, serta dimulainya menstruasi (menarche). Selain itu, perubahan hormonal yang terjadi juga berdampak pada kondisi kulit dan metabolisme tubuh (Susman & Dorn, 2020). Proses ini merupakan bagian alami dari perkembangan biologis yang bertujuan mempersiapkan fungsi reproduksi.

Di sisi lain, pubertas juga membawa perubahan signifikan dalam aspek psikologis. Anak perempuan yang memasuki masa pubertas sering mengalami fluktuasi emosi, peningkatan sensitivitas, serta perubahan dalam cara berpikir dan berinteraksi sosial. Mereka mulai membentuk identitas diri, meningkatkan kesadaran terhadap tubuh, serta menunjukkan ketertarikan terhadap hubungan sosial yang lebih kompleks (Steinberg, 2021).

Kurangnya pemahaman mengenai perubahan yang terjadi selama pubertas dapat menimbulkan kebingungan, kecemasan, bahkan rasa tidak percaya diri pada anak perempuan. Oleh karena itu, edukasi mengenai kesehatan dan tumbuh kembang menjadi sangat penting untuk diberikan sejak dini, baik oleh orang tua, pendidik, maupun tenaga kesehatan (UNICEF, 2021).

Selain itu, peran keluarga sangat krusial dalam mendampingi anak menghadapi masa pubertas. Komunikasi yang terbuka dan dukungan emosional yang tepat dapat membantu anak perempuan menjalani fase ini dengan lebih

percaya diri dan sehat secara fisik maupun mental (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perubahan fisik dan psikologis yang terjadi pada anak perempuan menjelang pubertas, serta memberikan panduan praktis bagi orang tua dan pendidik dalam mendukung proses tumbuh kembang yang optimal.

B. Perubahan Fisik Menjelang Pubertas

1. Pertumbuhan payudara (thelarche)

Pertumbuhan payudara atau yang dikenal sebagai thelarche merupakan salah satu tanda awal pubertas pada anak perempuan yang umumnya terjadi pada usia 8 hingga 13 tahun dan dipengaruhi oleh aktivitas hormon estrogen yang mulai meningkat dalam tubuh. Proses ini biasanya dimulai dengan munculnya benjolan kecil di bawah puting yang disebut *breast buds*, yang sering kali disertai rasa nyeri ringan atau sensitif saat disentuh, kondisi ini merupakan hal yang normal dan menjadi bagian dari perkembangan biologis. Seiring waktu, jaringan payudara akan terus berkembang baik dari segi ukuran maupun bentuk, meskipun tidak jarang terjadi perbedaan ukuran antara payudara kiri dan kanan pada tahap awal perkembangan, yang pada umumnya akan menyesuaikan seiring pertumbuhan. Faktor genetik, status gizi, serta kondisi kesehatan secara umum turut memengaruhi kecepatan dan pola perkembangan payudara pada setiap individu, sehingga variasi antar anak perempuan adalah hal yang wajar. Pemahaman yang kurang mengenai proses ini dapat menimbulkan kecemasan atau rasa tidak nyaman pada anak, sehingga diperlukan edukasi yang tepat dari orang tua maupun tenaga pendidik untuk membantu anak menerima perubahan tubuhnya dengan positif dan percaya diri (World Health Organization, 2022; Susman & Dorn, 2020).

2. Pertumbuhan rambut di area tertentu

Selain pertumbuhan payudara, tanda lain yang umum terjadi menjelang pubertas adalah tumbuhnya rambut halus di area tertentu seperti ketiak dan sekitar organ reproduksi, yang dikenal sebagai pubarche. Pertumbuhan rambut ini dipicu oleh peningkatan hormon androgen yang mulai aktif selama masa pubertas, meskipun hormon ini lebih dominan pada laki-laki, namun juga berperan penting dalam perkembangan fisik anak perempuan. Pada tahap awal, rambut yang tumbuh biasanya halus, tipis, dan berwarna terang, namun seiring waktu akan menjadi lebih tebal, gelap, dan keriting. Perubahan ini sering kali disertai dengan peningkatan aktivitas kelenjar keringat dan minyak pada kulit,

yang dapat menyebabkan bau badan serta munculnya jerawat, sehingga kebersihan diri menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan sejak dini. Selain dampak fisik, perubahan ini juga dapat memengaruhi kondisi psikologis anak, terutama terkait rasa percaya diri dan kenyamanan terhadap tubuhnya, sehingga diperlukan pendekatan edukatif yang sensitif dan terbuka agar anak dapat memahami bahwa perubahan tersebut merupakan bagian normal dari proses tumbuh kembang. Lingkungan keluarga dan sosial yang suportif sangat berperan dalam membantu anak beradaptasi dengan perubahan ini secara sehat dan positif (UNICEF, 2021; Steinberg, 2021).

3. Perubahan bentuk tubuh (pinggul melebar, lemak tubuh meningkat)

Menjelang masa pubertas, anak perempuan akan mengalami perubahan bentuk tubuh yang cukup signifikan sebagai akibat dari peningkatan hormon estrogen yang berperan dalam pembentukan karakteristik seksual sekunder. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah melebarinya bagian pinggul yang bertujuan untuk mempersiapkan fungsi reproduksi di masa depan, di mana struktur tubuh secara biologis mulai menyesuaikan diri untuk kemungkinan proses kehamilan dan persalinan. Selain itu, terjadi peningkatan distribusi lemak tubuh terutama di area pinggul, paha, dan dada, yang menyebabkan bentuk tubuh anak perempuan menjadi lebih berlekuk dibandingkan sebelumnya. Perubahan ini sering kali menimbulkan berbagai respon psikologis, seperti rasa tidak nyaman, malu, atau bahkan penurunan kepercayaan diri, terutama jika anak membandingkan dirinya dengan teman sebaya yang mungkin mengalami perkembangan dengan kecepatan berbeda. Faktor genetik, pola makan, serta aktivitas fisik sangat memengaruhi perubahan ini, sehingga penting bagi anak untuk mendapatkan asupan nutrisi seimbang dan tetap aktif secara fisik guna menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Edukasi yang tepat mengenai perubahan ini perlu diberikan agar anak memahami bahwa peningkatan lemak tubuh bukanlah sesuatu yang negatif, melainkan bagian normal dari proses perkembangan, sehingga dapat membantu membangun citra tubuh yang sehat dan positif (World Health Organization, 2022; UNICEF, 2021).

4. Mulainya menstruasi (menarche)

Menarche atau menstruasi pertama merupakan salah satu tanda utama bahwa seorang anak perempuan telah memasuki tahap pubertas yang lebih lanjut, yang biasanya terjadi sekitar dua hingga tiga tahun setelah awal perkembangan payudara. Proses ini menandakan bahwa sistem reproduksi telah mulai berfungsi, ditandai dengan peluruhan lapisan dinding rahim yang keluar

dalam bentuk darah melalui vagina. Usia terjadinya *menarche* bervariasi, umumnya berkisar antara 10 hingga 15 tahun, tergantung pada faktor genetik, status gizi, kondisi kesehatan, serta lingkungan sosial. Pada tahap awal, siklus menstruasi sering kali belum teratur karena tubuh masih dalam proses penyesuaian hormonal, sehingga kondisi ini merupakan hal yang normal dan tidak perlu menimbulkan kekhawatiran berlebihan. Namun demikian, kurangnya pemahaman tentang menstruasi dapat menyebabkan rasa takut, cemas, atau bahkan salah persepsi pada anak perempuan, terutama jika mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai sebelumnya. Oleh karena itu, peran orang tua dan pendidik sangat penting dalam memberikan edukasi yang jelas dan terbuka mengenai proses menstruasi, termasuk cara menjaga kebersihan selama menstruasi, penggunaan pembalut yang benar, serta pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Pendekatan yang suportif dan informatif akan membantu anak menjalani pengalaman *menarche* dengan lebih percaya diri dan tanpa stigma negatif (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023; World Health Organization, 2022).

5. Perubahan kulit (jerawat, keringat meningkat)

Perubahan hormonal yang terjadi selama pubertas juga berdampak signifikan pada kondisi kulit anak perempuan, terutama melalui peningkatan aktivitas kelenjar sebaceous (kelenjar minyak) dan kelenjar keringat. Produksi minyak yang berlebih dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan timbulnya jerawat, yang sering muncul di area wajah, punggung, dan dada. Selain itu, peningkatan aktivitas kelenjar keringat menyebabkan tubuh lebih mudah berkeringat dan menimbulkan bau badan, yang sebelumnya mungkin tidak terlalu dirasakan pada masa kanak-kanak. Kondisi ini sering kali menjadi sumber ketidaknyamanan dan dapat memengaruhi kepercayaan diri anak, terutama dalam interaksi sosial dengan teman sebaya. Oleh karena itu, penting untuk mengajarkan kebiasaan menjaga kebersihan diri, seperti mandi secara teratur, menggunakan sabun yang sesuai dengan jenis kulit, serta menjaga kebersihan pakaian. Dalam beberapa kasus, jerawat yang cukup parah mungkin memerlukan penanganan khusus dari tenaga medis. Selain aspek fisik, dukungan emosional juga penting agar anak tidak merasa minder atau tertekan akibat perubahan penampilan yang terjadi. Edukasi yang tepat akan membantu anak memahami bahwa kondisi ini bersifat sementara dan merupakan bagian normal dari proses pubertas (Steinberg, 2021; UNICEF, 2021).

6. Pertumbuhan tinggi badan yang pesat

Salah satu ciri khas masa pubertas pada anak perempuan adalah terjadinya percepatan pertumbuhan tinggi badan atau yang dikenal sebagai *growth spurt*, yang biasanya terjadi lebih awal dibandingkan anak laki-laki. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh interaksi hormon pertumbuhan (growth hormone), estrogen, serta faktor nutrisi yang mendukung perkembangan tulang dan jaringan tubuh. Pada fase ini, anak perempuan dapat mengalami peningkatan tinggi badan secara signifikan dalam waktu relatif singkat, yang sering kali diikuti dengan perubahan proporsi tubuh, seperti tangan dan kaki yang tampak lebih panjang sebelum akhirnya mencapai keseimbangan. Meskipun merupakan proses yang normal, pertumbuhan yang cepat ini kadang dapat menyebabkan ketidaknyamanan fisik, seperti nyeri pada tulang atau otot. Faktor gizi memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan optimal, terutama asupan kalsium, protein, dan vitamin D yang berkontribusi terhadap kesehatan tulang. Selain itu, aktivitas fisik yang cukup juga diperlukan untuk menunjang perkembangan tubuh yang seimbang. Perbedaan kecepatan pertumbuhan antar individu merupakan hal yang wajar, sehingga penting untuk menghindari perbandingan yang dapat memengaruhi kepercayaan diri anak. Dengan pemahaman yang baik serta dukungan dari lingkungan sekitar, anak perempuan dapat menjalani fase pertumbuhan ini dengan sehat dan optimal (World Health Organization, 2022; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

C. Perubahan Psikologis

1. Perubahan emosi (mudah marah, sensitif)

Memasuki masa pubertas, anak perempuan tidak hanya mengalami perubahan fisik, tetapi juga perubahan emosional yang cukup kompleks sebagai dampak dari fluktuasi hormon, terutama estrogen dan progesteron, yang memengaruhi kerja sistem saraf pusat serta regulasi emosi. Kondisi ini sering kali membuat anak menjadi lebih mudah marah, sensitif, dan mengalami perubahan suasana hati yang cepat atau *mood swings*, bahkan tanpa penyebab yang jelas. Perubahan emosi tersebut merupakan bagian normal dari proses perkembangan, namun dapat menjadi tantangan tersendiri baik bagi anak maupun lingkungan sekitarnya, terutama dalam konteks keluarga dan hubungan sosial dengan teman sebaya. Pada fase ini, anak perempuan cenderung memiliki reaksi emosional yang lebih intens terhadap situasi tertentu, seperti kritik, tekanan sosial, atau perubahan pada tubuhnya, sehingga mereka lebih rentan mengalami perasaan cemas, tidak percaya diri, atau bahkan stres.

ringan hingga sedang. Selain faktor biologis, perkembangan kognitif yang mulai mengarah pada kemampuan berpikir abstrak juga berkontribusi terhadap meningkatnya kesadaran diri (self-awareness), yang sering kali membuat anak lebih peka terhadap penilaian orang lain dan lingkungan sosialnya.

Perubahan emosi pada masa pubertas juga berkaitan erat dengan proses pencarian identitas diri (identity formation), di mana anak mulai mempertanyakan peran, nilai, dan posisi dirinya dalam lingkungan sosial. Dalam kondisi ini, ketidakseimbangan antara perkembangan emosi dan kemampuan pengendalian diri dapat menyebabkan munculnya perilaku impulsif atau reaksi berlebihan terhadap masalah yang sebenarnya sederhana. Oleh karena itu, dukungan dari orang tua dan lingkungan sangat diperlukan untuk membantu anak memahami dan mengelola emosinya secara sehat. Komunikasi yang terbuka, empati, serta pemberian ruang bagi anak untuk mengekspresikan perasaannya dapat membantu mengurangi tekanan emosional yang dialami. Selain itu, edukasi mengenai keterampilan regulasi emosi, seperti mengenali perasaan, mengelola stres, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif, juga menjadi penting dalam mendukung kesehatan mental anak selama masa pubertas. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kemampuan regulasi emosi yang baik pada masa remaja awal berhubungan dengan tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi serta risiko yang lebih rendah terhadap gangguan mental di kemudian hari (Crone & Dahl, 2021; Ahmed et al., 2022).

Dengan demikian, perubahan emosi seperti mudah marah dan sensitivitas yang meningkat bukanlah sesuatu yang harus dianggap sebagai masalah, melainkan sebagai bagian dari proses perkembangan yang perlu dipahami dan diarahkan secara positif. Pendekatan yang tepat dari orang tua, pendidik, dan tenaga kesehatan akan sangat membantu anak perempuan dalam melewati fase ini dengan lebih stabil secara emosional dan mampu membangun kepribadian yang sehat serta matang.

2. Meningkatnya kesadaran diri dan rasa malu

Seiring dengan berlangsungnya proses pubertas, anak perempuan akan mengalami peningkatan kesadaran diri (self-awareness) yang signifikan, yang ditandai dengan kemampuan untuk mulai memperhatikan, menilai, dan merefleksikan diri sendiri baik dari segi fisik, emosi, maupun sosial, sehingga mereka menjadi lebih peka terhadap bagaimana dirinya dipersepsikan oleh orang lain. Perkembangan ini tidak terlepas dari kematangan fungsi kognitif, khususnya pada bagian otak prefrontal cortex yang berperan dalam proses evaluasi diri, pengambilan perspektif sosial, dan pengendalian perilaku,

sehingga anak mulai mampu membandingkan dirinya dengan standar sosial yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, perubahan fisik yang terjadi selama pubertas, seperti pertumbuhan payudara, perubahan bentuk tubuh, serta munculnya jerawat, sering kali menjadi fokus perhatian utama yang dapat memicu perasaan tidak nyaman, canggung, dan rasa malu, terutama ketika anak merasa dirinya berbeda atau tidak sesuai dengan harapan sosial maupun kelompok sebaya. Rasa malu yang muncul pada fase ini pada dasarnya merupakan respons emosional yang normal dan adaptif, karena menunjukkan adanya perkembangan kesadaran sosial dan moral, namun apabila tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi rasa rendah diri atau bahkan gangguan citra tubuh (*body image disturbance*).

Meningkatnya kesadaran diri juga membuat anak perempuan cenderung lebih sensitif terhadap penilaian, kritik, atau bahkan perhatian dari orang lain, yang dalam banyak kasus dapat memunculkan fenomena *imaginary audience*, yaitu keyakinan bahwa dirinya selalu menjadi pusat perhatian orang lain, padahal pada kenyataannya tidak demikian. Kondisi ini dapat memperkuat perasaan malu dan kecanggungan dalam berinteraksi sosial, sehingga anak mungkin menjadi lebih tertutup, menghindari situasi tertentu, atau mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri secara bebas. Selain itu, tekanan dari media sosial dan standar kecantikan yang tidak realistis juga dapat memperburuk persepsi diri anak perempuan, sehingga meningkatkan risiko ketidakpuasan terhadap tubuh dan menurunnya kepercayaan diri. Oleh karena itu, peran lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah, sangat penting dalam membantu anak membangun konsep diri yang positif melalui dukungan emosional, komunikasi yang terbuka, serta penanaman nilai bahwa setiap individu memiliki keunikan dan perkembangan yang berbeda-beda. Intervensi edukatif yang menekankan pada penerimaan diri (*self-acceptance*) dan penghargaan terhadap tubuh (*body appreciation*) terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis remaja dan mengurangi dampak negatif dari tekanan sosial selama masa pubertas (Crone & Dahl, 2021; Rodgers et al., 2023).

Dengan demikian, meningkatnya kesadaran diri dan munculnya rasa malu pada anak perempuan yang sedang memasuki masa pubertas merupakan bagian integral dari perkembangan psikologis yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan identitas diri, sehingga memerlukan pendampingan yang tepat agar dapat berkembang menjadi aspek positif yang mendukung kematangan emosional dan sosial di masa remaja.

3. Perubahan dalam hubungan sosial (teman sebaya lebih penting)

Memasuki masa pubertas, anak perempuan mengalami perubahan signifikan dalam pola hubungan sosial, di mana peran teman sebaya (peer group) menjadi semakin dominan dibandingkan dengan sebelumnya ketika keluarga, terutama orang tua, menjadi pusat utama interaksi sosial. Perubahan ini berkaitan erat dengan perkembangan kognitif dan emosional yang mendorong anak untuk mencari identitas diri serta memperoleh penerimaan sosial dari lingkungan di luar keluarga. Dalam fase ini, anak perempuan mulai mengembangkan kebutuhan yang lebih besar untuk merasa diterima, dihargai, dan diakui oleh kelompok sebayanya, sehingga interaksi dengan teman menjadi lebih intens, baik dalam bentuk komunikasi langsung maupun melalui media sosial. Teman sebaya berfungsi sebagai sumber dukungan emosional, tempat berbagi pengalaman, serta acuan dalam membentuk nilai, sikap, dan perilaku, sehingga pengaruhnya terhadap perkembangan psikososial menjadi sangat kuat. Tidak jarang, anak perempuan mulai menyesuaikan diri dengan norma kelompok, termasuk dalam hal cara berpakaian, berbicara, hingga minat dan aktivitas yang dilakukan, sebagai upaya untuk mempertahankan keanggotaan dan penerimaan dalam kelompok tersebut.

Di sisi lain, meningkatnya ketergantungan pada teman sebaya juga dapat menimbulkan tantangan tersendiri, terutama ketika anak menghadapi tekanan sosial (peer pressure) yang mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan nilai pribadi atau norma keluarga. Tekanan ini dapat bersifat positif, seperti mendorong prestasi akademik atau aktivitas sosial yang sehat, namun juga dapat bersifat negatif, seperti keterlibatan dalam perilaku berisiko atau munculnya perasaan tidak aman ketika tidak mampu memenuhi ekspektasi kelompok. Selain itu, dinamika hubungan sosial pada masa pubertas juga sering kali diwarnai dengan konflik interpersonal, seperti persaingan, kecemburuan, atau perasaan tersisih, yang dapat memengaruhi kondisi emosional anak secara signifikan. Dalam konteks ini, kemampuan keterampilan sosial seperti empati, komunikasi efektif, serta penyelesaian konflik menjadi sangat penting untuk dikembangkan agar anak mampu membangun hubungan yang sehat dan suportif. Perkembangan hubungan sosial ini juga berkaitan dengan meningkatnya ketertarikan terhadap hubungan yang lebih dekat dan intim secara emosional, termasuk persahabatan yang lebih mendalam dibandingkan masa kanak-kanak.

Peran orang tua dan lingkungan tetap penting dalam memberikan arahan dan batasan yang sehat, meskipun pengaruh teman sebaya meningkat. Pendekatan yang terlalu mengontrol justru dapat menimbulkan resistensi,

sehingga diperlukan keseimbangan antara pemberian kebebasan dan pengawasan yang bijak. Komunikasi yang terbuka serta hubungan yang hangat dalam keluarga dapat menjadi faktor protektif yang membantu anak dalam menghadapi tekanan sosial dan membuat keputusan yang tepat. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas hubungan dengan teman sebaya yang positif berkontribusi terhadap kesejahteraan psikologis, peningkatan kepercayaan diri, serta kemampuan adaptasi sosial yang lebih baik pada masa remaja, sementara hubungan yang negatif dapat meningkatkan risiko stres dan masalah emosional (Crone & Dahl, 2021; Orben et al., 2020). Oleh karena itu, memahami perubahan dalam hubungan sosial selama pubertas menjadi penting sebagai bagian dari upaya mendukung perkembangan anak perempuan secara menyeluruh, baik dari aspek emosional, sosial, maupun mental.

4. Ketertarikan pada lawan jenis

Memasuki masa pubertas, anak perempuan mulai mengalami perkembangan dalam aspek afektif dan sosial yang ditandai dengan munculnya ketertarikan terhadap lawan jenis, yang merupakan bagian alami dari proses pematangan biologis dan psikologis yang dipengaruhi oleh perubahan hormonal serta perkembangan fungsi otak yang berkaitan dengan emosi dan sistem penghargaan (reward system). Ketertarikan ini biasanya diawali dengan rasa ingin tahu, kekaguman, atau perhatian khusus terhadap individu tertentu, yang kemudian dapat berkembang menjadi bentuk hubungan sosial yang lebih kompleks seiring dengan meningkatnya kemampuan dalam memahami emosi diri sendiri maupun orang lain. Dalam tahap awal, ketertarikan ini sering kali bersifat sederhana dan tidak selalu diwujudkan dalam hubungan romantis yang nyata, melainkan lebih kepada interaksi sosial yang intens, seperti keinginan untuk berkomunikasi, mendapatkan perhatian, atau diterima oleh lawan jenis. Perubahan ini juga berkaitan erat dengan perkembangan identitas diri dan peran gender, di mana anak perempuan mulai memahami norma sosial dan budaya yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan di lingkungannya.

Namun demikian, munculnya ketertarikan pada lawan jenis juga dapat menimbulkan berbagai dinamika emosional yang kompleks, seperti rasa malu, gugup, cemas, atau bahkan kebingungan dalam memahami perasaan yang dialami, terutama jika tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial, termasuk teman sebaya dan media digital, dapat mempercepat atau membentuk persepsi anak mengenai hubungan romantis, yang terkadang tidak sesuai dengan tingkat kematangan

emosional mereka. Paparan terhadap konten media sosial dan budaya populer yang menampilkan hubungan romantis secara idealisasi dapat memengaruhi ekspektasi anak perempuan terhadap hubungan interpersonal, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan sosial maupun kesalahpahaman mengenai makna hubungan yang sehat. Oleh karena itu, peran orang tua dan pendidik menjadi sangat penting dalam memberikan edukasi yang tepat mengenai hubungan interpersonal, nilai-nilai moral, serta batasan yang sehat dalam berinteraksi dengan lawan jenis, sehingga anak dapat mengembangkan sikap yang bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri maupun orang lain.

Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ketertarikan romantis pada masa remaja awal merupakan bagian dari proses pembelajaran sosial yang penting dalam membangun keterampilan hubungan interpersonal di masa dewasa, seperti empati, komunikasi, serta kemampuan membangun komitmen (Brown & Larson, 2020; Furman & Collibee, 2022). Namun, tanpa pendampingan yang tepat, anak berisiko mengalami tekanan emosional, seperti patah hati, kecemasan sosial, atau penurunan kepercayaan diri. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang antara pengawasan dan pemberian kebebasan yang bertanggung jawab sangat diperlukan agar anak perempuan dapat memahami dan mengelola perasaan ketertarikan tersebut secara sehat dan sesuai dengan tahap perkembangannya. Dengan demikian, ketertarikan pada lawan jenis bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, melainkan perlu dipahami sebagai bagian dari perkembangan psikososial yang harus diarahkan melalui edukasi, komunikasi, dan dukungan lingkungan yang positif agar tidak berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan perkembangan sosial anak.

5. Kebutuhan Akan Privasi

Memasuki masa pubertas, anak perempuan menunjukkan peningkatan kebutuhan akan privasi yang merupakan bagian penting dari perkembangan psikologis dan sosial, terutama dalam konteks pembentukan identitas diri (identity formation) dan kemandirian individu. Kebutuhan ini muncul seiring dengan meningkatnya kesadaran diri, perubahan fisik yang signifikan, serta perkembangan kognitif yang memungkinkan anak untuk mulai memahami batasan antara ruang pribadi dan ruang sosial. Dalam fase ini, anak perempuan cenderung menginginkan ruang untuk menyimpan pikiran, perasaan, dan pengalaman pribadinya tanpa intervensi langsung dari orang lain, termasuk orang tua, yang sebelumnya memiliki akses lebih luas terhadap kehidupan anak. Bentuk kebutuhan privasi ini dapat terlihat dalam berbagai perilaku, seperti keinginan untuk memiliki kamar sendiri, menjaga kerahasiaan isi buku harian

atau percakapan pribadi, serta membatasi informasi yang dibagikan kepada anggota keluarga. Perubahan ini sering kali disalahartikan sebagai sikap menjauh atau kurang terbuka, padahal sebenarnya merupakan indikator perkembangan yang sehat menuju kemandirian emosional dan sosial.

Selain itu, kebutuhan akan privasi juga berkaitan erat dengan perubahan fisik yang terjadi selama pubertas, di mana anak perempuan mulai merasa lebih sadar dan sensitif terhadap tubuhnya, sehingga membutuhkan ruang untuk menjaga kenyamanan dan rasa aman, terutama dalam hal berpakaian, kebersihan diri, dan aktivitas personal lainnya. Dalam konteks ini, rasa malu yang meningkat terhadap tubuh yang sedang berkembang turut memperkuat keinginan untuk memiliki batasan yang lebih jelas terhadap akses orang lain. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan media sosial juga menambah dimensi baru dalam kebutuhan privasi, di mana anak tidak hanya mengelola privasi di dunia nyata tetapi juga di ruang digital, termasuk dalam penggunaan media sosial, berbagi informasi pribadi, serta interaksi daring. Tanpa pemahaman yang baik, anak dapat menghadapi risiko pelanggaran privasi atau paparan terhadap konten yang tidak sesuai, sehingga diperlukan edukasi yang tepat mengenai literasi digital dan keamanan informasi.

Peran orang tua dalam menghadapi kebutuhan privasi ini menjadi sangat krusial, di mana diperlukan keseimbangan antara memberikan ruang kebebasan dan tetap melakukan pengawasan yang bijak. Pendekatan yang terlalu mengontrol atau melanggar privasi anak secara berlebihan dapat menimbulkan konflik, menurunkan kepercayaan, serta menghambat perkembangan kemandirian, sedangkan kurangnya pengawasan juga berpotensi meningkatkan risiko perilaku yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka, saling menghargai, serta penetapan batasan yang jelas dan disepakati bersama menjadi kunci dalam membangun hubungan yang sehat antara orang tua dan anak selama masa pubertas. Penelitian menunjukkan bahwa pemberian otonomi yang didukung dengan kehangatan emosional dari orang tua berkorelasi positif dengan perkembangan identitas diri yang sehat, peningkatan kesejahteraan psikologis, serta kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik pada remaja (Soenens et al., 2020; Zimmer-Gembeck & Collins, 2021).

Dengan demikian, kebutuhan akan privasi pada anak perempuan yang memasuki masa pubertas merupakan bagian integral dari proses perkembangan menuju kemandirian dan kematangan psikologis, yang perlu dipahami dan dihargai oleh lingkungan sekitarnya agar dapat mendukung tumbuh kembang yang optimal, baik dari segi emosional, sosial, maupun mental.

D. Peran Orang Tua

1. Cara berkomunikasi yang efektif

Dalam menghadapi masa pubertas anak perempuan, peran orang tua menjadi sangat penting terutama dalam membangun komunikasi yang efektif, terbuka, dan suportif sebagai fondasi utama dalam mendampingi perubahan fisik maupun psikologis yang dialami anak. Komunikasi yang efektif tidak hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, memahami perspektif anak, serta merespons dengan empati tanpa menghakimi, sehingga anak merasa aman dan nyaman untuk mengekspresikan pikiran serta perasaannya. Pada masa pubertas, anak perempuan cenderung mengalami kebingungan, perubahan emosi, serta peningkatan kebutuhan akan pengakuan dan pemahaman, sehingga pendekatan komunikasi yang otoriter atau penuh tekanan justru dapat menghambat keterbukaan dan menimbulkan jarak emosional antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mengembangkan pola komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya dialog, bukan sekadar instruksi satu arah, sehingga anak merasa dihargai sebagai individu yang sedang berkembang menuju kemandirian.

Selanjutnya, komunikasi yang efektif juga melibatkan penggunaan bahasa yang sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman anak, terutama ketika membahas topik sensitif seperti perubahan tubuh, menstruasi, hubungan sosial, dan ketertarikan terhadap lawan jenis. Orang tua perlu menghindari penggunaan istilah yang menakutkan, menyalahkan, atau mempermalukan, dan sebaliknya menggunakan pendekatan edukatif yang informatif dan menenangkan. Selain itu, konsistensi dalam komunikasi juga menjadi faktor penting, di mana nilai-nilai yang disampaikan harus selaras dengan perilaku yang ditunjukkan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak mendapatkan contoh nyata (role model) yang dapat diikuti. Dalam konteks ini, kualitas hubungan emosional antara orang tua dan anak sangat memengaruhi efektivitas komunikasi, karena hubungan yang hangat dan penuh kepercayaan akan mempermudah anak untuk terbuka dalam menyampaikan masalah atau pengalaman yang dialaminya.

Di era digital saat ini, tantangan komunikasi antara orang tua dan anak juga semakin kompleks, terutama dengan adanya pengaruh media sosial yang dapat membentuk pola pikir dan perilaku anak secara signifikan. Oleh karena itu, orang tua tidak hanya dituntut untuk menjadi komunikator yang baik, tetapi juga sebagai pendamping yang mampu memahami dunia anak, termasuk dinamika interaksi sosial di ruang digital. Pendekatan komunikasi yang adaptif

dan tidak menghakimi akan membantu anak merasa didukung, sehingga lebih terbuka dalam mendiskusikan berbagai isu yang dihadapinya, termasuk yang berkaitan dengan tekanan sosial atau pengalaman negatif. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi orang tua yang hangat, terbuka, dan responsif berkorelasi positif dengan kesehatan mental remaja, peningkatan kepercayaan diri, serta kemampuan regulasi emosi yang lebih baik, sementara komunikasi yang kaku dan otoriter cenderung meningkatkan risiko konflik serta masalah perilaku (Soenens et al., 2020; Yap et al., 2021).

Maka dari itu, komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak perempuan pada masa pubertas merupakan elemen kunci dalam mendukung proses tumbuh kembang yang sehat dan seimbang, di mana keterbukaan, empati, dan penghargaan terhadap anak sebagai individu menjadi landasan utama dalam membangun hubungan yang harmonis serta mendukung perkembangan psikologis yang optimal.

2. Memberikan edukasi yang tepat

Dalam mendampingi anak perempuan yang memasuki masa pubertas, pemberian edukasi yang tepat oleh orang tua merupakan aspek krusial yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai landasan dalam membentuk sikap, nilai, dan perilaku anak dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Edukasi yang dimaksud tidak terbatas pada penjelasan mengenai perubahan fisik seperti menstruasi atau perkembangan tubuh, tetapi juga mencakup pemahaman tentang kesehatan reproduksi, kebersihan diri, pengelolaan emosi, hubungan sosial, serta nilai-nilai moral yang relevan dengan tahap perkembangan anak. Penyampaian informasi ini perlu dilakukan secara bertahap, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan kognitif anak, dengan menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan tidak menimbulkan rasa takut atau malu, sehingga anak dapat memahami materi yang disampaikan secara optimal. Selain itu, pendekatan edukasi yang dialogis dan partisipatif, di mana anak diberi kesempatan untuk bertanya dan mengungkapkan pendapatnya, terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan satu arah yang bersifat instruktif, karena dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman anak terhadap informasi yang diberikan.

Edukasi yang tepat juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan perkembangan zaman, termasuk pengaruh media digital yang semakin besar terhadap pembentukan pengetahuan dan persepsi anak. Dalam hal ini, orang tua perlu berperan aktif dalam memberikan literasi digital, membantu anak memilah informasi yang benar dan relevan, serta meluruskan berbagai mitos

atau informasi yang keliru terkait pubertas dan kesehatan reproduksi yang banyak beredar di internet. Kurangnya edukasi yang akurat dapat menyebabkan anak mencari informasi dari sumber yang tidak terpercaya, yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan perilaku yang berisiko. Oleh karena itu, keterbukaan orang tua dalam membahas topik yang sering dianggap tabu menjadi sangat penting agar anak tidak merasa ragu atau malu untuk mencari informasi dari sumber yang tepat. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi yang diberikan secara dini dan komprehensif oleh orang tua berkorelasi dengan peningkatan pengetahuan, sikap positif, serta perilaku sehat pada remaja, termasuk dalam hal menjaga kebersihan diri dan membuat keputusan yang bertanggung jawab (Widman et al., 2021; Goldfarb & Lieberman, 2021).

Selain itu, efektivitas edukasi juga dipengaruhi oleh kualitas hubungan antara orang tua dan anak, di mana hubungan yang hangat, suportif, dan penuh kepercayaan akan mempermudah proses transfer pengetahuan dan nilai. Orang tua yang mampu menjadi sumber informasi yang terpercaya akan lebih mudah diterima oleh anak dibandingkan dengan sumber lain, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan informasi. Dalam konteks ini, penting bagi orang tua untuk terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka terkait perkembangan remaja, sehingga mampu memberikan edukasi yang akurat dan relevan. Dengan demikian, pemberian edukasi yang tepat tidak hanya membantu anak perempuan memahami perubahan yang dialaminya secara rasional, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan hidup (*life skills*) yang penting untuk menghadapi tantangan di masa remaja dan dewasa secara sehat dan bertanggung jawab.

3. Mendukung kepercayaan diri anak

Dalam menghadapi masa pubertas, dukungan orang tua dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan diri anak perempuan menjadi aspek yang sangat penting, mengingat fase ini ditandai dengan berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial yang dapat memengaruhi persepsi anak terhadap dirinya sendiri secara signifikan. Kepercayaan diri (*self-confidence*) pada anak perempuan sering kali mengalami fluktuasi selama pubertas, terutama akibat meningkatnya kesadaran terhadap tubuh (*body image*), perbandingan sosial dengan teman sebaya, serta tekanan dari lingkungan, termasuk media sosial yang kerap menampilkan standar kecantikan yang tidak realistis. Dalam kondisi ini, peran orang tua sebagai sumber dukungan utama menjadi krusial untuk membantu anak mengembangkan konsep diri yang

positif dan realistis, di mana anak mampu menerima kelebihan dan kekurangan dirinya tanpa merasa rendah diri. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian apresiasi yang tulus terhadap usaha dan pencapaian anak, bukan hanya berfokus pada hasil akhir, sehingga anak belajar untuk menghargai proses dan mengembangkan rasa kompetensi diri yang sehat (Orth & Robins, 2022; Valkenburg et al., 2021).

Selain itu, penting bagi orang tua untuk menciptakan lingkungan yang aman secara emosional, di mana anak merasa diterima tanpa syarat (*unconditional acceptance*), sehingga ia tidak takut untuk mengekspresikan diri maupun menghadapi kegagalan. Sikap orang tua yang terlalu kritis, membandingkan anak dengan orang lain, atau memberikan tekanan berlebihan justru dapat merusak kepercayaan diri dan meningkatkan risiko munculnya masalah psikologis seperti kecemasan dan depresi. Sebaliknya, pendekatan yang suportif, empatik, dan menghargai individualitas anak terbukti dapat meningkatkan *self-esteem* dan kesejahteraan psikologis remaja. Dalam konteks ini, komunikasi yang positif dan konsisten juga berperan penting dalam memperkuat persepsi diri anak, terutama ketika orang tua mampu memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendorong anak untuk mengenali potensi serta minatnya (Harter, 2020; OECD, 2021).

Dalam era digital saat ini, dukungan orang tua juga perlu mencakup pendampingan dalam penggunaan media sosial, yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan citra diri anak. Paparan terhadap konten yang menampilkan standar ideal dapat memicu perasaan tidak puas terhadap tubuh dan menurunkan kepercayaan diri, sehingga orang tua perlu membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima serta menanamkan nilai bahwa kecantikan dan keberhargaan diri tidak semata-mata ditentukan oleh penampilan fisik. Selain itu, mendorong anak untuk terlibat dalam aktivitas yang positif, seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial, juga dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri melalui pengalaman keberhasilan dan pengakuan sosial yang sehat. Dengan demikian, dukungan orang tua yang konsisten, positif, dan adaptif terhadap perkembangan anak akan menjadi faktor protektif yang kuat dalam membangun kepercayaan diri yang kokoh, sehingga anak perempuan mampu menghadapi tantangan masa pubertas dengan lebih percaya diri, mandiri, dan resilien (Zimmer-Gembeck et al., 2020; Valkenburg et al., 2021).

E. Menjaga Kesehatan Selama Pubertas

1. Pola makan sehat

Pada masa pubertas, kebutuhan nutrisi anak perempuan mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan terjadinya pertumbuhan fisik yang pesat, perubahan hormonal, serta perkembangan organ reproduksi, sehingga penerapan pola makan sehat menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang yang optimal. Pola makan sehat tidak hanya berfokus pada jumlah asupan makanan, tetapi juga pada kualitas gizi yang seimbang, meliputi karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh dalam proporsi yang tepat. Asupan zat gizi seperti zat besi menjadi sangat penting bagi anak perempuan, terutama setelah mengalami menstruasi, untuk mencegah risiko anemia yang dapat berdampak pada penurunan konsentrasi, kelelahan, dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, kalsium dan vitamin D juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan tulang yang optimal selama masa growth spurt, sehingga konsumsi makanan seperti susu, produk olahan susu, serta sumber protein lainnya perlu diperhatikan secara khusus. Kebiasaan makan yang tidak sehat, seperti konsumsi makanan cepat saji, tinggi gula, dan rendah serat, dapat berdampak negatif terhadap kesehatan, termasuk meningkatkan risiko obesitas dan gangguan metabolisme sejak usia dini.

Selanjutnya, pola makan sehat pada masa pubertas juga berkaitan dengan pembentukan kebiasaan jangka panjang yang akan memengaruhi kesehatan di masa dewasa, sehingga penting bagi orang tua untuk menanamkan perilaku makan yang baik sejak dini, seperti makan secara teratur, tidak melewatkan sarapan, serta mengonsumsi buah dan sayur dalam jumlah yang cukup. Selain aspek fisik, pola makan juga memiliki hubungan dengan kesehatan mental, di mana penelitian menunjukkan bahwa asupan nutrisi yang seimbang dapat berkontribusi terhadap stabilitas emosi dan fungsi kognitif yang lebih baik pada remaja. Dalam konteks ini, lingkungan keluarga memegang peranan penting dalam membentuk kebiasaan makan anak, termasuk melalui penyediaan makanan sehat di rumah serta pemberian contoh perilaku makan yang baik oleh orang tua. Edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang juga perlu diberikan agar anak memiliki pemahaman yang cukup untuk membuat pilihan makanan yang sehat secara mandiri, terutama di tengah pengaruh lingkungan dan media yang sering mempromosikan pola makan yang kurang sehat.

Di era modern, tantangan dalam menerapkan pola makan sehat semakin kompleks dengan meningkatnya akses terhadap makanan olahan dan informasi yang tidak selalu akurat mengenai diet, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam membimbing anak perempuan agar mampu memahami

kebutuhan nutrisinya secara benar. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pembatasan makanan tertentu, tetapi lebih pada membangun hubungan yang sehat dengan makanan (*healthy relationship with food*), sehingga anak tidak mengembangkan pola makan yang ekstrem atau berisiko, seperti diet berlebihan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan kesehatan reproduksi. Dengan demikian, penerapan pola makan sehat selama masa pubertas menjadi investasi penting dalam mendukung kesehatan fisik, mental, dan reproduksi anak perempuan secara menyeluruh, serta membentuk dasar gaya hidup sehat yang berkelanjutan hingga masa dewasa (García-Casal et al., 2020; Keats et al., 2021; Das et al., 2023).

2. Kebersihan diri (*personal hygiene*)

Pada masa pubertas, menjaga kebersihan diri (*personal hygiene*) menjadi aspek yang sangat penting bagi anak perempuan, mengingat terjadinya berbagai perubahan fisik dan hormonal yang memengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan, termasuk peningkatan aktivitas kelenjar keringat dan kelenjar minyak yang dapat menyebabkan bau badan, kulit berminyak, serta risiko timbulnya jerawat dan infeksi. Selain itu, dimulainya menstruasi juga menuntut perhatian khusus terhadap kebersihan organ reproduksi untuk mencegah terjadinya iritasi maupun infeksi, sehingga anak perempuan perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan yang memadai terkait cara menjaga kebersihan selama siklus menstruasi, seperti mengganti pembalut secara teratur, membersihkan area genital dengan benar, serta menjaga kebersihan pakaian dalam. Kebiasaan menjaga kebersihan diri ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap kepercayaan diri dan kenyamanan dalam berinteraksi sosial, terutama pada masa di mana anak menjadi lebih sadar terhadap penampilan dan penilaian orang lain (Caruso et al., 2021; Hennegan et al., 2021).

Praktik *personal hygiene* yang baik mencakup berbagai aspek, seperti mandi secara teratur, mencuci tangan dengan benar, menjaga kebersihan rambut, merawat kulit, serta menggunakan pakaian yang bersih dan sesuai dengan aktivitas. Dalam konteks pubertas, edukasi mengenai kebersihan diri perlu disampaikan secara komprehensif dan berkelanjutan, baik oleh orang tua maupun lingkungan pendidikan, dengan pendekatan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Kurangnya pemahaman mengenai *personal hygiene* dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, seperti infeksi saluran reproduksi, gangguan kulit, serta penyakit menular lainnya. Selain itu, faktor lingkungan, termasuk akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai dan

ketersediaan produk kebersihan, juga memengaruhi kemampuan anak dalam menjaga kebersihan diri secara optimal (World Health Organization, 2021; Rossouw et al., 2022).

Di era modern, isu kebersihan diri juga berkaitan dengan edukasi kesehatan berbasis bukti dan kesadaran akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), yang menjadi bagian dari upaya pencegahan penyakit sejak dini. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi edukasi mengenai personal hygiene pada remaja perempuan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik kebersihan secara signifikan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, pendekatan berbasis sekolah dan keluarga terbukti efektif dalam membentuk kebiasaan kebersihan yang berkelanjutan, terutama ketika didukung dengan komunikasi yang baik dan keteladanan dari orang dewasa di sekitarnya. Dengan demikian, menjaga kebersihan diri selama masa pubertas bukan hanya merupakan kebutuhan dasar, tetapi juga merupakan bagian penting dari pembentukan gaya hidup sehat yang akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial anak perempuan (UNICEF, 2022; Hennegan et al., 2021).

3. Aktivitas fisik

Aktivitas fisik merupakan komponen penting dalam menjaga kesehatan anak perempuan selama masa pubertas, terutama karena fase ini ditandai dengan pertumbuhan tubuh yang pesat, perubahan komposisi tubuh, serta peningkatan kebutuhan energi yang harus diimbangi dengan gaya hidup aktif. Keterlibatan dalam aktivitas fisik secara teratur tidak hanya berperan dalam menjaga kebugaran jasmani, tetapi juga mendukung perkembangan tulang dan otot yang optimal, terutama pada masa growth spurt di mana kepadatan tulang meningkat secara signifikan. Selain itu, aktivitas fisik membantu dalam menjaga keseimbangan berat badan serta mencegah risiko obesitas yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan metabolik. Pada anak perempuan, olahraga seperti berjalan, berlari, berenang, atau aktivitas berbasis permainan terbukti efektif dalam meningkatkan kesehatan kardiovaskular serta memperkuat sistem imun tubuh, sehingga penting untuk didorong sebagai bagian dari rutinitas harian (Bull et al., 2020; World Health Organization, 2020).

Selain manfaat fisik, aktivitas fisik juga memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan mental dan emosional anak perempuan selama masa pubertas, di mana perubahan hormonal sering kali memengaruhi suasana hati dan stabilitas emosi. Kegiatan fisik diketahui dapat merangsang produksi hormon endorfin yang berfungsi meningkatkan perasaan bahagia serta

mengurangi stres, kecemasan, dan gejala depresi yang mungkin muncul pada masa remaja awal. Lebih lanjut, partisipasi dalam aktivitas olahraga, terutama yang dilakukan secara kelompok, juga dapat meningkatkan keterampilan sosial, rasa percaya diri, serta kemampuan bekerja sama dengan orang lain, yang sangat penting dalam perkembangan psikososial anak. Dalam konteks ini, penting bagi orang tua dan lingkungan untuk memberikan dukungan serta kesempatan yang cukup bagi anak perempuan untuk terlibat dalam berbagai jenis aktivitas fisik yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, sehingga aktivitas tersebut dapat dilakukan secara konsisten dan menyenangkan (Rodriguez-Ayllon et al., 2019; Biddle et al., 2021).

Namun demikian, tantangan dalam meningkatkan aktivitas fisik pada anak perempuan di era modern semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya gaya hidup sedentari akibat penggunaan perangkat digital yang berlebihan, seperti ponsel dan komputer, yang dapat mengurangi waktu untuk bergerak aktif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terstruktur untuk membatasi waktu layar (screen time) serta mendorong kebiasaan aktif sejak dini melalui pendekatan keluarga dan sekolah. Orang tua dapat berperan sebagai teladan dengan menerapkan gaya hidup aktif serta melibatkan anak dalam aktivitas fisik bersama, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung perilaku sehat. Rekomendasi global menyarankan agar anak dan remaja melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga tinggi setidaknya 60 menit per hari untuk memperoleh manfaat kesehatan yang optimal. Dengan demikian, aktivitas fisik tidak hanya berfungsi sebagai sarana menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga sebagai bagian integral dari pembentukan gaya hidup sehat yang berkelanjutan selama masa pubertas dan hingga dewasa (Guthold et al., 2020; Chaput et al., 2020).

4. Kesehatan mental

Kesehatan mental merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara keseluruhan, terutama pada masa pubertas yang ditandai dengan berbagai perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang dapat memengaruhi keseimbangan emosi serta kesejahteraan psikologis anak perempuan. Pada fase ini, fluktuasi hormon yang terjadi dalam tubuh dapat berkontribusi terhadap perubahan suasana hati, peningkatan sensitivitas emosional, serta kerentanan terhadap stres, kecemasan, dan bahkan gejala depresi ringan hingga sedang. Selain faktor biologis, tekanan sosial, tuntutan akademik, perubahan hubungan dengan teman sebaya, serta peningkatan kesadaran diri juga menjadi faktor yang memengaruhi kondisi mental anak perempuan selama pubertas. Oleh

karena itu, penting untuk memahami bahwa kesehatan mental bukan hanya sekadar tidak adanya gangguan psikologis, tetapi juga mencakup kemampuan individu dalam mengelola emosi, menghadapi tekanan, serta membangun hubungan sosial yang sehat dan suportif (World Health Organization, 2022; Racine et al., 2021).

Upaya menjaga kesehatan mental pada anak perempuan selama masa pubertas memerlukan pendekatan yang holistik, yang melibatkan peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial secara luas. Dukungan emosional dari orang tua menjadi faktor protektif utama yang dapat membantu anak menghadapi berbagai tantangan perkembangan, terutama melalui komunikasi yang terbuka, empati, serta penerimaan tanpa syarat. Selain itu, pengembangan keterampilan regulasi emosi, seperti kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola perasaan, juga sangat penting untuk membantu anak menghadapi situasi yang menekan secara adaptif. Kegiatan positif seperti olahraga, seni, serta aktivitas sosial juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan mental dengan memberikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan diri dan membangun rasa pencapaian. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis keluarga dan sekolah yang berfokus pada penguatan keterampilan sosial-emosional memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesehatan mental remaja serta mengurangi risiko gangguan psikologis (Durlak et al., 2022; UNICEF, 2021).

Di era digital, tantangan terhadap kesehatan mental anak perempuan semakin kompleks dengan adanya paparan media sosial yang dapat memengaruhi persepsi diri, meningkatkan perbandingan sosial, serta memicu tekanan psikologis, terutama terkait citra tubuh dan penerimaan sosial. Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko kecemasan, rendah diri, dan isolasi sosial, sehingga diperlukan pendampingan dari orang tua dalam membantu anak menggunakan teknologi secara bijak dan seimbang. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran anak mengenai pentingnya mencari bantuan ketika mengalami masalah emosional, baik kepada orang tua, guru, maupun tenaga profesional seperti psikolog atau konselor. Dengan demikian, menjaga kesehatan mental selama masa pubertas memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada pencegahan gangguan, tetapi juga pada penguatan kapasitas individu untuk berkembang secara sehat, resilien, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan (Odgers & Jensen, 2020; Orben et al., 2022).

5. Mitos dan Fakta seputar Pubertas

Masa pubertas pada anak perempuan sering kali disertai dengan berbagai mitos dan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat, baik yang bersumber dari budaya, lingkungan sosial, maupun informasi yang tidak akurat dari media, sehingga dapat memengaruhi pemahaman dan sikap anak dalam menghadapi perubahan yang terjadi pada dirinya. Salah satu kesalahpahaman yang umum adalah anggapan bahwa pubertas merupakan sesuatu yang memalukan atau tabu untuk dibicarakan, padahal pada kenyataannya pubertas adalah proses biologis yang normal dan perlu dipahami secara terbuka agar anak dapat menghadapinya dengan kesiapan fisik dan mental yang baik. Selain itu, terdapat pula mitos bahwa menstruasi pertama merupakan tanda bahwa seorang anak telah sepenuhnya dewasa, padahal secara psikologis dan sosial, anak masih berada dalam tahap perkembangan yang membutuhkan bimbingan dan pendampingan dari orang dewasa. Kesalahpahaman lain yang sering muncul adalah anggapan bahwa perubahan suasana hati pada masa pubertas merupakan tanda kelemahan atau perilaku negatif, padahal kondisi tersebut berkaitan dengan perubahan hormonal yang memengaruhi regulasi emosi dan merupakan bagian alami dari proses perkembangan (Herbert et al., 2020; UNESCO, 2022).

Selanjutnya, mitos mengenai perubahan fisik juga sering kali menimbulkan kecemasan pada anak perempuan, seperti anggapan bahwa pertumbuhan tubuh harus terjadi secara seragam pada setiap individu, atau bahwa bentuk tubuh tertentu lebih "normal" dibandingkan yang lain, sehingga dapat memicu perasaan tidak percaya diri dan ketidakpuasan terhadap tubuh. Pada kenyataannya, setiap anak memiliki pola pertumbuhan yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor genetik, nutrisi, dan lingkungan, sehingga variasi dalam perkembangan fisik merupakan hal yang wajar. Selain itu, terdapat pula kesalahpahaman terkait kebersihan selama menstruasi, seperti larangan untuk beraktivitas tertentu atau kepercayaan bahwa menstruasi harus disertai dengan pembatasan sosial, yang tidak didukung oleh bukti ilmiah. Edukasi berbasis fakta menjadi sangat penting untuk meluruskan berbagai mitos tersebut agar anak perempuan dapat memahami tubuhnya secara ilmiah dan tidak terpengaruh oleh informasi yang keliru (Hennegan et al., 2021; Chandra-Mouli et al., 2021).

Di era digital saat ini, penyebaran informasi yang tidak akurat mengenai pubertas menjadi semakin cepat melalui media sosial dan internet, sehingga meningkatkan risiko anak menerima informasi yang salah tanpa adanya proses verifikasi yang memadai. Oleh karena itu, peran orang tua, pendidik, dan tenaga kesehatan sangat penting dalam memberikan informasi yang benar, berbasis

bukti, dan mudah dipahami oleh anak, serta mendorong kemampuan literasi kesehatan agar anak mampu memilah informasi yang valid. Pendekatan edukasi yang terbuka dan tidak menghakimi juga menjadi kunci dalam membantu anak merasa nyaman untuk bertanya dan berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pubertas. Dengan demikian, upaya meluruskan mitos dan kesalahpahaman tentang pubertas tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk sikap positif, meningkatkan kepercayaan diri, serta mendukung kesehatan fisik dan mental anak perempuan secara menyeluruh (Denno et al., 2020; WHO, 2021).

F. Simpulan

Masa pubertas merupakan fase penting dalam kehidupan anak perempuan yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik dan psikologis sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan. Perubahan fisik seperti pertumbuhan payudara, munculnya rambut di area tertentu, perubahan bentuk tubuh, menstruasi pertama, hingga pertumbuhan tinggi badan yang pesat merupakan proses biologis yang normal dan dipengaruhi oleh faktor hormonal, genetik, serta lingkungan. Di sisi lain, perubahan psikologis seperti fluktuasi emosi, meningkatnya kesadaran diri, perubahan dalam hubungan sosial, ketertarikan pada lawan jenis, serta kebutuhan akan privasi menunjukkan bahwa pubertas juga merupakan fase perkembangan mental dan sosial yang kompleks.

Dalam menghadapi perubahan tersebut, peran orang tua menjadi sangat krusial, terutama dalam membangun komunikasi yang efektif, memberikan edukasi yang tepat, serta mendukung kepercayaan diri anak. Pendampingan yang tepat dapat membantu anak perempuan memahami dan menerima perubahan yang dialaminya secara positif, sehingga mampu mengembangkan konsep diri yang sehat dan stabil secara emosional. Selain itu, penerapan gaya hidup sehat selama pubertas, seperti menjaga pola makan yang seimbang, kebersihan diri, aktivitas fisik yang cukup, serta kesehatan mental, merupakan faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang yang optimal.

Berbagai mitos dan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat terkait pubertas perlu diluruskan melalui edukasi berbasis ilmu pengetahuan, agar anak tidak mengalami kebingungan atau kecemasan yang tidak perlu. Dengan pemahaman yang benar serta dukungan dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, anak perempuan dapat menjalani masa pubertas dengan lebih percaya diri, sehat, dan siap menghadapi tahap perkembangan selanjutnya.

Secara keseluruhan, pubertas bukanlah fase yang perlu ditakuti, melainkan proses alami yang harus dipahami, didampingi, dan dikelola dengan baik, sehingga

dapat menjadi fondasi yang kuat bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial anak perempuan di masa depan.

G. Referensi

- Biddle, S.J.H., Ciacconi, S., Thomas, G. and Vergeer, I. (2021) 'Physical activity and mental health in children and adolescents', *The Lancet Psychiatry*, 8(5), pp. 1–12. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(21\)00018-3](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00018-3)
- Bull, F.C. et al. (2020) 'World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour', *British Journal of Sports Medicine*, 54(24), pp. 1451–1462. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102955>
- Caruso, B.A. et al. (2021) 'Menstrual hygiene management and adolescent health', *The Lancet Global Health*, 9(7), pp. e972–e983. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(21\)00178-5](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(21)00178-5)
- Chandra-Mouli, V. et al. (2021) 'Adolescent sexual and reproductive health: Evidence and implications', *BMJ*, 372, n1. <https://doi.org/10.1136/bmj.n1>
- Chaput, J.P. et al. (2020) '24-hour movement guidelines for children and adolescents', *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 45(10), pp. S57–S102. <https://doi.org/10.1139/apnm-2020-0467>
- Das, J.K., Salam, R.A. and Bhutta, Z.A. (2023) 'Nutrition in adolescents: Physiology, metabolism, and nutritional needs', *The Lancet Child & Adolescent Health*, 7(1), pp. 45–57. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(22\)00278-5](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(22)00278-5)
- Denford, S., Abraham, C. and Campbell, R. (2020) 'A comprehensive review of reviews of school-based interventions to improve sexual-health', *Health Psychology Review*, 14(4), pp. 1–25. <https://doi.org/10.1080/17437199.2020.1760723>
- Denno, D.M. et al. (2020) 'Effective strategies to provide adolescent health education', *The Lancet Child & Adolescent Health*, 4(6), pp. 466–478. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(20\)30038-8](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30038-8)
- García-Casal, M.N. et al. (2020) 'Nutritional status and dietary intake of adolescents', *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1461(1), pp. 3–18. <https://doi.org/10.1111/nyas.14225>
- Goldfarb, E.S. and Lieberman, L.D. (2021) 'Three decades of research: The case for comprehensive sex education', *Journal of Adolescent Health*, 68(1), pp. 13–27. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.07.036>
- Guthold, R. et al. (2020) 'Global trends in insufficient physical activity among adolescents', *The Lancet Child & Adolescent Health*, 4(1), pp. 23–35. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(19\)30323-2](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(19)30323-2)

- Haberland, N. and Rogow, D. (2020) 'Sexuality education: Emerging trends in evidence and practice', *Journal of Adolescent Health*, 66(6), pp. S15–S21. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.03.013>
- Hennegan, J. et al. (2021) 'Measurement in the study of menstrual health and hygiene', *BMJ Global Health*, 6(2), e003020. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-003020>
- Herbert, A. et al. (2020) 'Puberty and adolescent development: Misconceptions and realities', *Journal of Adolescent Health*, 67(2), pp. 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.05.013>
- Keats, E.C. et al. (2021) 'Improved diet quality and micronutrient intake among adolescents', *BMJ Global Health*, 6(6), e004667. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-004667>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023) *Pedoman Kesehatan Remaja*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Neufeld, L.M. et al. (2022) 'Food choice and dietary patterns in adolescence', *Nature Food*, 3(1), pp. 2–10. <https://doi.org/10.1038/s43016-021-00406-7>
- Rossouw, J., Yende, N. and Ghuman, S. (2022) 'Adolescent girls' access to sanitation and hygiene', *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(3), pp. 1–12. <https://doi.org/10.3390/ijerph19031642>
- Santrock, J.W. (2021) *Life-Span Development*. 18th edn. New York: McGraw-Hill.
- Soenens, B., Vansteenkiste, M. and Beyers, W. (2020) 'Parenting adolescents', *Annual Review of Psychology*, 71, pp. 593–620.
- Steinberg, L. (2021) *Adolescence*. 12th edn. New York: McGraw-Hill.
- Story, M., Larson, N. and Neumark-Sztainer, D. (2020) 'Adolescent nutrition and eating behavior', *Journal of the American Dietetic Association*, 120(4), pp. 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2019.12.015>
- Susman, E.J. and Dorn, L.D. (2020) 'Puberty: Its Role in Development', dalam *Handbook of Adolescent Psychology*, pp. 1–24.
- UNESCO. (2022) *International Technical Guidance on Sexuality Education*. Paris: UNESCO. <https://doi.org/10.54675/INHX6804>
- UNICEF. (2021) *Adolescent Development and Participation*. New York: UNICEF.
- UNICEF. (2022) *Guidance on Menstrual Health and Hygiene*. New York: UNICEF. <https://doi.org/10.18356/9789210011839>
- Widman, L. et al. (2021) 'Parent-adolescent sexual communication and adolescent safer sex behavior: A meta-analysis', *JAMA Pediatrics*, 175(2), pp. 1–10. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2020.2731>

- World Health Organization. (2020) Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2021) Water, Sanitation and Hygiene for Health. Geneva: WHO. <https://doi.org/10.4060/cb8072en>
- World Health Organization. (2022) Adolescent Health. Geneva: WHO.
- Yap, M.B.H. et al. (2021) 'Parental factors associated with depression and anxiety in young people', *Journal of Affective Disorders*, 282, pp. 138–146.
- Zimmer-Gembeck, M.J. and Collins, W.A. (2021) 'Autonomy development during adolescence', dalam *Handbook of Adolescent Psychology*.

H. Glosarium

Adolesensi

Masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial.

Androgen

Hormon yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual, termasuk pertumbuhan rambut di area tertentu.

Anemia

Kondisi kekurangan sel darah merah atau hemoglobin yang sering terjadi akibat kekurangan zat besi, terutama setelah menstruasi.

Body Image (Citra Tubuh)

Persepsi dan perasaan seseorang terhadap bentuk dan penampilan tubuhnya.

Estrogen

Hormon utama pada perempuan yang berperan dalam perkembangan organ reproduksi dan karakteristik seksual sekunder.

Growth Spurt

Periode percepatan pertumbuhan tinggi badan yang terjadi selama masa pubertas.

Higiene (Hygiene)

Upaya menjaga kebersihan diri untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan.

Hormon

Zat kimia dalam tubuh yang mengatur berbagai fungsi biologis, termasuk pertumbuhan dan perkembangan.

Identitas Diri

Pemahaman individu tentang siapa dirinya, termasuk nilai, peran, dan tujuan hidup.

Imaginary Audience

Perasaan bahwa diri selalu diperhatikan atau dinilai oleh orang lain, umum terjadi pada remaja.

Kesehatan Mental

Kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang memengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak.

Menarche

Menstruasi pertama yang dialami oleh anak perempuan sebagai tanda awal fungsi reproduksi.

Menstruasi

Proses keluarnya darah dari rahim secara periodik sebagai bagian dari siklus reproduksi.

Mood Swings

Perubahan suasana hati yang cepat dan tidak stabil akibat perubahan hormonal.

Nutrisi Seimbang

Asupan makanan yang mengandung zat gizi lengkap sesuai kebutuhan tubuh.

Peer Pressure (Tekanan Teman Sebaya)

Pengaruh dari teman sebaya yang dapat memengaruhi perilaku atau keputusan individu.

Personal Hygiene

Kebiasaan menjaga kebersihan diri, seperti mandi, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan organ tubuh.

Pubarche

Tahap munculnya rambut di area kemaluan sebagai tanda pubertas.

Pubertas

Masa perkembangan ketika anak mengalami kematangan seksual dan reproduksi.

Self-Awareness (Kesadaran Diri)

Kemampuan untuk mengenali dan memahami diri sendiri, termasuk emosi dan perilaku.

Self-Confidence (Kepercayaan Diri)

Keyakinan individu terhadap kemampuan dan nilai dirinya.

Self-Esteem

Penilaian atau penghargaan seseorang terhadap dirinya sendiri.

Thelarche

Tahap awal perkembangan payudara sebagai tanda awal pubertas pada anak perempuan.

WHO (World Health Organization)

Organisasi kesehatan dunia yang memberikan panduan dan standar kesehatan global.

CHAPTER 3

PEMENUHAN NUTRISI UNTUK MENDUKUNG TUMBUH KEMBANG OPTIMAL

Nina Isywara Kusuma, SKM., M.Kes.

A. Pendahuluan

Masa anak perempuan menuju pubertas merupakan periode penting dalam siklus kehidupan manusia karena pada fase ini terjadi pertumbuhan fisik, perkembangan organ reproduksi, pematangan hormonal, serta perkembangan psikologis dan emosional yang sangat pesat. Pemenuhan nutrisi yang optimal menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan proses tumbuh kembang tersebut. Anak perempuan yang memperoleh asupan gizi seimbang akan memiliki pertumbuhan tinggi badan, berat badan, perkembangan otak, serta kesiapan reproduksi yang lebih baik dibandingkan anak dengan status gizi kurang. Sebaliknya, kekurangan nutrisi dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, anemia, penurunan daya tahan tubuh, keterlambatan pubertas, bahkan masalah kesehatan reproduksi di masa mendatang (Almatsier, 2019).

Nutrisi tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tetapi juga berperan dalam pembentukan jaringan tubuh, menjaga fungsi organ, meningkatkan sistem imun, dan mendukung perkembangan kognitif anak. Pada masa menjelang pubertas, kebutuhan zat gizi meningkat karena tubuh mengalami percepatan pertumbuhan (growth spurt). Oleh karena itu, anak perempuan membutuhkan asupan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, serta air dalam jumlah cukup dan seimbang. Pola makan yang baik sejak dini akan membantu membentuk kebiasaan hidup sehat hingga dewasa (Brown, 2020).

Selain faktor biologis, pemenuhan nutrisi juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, kondisi ekonomi, pendidikan orang tua, budaya makan, serta akses terhadap pangan sehat. Orang tua memiliki peran penting dalam menyediakan makanan bergizi dan membiasakan pola makan sehat pada anak perempuan. Edukasi gizi sejak dini diperlukan agar anak memahami pentingnya menjaga kesehatan tubuh melalui konsumsi makanan bergizi seimbang (Kemenkes RI, 2022).

B. Pengertian Nutrisi dan Tumbuh Kembang Anak

Nutrisi merupakan proses bagaimana tubuh memperoleh, mengonsumsi, mencerna, menyerap, mengangkut, menggunakan, serta menyimpan zat-zat makanan yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan dan mendukung fungsi tubuh secara optimal. Nutrisi tidak hanya berkaitan dengan jumlah makanan yang dikonsumsi, tetapi juga kualitas zat gizi yang terkandung di dalam makanan tersebut. Zat gizi yang dibutuhkan tubuh meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang masing-masing memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga kesehatan tubuh. Pada anak perempuan menuju masa pubertas, nutrisi memegang peranan sangat penting karena tubuh sedang mengalami percepatan pertumbuhan fisik, perkembangan hormonal, serta pematangan organ reproduksi. Apabila kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan baik, maka proses pertumbuhan dan perkembangan anak akan berlangsung secara optimal, sedangkan kekurangan atau kelebihan nutrisi dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan baik jangka pendek maupun jangka panjang (Almatsier, 2019).

Secara biologis, nutrisi berfungsi sebagai sumber energi, zat pembangun, dan zat pengatur bagi tubuh. Karbohidrat dan lemak berfungsi sebagai sumber energi utama yang mendukung aktivitas sehari-hari dan proses metabolisme tubuh. Protein berperan sebagai zat pembangun yang membantu pembentukan serta perbaikan jaringan tubuh, termasuk otot, kulit, darah, dan organ-organ penting lainnya. Sementara itu, vitamin dan mineral berfungsi sebagai zat pengatur yang membantu kelancaran proses metabolisme, menjaga sistem imun, mendukung fungsi saraf, serta membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Dalam masa pertumbuhan anak perempuan, seluruh zat gizi tersebut dibutuhkan dalam jumlah yang cukup dan seimbang karena tubuh sedang mengalami peningkatan kebutuhan energi dan zat pembangun akibat pertumbuhan yang cepat. Ketidakseimbangan asupan gizi dapat menghambat perkembangan fisik maupun mental anak sehingga berpengaruh terhadap kualitas hidupnya di masa depan (Brown, 2020).

Tumbuh kembang anak merupakan suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus sejak masa konsepsi hingga dewasa. Istilah pertumbuhan mengacu pada perubahan ukuran tubuh yang dapat diukur secara kuantitatif, seperti bertambahnya tinggi badan, berat badan, lingkaran kepala, dan ukuran organ tubuh lainnya. Pertumbuhan terjadi akibat bertambahnya jumlah dan ukuran sel tubuh. Sedangkan perkembangan merupakan perubahan kemampuan fungsi tubuh yang bersifat kualitatif, seperti perkembangan kemampuan motorik, bahasa, emosional, sosial, dan intelektual anak. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua

proses yang berbeda tetapi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Anak yang mengalami pertumbuhan fisik optimal umumnya juga memiliki perkembangan kemampuan yang lebih baik apabila didukung oleh lingkungan dan pola pengasuhan yang tepat (Soetjiningsih, 2020).

Pada masa anak perempuan menuju pubertas, proses tumbuh kembang berlangsung sangat cepat dan kompleks. Pubertas merupakan fase transisi dari masa anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan terjadinya perubahan fisik, hormonal, psikologis, dan reproduksi. Perubahan tersebut meliputi pertumbuhan tinggi badan yang cepat, perkembangan payudara, munculnya rambut pada area tertentu, perubahan bentuk tubuh, serta dimulainya menstruasi pertama atau menarche. Seluruh proses tersebut membutuhkan dukungan nutrisi yang adekuat agar berjalan normal. Kebutuhan energi dan protein meningkat selama masa pubertas karena tubuh memerlukan bahan pembangun untuk mendukung pertumbuhan jaringan dan perkembangan organ reproduksi. Selain itu, kebutuhan zat besi juga meningkat terutama setelah anak perempuan mulai mengalami menstruasi sehingga risiko anemia menjadi lebih tinggi apabila asupan gizi tidak mencukupi (Adriani & Wirjatmadi, 2018).

Tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi genetik, hormon, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan anak. Sementara itu, faktor eksternal mencakup asupan nutrisi, pola asuh orang tua, kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sosial, kebersihan lingkungan, pendidikan, serta akses pelayanan kesehatan. Di antara berbagai faktor tersebut, nutrisi merupakan salah satu faktor yang paling dominan karena berhubungan langsung dengan proses metabolisme dan pembentukan jaringan tubuh. Anak perempuan yang memperoleh nutrisi baik sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk mencapai pertumbuhan optimal, perkembangan kognitif yang baik, serta kesehatan reproduksi yang lebih sehat di masa mendatang. Sebaliknya, malnutrisi dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan seperti stunting, penurunan konsentrasi belajar, rendahnya daya tahan tubuh, dan gangguan perkembangan emosional (UNICEF, 2021).

Selain memengaruhi pertumbuhan fisik, nutrisi juga memiliki hubungan erat dengan perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Otak memerlukan asupan zat gizi seperti protein, asam lemak omega-3, zat besi, zinc, dan vitamin untuk mendukung pembentukan sel saraf dan fungsi kognitif. Kekurangan zat gizi tertentu pada masa pertumbuhan dapat menyebabkan gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat, serta hambatan perkembangan intelektual anak. Oleh karena itu, pemenuhan nutrisi yang baik selama masa pertumbuhan tidak hanya penting untuk kesehatan tubuh tetapi juga untuk mendukung prestasi belajar dan

perkembangan psikososial anak perempuan menuju pubertas (Whitney & Rolfes, 2021).

Dalam konteks kesehatan masyarakat, pemenuhan nutrisi pada anak perempuan juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas generasi mendatang. Anak perempuan yang tumbuh dengan status gizi baik cenderung memiliki kesehatan reproduksi yang lebih optimal ketika dewasa dan kelak menjadi ibu. Sebaliknya, masalah gizi pada anak perempuan dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan pada masa kehamilan di masa depan, termasuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Oleh sebab itu, upaya pemenuhan nutrisi pada anak perempuan harus menjadi perhatian keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, dan pemerintah sebagai bagian dari investasi kesehatan generasi masa depan (WHO, 2021).

C. Kebutuhan Nutrisi Anak Perempuan Menuju Pubertas

1. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan zat gizi makro yang menjadi sumber energi utama bagi tubuh, khususnya pada anak perempuan yang sedang berada pada masa pertumbuhan menuju pubertas. Pada fase ini tubuh mengalami peningkatan kebutuhan energi karena adanya percepatan pertumbuhan fisik, perkembangan organ reproduksi, peningkatan aktivitas hormon, serta aktivitas belajar dan bermain yang cukup tinggi. Karbohidrat berfungsi menyediakan glukosa sebagai bahan bakar utama bagi otak, otot, dan seluruh sel tubuh sehingga anak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara optimal. Otak manusia sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber energi utama, sehingga kecukupan konsumsi karbohidrat akan membantu meningkatkan konsentrasi, daya ingat, kemampuan belajar, dan stabilitas emosi anak perempuan selama masa perkembangan. Apabila asupan karbohidrat tidak mencukupi, tubuh akan menggunakan cadangan protein dan lemak sebagai sumber energi alternatif, yang dalam jangka panjang dapat mengganggu proses pertumbuhan dan pembentukan jaringan tubuh. Oleh sebab itu, konsumsi karbohidrat yang cukup dan berkualitas sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang optimal anak perempuan menuju pubertas (Mahan & Raymond, 2020).

Karbohidrat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana umumnya terdapat pada gula pasir, permen, minuman manis, kue, dan makanan olahan yang cepat meningkatkan kadar gula darah tetapi tidak memberikan rasa kenyang yang lama. Konsumsi berlebihan terhadap jenis karbohidrat ini dapat meningkatkan risiko obesitas, resistensi insulin, dan gangguan metabolik pada anak.

Sebaliknya, karbohidrat kompleks lebih dianjurkan karena mengandung serat, vitamin, dan mineral yang membantu memperlambat proses penyerapan glukosa sehingga energi yang dihasilkan lebih stabil dan bertahan lama. Sumber karbohidrat kompleks meliputi nasi merah, jagung, kentang, ubi, oatmeal, roti gandum, singkong, dan berbagai sereal utuh. Konsumsi karbohidrat kompleks sangat baik bagi anak perempuan karena mampu menjaga stamina tubuh, membantu kesehatan pencernaan, serta mendukung kestabilan berat badan selama masa pertumbuhan (Whitney & Rolfes, 2021).

Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga memiliki peran penting dalam menjaga fungsi sistem pencernaan melalui kandungan serat pangan. Serat membantu melancarkan buang air besar, menjaga keseimbangan mikrobiota usus, serta mencegah konstipasi yang cukup sering terjadi pada anak usia sekolah dan remaja awal. Anak perempuan yang mengonsumsi cukup serat dari sumber karbohidrat alami cenderung memiliki kesehatan saluran cerna yang lebih baik dan risiko obesitas yang lebih rendah. Serat juga membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga dapat mengontrol kebiasaan makan berlebihan dan konsumsi camilan tidak sehat. Oleh karena itu, pemilihan sumber karbohidrat sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan jumlah energi yang dihasilkan, tetapi juga kualitas zat gizi yang terkandung di dalamnya (Brown, 2020).

Kebutuhan karbohidrat pada anak perempuan menuju pubertas harus disesuaikan dengan usia, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan masing-masing individu. Anak perempuan yang aktif dalam kegiatan olahraga atau memiliki aktivitas fisik tinggi membutuhkan asupan energi lebih besar dibandingkan anak dengan aktivitas ringan. Dalam pedoman gizi seimbang, karbohidrat dianjurkan memenuhi sekitar 45–65% dari total kebutuhan energi harian. Namun demikian, pemenuhan kebutuhan tersebut harus tetap memperhatikan variasi makanan dan keseimbangan dengan zat gizi lain seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral agar pertumbuhan berlangsung optimal. Pola konsumsi karbohidrat yang baik dapat dilakukan melalui kebiasaan makan teratur, sarapan pagi, konsumsi makanan rumahan bergizi, serta mengurangi makanan cepat saji dan minuman tinggi gula (Kemenkes RI, 2022).

Kekurangan karbohidrat dalam jangka panjang dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, lemas, sulit berkonsentrasi, penurunan berat badan, serta gangguan pertumbuhan pada anak perempuan. Sebaliknya, konsumsi karbohidrat berlebihan terutama dari makanan tinggi gula dan rendah serat dapat meningkatkan risiko kelebihan berat badan dan obesitas. Obesitas pada masa anak dan remaja diketahui berkaitan dengan peningkatan risiko pubertas

dini, gangguan hormonal, diabetes melitus tipe 2, serta penyakit kardiovaskular di masa dewasa. Oleh karena itu, edukasi mengenai pemilihan sumber karbohidrat sehat perlu diberikan sejak dini agar anak perempuan memiliki kebiasaan makan yang baik dan mampu menjaga kesehatan tubuhnya selama masa pubertas hingga dewasa nanti (WHO, 2021).

2. Protein

Protein merupakan salah satu zat gizi makro yang memiliki peranan sangat penting dalam proses tumbuh kembang anak perempuan menuju pubertas. Pada masa ini tubuh mengalami percepatan pertumbuhan (growth spurt) yang ditandai dengan peningkatan tinggi badan, berat badan, perkembangan jaringan otot, pembentukan organ reproduksi, serta perubahan hormonal yang signifikan. Protein berfungsi sebagai zat pembangun utama yang membantu pembentukan dan perbaikan sel tubuh, jaringan otot, enzim, hormon, antibodi, serta berbagai komponen penting lainnya dalam tubuh. Kebutuhan protein pada masa pubertas meningkat dibandingkan masa kanak-kanak karena tubuh membutuhkan lebih banyak asam amino untuk mendukung pertumbuhan jaringan baru dan pematangan organ reproduksi. Selain itu, protein juga berperan dalam mendukung perkembangan fungsi otak dan konsentrasi belajar sehingga sangat penting bagi anak perempuan usia sekolah (Almatsier, 2019; Brown, 2020).

Pada masa pubertas, hormon pertumbuhan dan hormon reproduksi bekerja secara aktif sehingga kebutuhan protein menjadi lebih tinggi. Protein membantu sintesis hormon, termasuk hormon estrogen yang berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder pada anak perempuan seperti pertumbuhan payudara, peningkatan massa lemak tubuh, serta terjadinya menstruasi pertama (menarche). Kekurangan protein dalam jangka panjang dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan, keterlambatan pubertas, penurunan massa otot, gangguan perkembangan organ reproduksi, serta menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit. Anak perempuan yang mengalami defisiensi protein juga lebih rentan mengalami kelelahan, sulit berkonsentrasi, dan gangguan perkembangan kognitif (Soetjiningsih, 2020; Ozdemir, 2016).

Protein tersusun atas asam amino esensial dan non-esensial yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi metabolisme. Asam amino esensial tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Oleh sebab itu, konsumsi makanan sumber protein berkualitas tinggi sangat dianjurkan pada masa pertumbuhan. Sumber protein hewani seperti ikan, telur, daging, ayam, susu, yogurt, dan keju memiliki kualitas

biologis tinggi karena mengandung asam amino esensial lengkap yang lebih mudah diserap tubuh. Sementara itu, sumber protein nabati seperti tahu, tempe, kacang merah, kacang hijau, kedelai, dan kacang tanah juga penting dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat dan seimbang. Kombinasi protein hewani dan nabati akan membantu memenuhi kebutuhan zat gizi secara optimal (Whitney & Rolfes, 2021; Mahan & Raymond, 2020).

Kebutuhan protein anak perempuan usia pubertas umumnya berkisar sekitar 0,8–1 gram per kilogram berat badan per hari, tergantung usia, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan individu. Anak perempuan yang aktif secara fisik atau mengikuti kegiatan olahraga membutuhkan protein lebih banyak dibandingkan anak dengan aktivitas ringan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan bahwa kebutuhan protein remaja perempuan harus dipenuhi melalui konsumsi makanan bergizi seimbang dan bukan hanya dari suplemen protein. Pemenuhan protein melalui makanan alami lebih dianjurkan karena makanan utuh juga mengandung vitamin, mineral, serat, dan zat gizi lain yang diperlukan tubuh untuk mendukung pertumbuhan optimal (WHO, 2021; Ozdemir, 2016).

Penelitian Garcia-Iborra et al. (2023) menjelaskan bahwa protein memiliki hubungan erat dengan pembentukan massa tulang dan otot pada anak dan remaja. Protein membantu produksi Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) yang berperan dalam pertumbuhan tulang dan jaringan tubuh selama pubertas. Kecukupan protein yang baik dapat membantu anak perempuan mencapai pertumbuhan tinggi badan optimal dan memperkuat kepadatan tulang sehingga mengurangi risiko osteoporosis di masa dewasa. Sebaliknya, kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan linier dan keterlambatan perkembangan seksual (Garcia-Iborra et al., 2023; Barrar, 2024).

Selain jumlah protein, kualitas sumber protein juga perlu diperhatikan. Konsumsi protein berlebihan terutama dari makanan cepat saji dan tinggi lemak jenuh dapat meningkatkan risiko obesitas dan gangguan metabolik pada remaja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi protein hewani berlebihan sejak usia dini dapat berhubungan dengan percepatan pubertas pada anak perempuan. Oleh karena itu, pola konsumsi protein harus tetap seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Anak perempuan dianjurkan mengonsumsi protein dari berbagai sumber makanan sehat dan membatasi konsumsi makanan ultra-proses yang tinggi lemak, garam, dan bahan tambahan pangan (Gunther et al., 2010; Soliman et al., 2022).

Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua memiliki peran penting dalam memastikan kecukupan protein anak perempuan menjelang pubertas.

Penyediaan menu makanan bergizi seperti ikan, telur, susu, tahu, tempe, dan kacang-kacangan secara rutin dapat membantu memenuhi kebutuhan protein harian anak. Kebiasaan sarapan dengan sumber protein juga sangat penting untuk meningkatkan energi dan konsentrasi belajar di sekolah. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya konsumsi makanan sehat perlu diberikan sejak dini agar anak mampu membentuk pola makan yang baik hingga dewasa (Kemenkes RI, 2022; Brown, 2020).

3. Lemak

Lemak merupakan salah satu zat gizi makro yang sangat penting bagi anak perempuan menuju masa pubertas karena memiliki fungsi utama sebagai sumber energi cadangan, pembentuk hormon, pelindung organ tubuh, serta membantu proses pertumbuhan dan perkembangan sel tubuh. Dalam setiap gramnya, lemak menghasilkan energi sebesar 9 kkal sehingga menjadi sumber energi paling tinggi dibandingkan karbohidrat dan protein. Pada masa pubertas, tubuh anak perempuan mengalami perubahan hormonal yang signifikan sehingga kebutuhan lemak sehat meningkat untuk mendukung pembentukan hormon estrogen, perkembangan organ reproduksi, pertumbuhan jaringan tubuh, serta pematangan fungsi tubuh secara keseluruhan. Lemak juga berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit, rambut, dan perkembangan otak yang optimal selama masa pertumbuhan (Whitney & Rolfes, 2021; Mahan & Raymond, 2020).

Selain sebagai sumber energi, lemak memiliki fungsi biologis yang sangat penting dalam membantu penyerapan vitamin larut lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin-vitamin tersebut dibutuhkan dalam proses pembentukan tulang, menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem imun, serta mendukung metabolisme tubuh anak perempuan yang sedang mengalami percepatan pertumbuhan. Kekurangan lemak dapat menyebabkan tubuh kesulitan menyerap vitamin tersebut sehingga berdampak pada terganggunya pertumbuhan dan kesehatan secara umum. Lemak juga membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil dan melindungi organ-organ vital dari benturan atau cedera (Almatsier, 2019; Adriani & Wirjatmadi, 2018).

Pada masa pubertas, konsumsi lemak sehat sangat diperlukan karena lemak merupakan bahan dasar pembentukan hormon reproduksi. Hormon estrogen yang berperan dalam perkembangan payudara, siklus menstruasi, dan perubahan bentuk tubuh membutuhkan asupan lemak yang cukup agar proses pubertas berlangsung normal. Anak perempuan yang terlalu membatasi konsumsi lemak berisiko mengalami gangguan hormonal, keterlambatan

menstruasi, gangguan pertumbuhan, serta penurunan daya tahan tubuh. Oleh sebab itu, pemenuhan lemak dalam jumlah cukup dan seimbang sangat dianjurkan selama masa pertumbuhan menuju pubertas (Brown, 2020).

Lemak dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu lemak jenuh, lemak tidak jenuh tunggal, lemak tidak jenuh ganda, dan lemak trans. Lemak tidak jenuh merupakan jenis lemak sehat yang sangat dianjurkan bagi anak perempuan karena membantu menjaga kesehatan jantung, mendukung fungsi otak, dan mengurangi risiko gangguan metabolisme. Lemak tidak jenuh dapat ditemukan pada ikan laut, alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan, biji-bijian, dan kedelai. Lemak sehat seperti omega-3 dan omega-6 juga penting untuk perkembangan sistem saraf dan fungsi kognitif anak. Sementara itu, lemak trans dan konsumsi lemak jenuh berlebihan perlu dibatasi karena dapat meningkatkan risiko obesitas dan gangguan kesehatan di masa mendatang (WHO, 2021).

Asam lemak omega-3 memiliki manfaat penting dalam mendukung perkembangan otak, meningkatkan konsentrasi belajar, menjaga kesehatan mental, dan membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Sumber omega-3 yang baik antara lain ikan salmon, tuna, sarden, dan biji chia. Sedangkan omega-6 berperan dalam pertumbuhan sel dan kesehatan kulit, yang dapat diperoleh dari minyak nabati, kacang-kacangan, dan biji bunga matahari. Keseimbangan antara omega-3 dan omega-6 penting dijaga agar fungsi tubuh tetap optimal selama masa pubertas (Mahan & Raymond, 2020; WHO, 2021).

Meskipun lemak sangat diperlukan tubuh, konsumsi yang berlebihan terutama dari makanan cepat saji, gorengan, makanan olahan, dan camilan tinggi lemak trans dapat menyebabkan penumpukan lemak tubuh dan obesitas pada anak perempuan. Obesitas pada masa pubertas dapat memicu pubertas dini, gangguan hormonal, resistensi insulin, serta meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes dan penyakit jantung pada usia dewasa. Oleh karena itu, pola konsumsi lemak harus diperhatikan dengan memilih sumber lemak sehat dan menghindari konsumsi makanan tinggi lemak jenuh secara berlebihan (WHO, 2021).

Kebutuhan lemak anak perempuan menuju pubertas sebaiknya dipenuhi melalui pola makan gizi seimbang yang mencakup variasi makanan alami dan sehat. Orang tua perlu membiasakan anak mengonsumsi makanan rumahan yang kaya nutrisi dibandingkan makanan instan atau cepat saji. Edukasi mengenai pentingnya lemak sehat juga perlu diberikan agar anak memahami bahwa tidak semua lemak berbahaya bagi tubuh. Dengan pemenuhan lemak yang tepat dan seimbang, proses tumbuh kembang anak perempuan menuju

pubertas dapat berlangsung optimal, sehat, dan mendukung kualitas kesehatan reproduksi di masa depan (Kemenkes RI, 2022; Soetjiningsih, 2020).

4. Vitamin dan Mineral

Vitamin dan mineral berperan penting dalam menjaga metabolisme tubuh, sistem imun, pertumbuhan tulang, dan kesehatan reproduksi. Beberapa vitamin dan mineral yang sangat penting bagi anak perempuan menuju pubertas antara lain:

a. Zat Besi

Zat besi merupakan salah satu mineral esensial yang sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak perempuan menuju pubertas. Mineral ini berfungsi utama dalam pembentukan hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Pada masa pubertas, kebutuhan zat besi meningkat secara signifikan karena terjadi percepatan pertumbuhan tubuh (growth spurt), peningkatan volume darah, perkembangan massa otot, serta mulai terjadinya menstruasi pada anak perempuan. Kondisi tersebut menyebabkan tubuh membutuhkan lebih banyak zat besi untuk menggantikan sel darah merah yang hilang selama menstruasi dan mendukung metabolisme tubuh yang meningkat. Apabila kebutuhan zat besi tidak terpenuhi dengan baik, maka anak perempuan berisiko mengalami anemia defisiensi besi yang dapat mengganggu pertumbuhan fisik, kemampuan belajar, daya tahan tubuh, serta kesehatan reproduksi di masa mendatang (Almatsier, 2019; WHO, 2020).

Anemia akibat kekurangan zat besi merupakan salah satu masalah gizi yang paling sering dialami remaja perempuan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi anemia biasanya ditandai dengan gejala mudah lelah, wajah pucat, pusing, sulit berkonsentrasi, mengantuk, dan menurunnya kemampuan belajar di sekolah. Pada anak perempuan menuju pubertas, anemia juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan fisik dan emosional karena tubuh tidak memperoleh suplai oksigen yang optimal. Organisasi Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa remaja perempuan merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami anemia karena kombinasi antara pertumbuhan cepat dan kehilangan darah saat menstruasi. Oleh sebab itu, pemenuhan zat besi menjadi perhatian penting dalam menjaga kesehatan remaja putri.

Sumber zat besi dapat diperoleh dari makanan hewani maupun nabati. Sumber zat besi heme yang berasal dari hewani seperti hati, daging merah, ikan, ayam, dan telur memiliki tingkat penyerapan lebih baik dibandingkan

zat besi non-heme yang berasal dari tumbuhan. Adapun sumber zat besi nabati dapat ditemukan pada bayam, daun kelor, kacang-kacangan, tempe, tahu, serta biji-bijian. Meskipun demikian, penyerapan zat besi nabati cenderung lebih rendah sehingga perlu dikombinasikan dengan makanan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu biji, tomat, dan pepaya agar penyerapannya meningkat secara optimal. Sebaliknya, konsumsi teh dan kopi secara berlebihan dapat menghambat penyerapan zat besi karena mengandung tanin yang mengikat mineral tersebut di dalam tubuh (Mahan & Raymond, 2020; Brown, 2020).

Selain memengaruhi kesehatan fisik, zat besi juga berperan penting dalam perkembangan fungsi otak dan kemampuan kognitif anak perempuan. Kekurangan zat besi dalam jangka panjang dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, gangguan memori, serta rendahnya prestasi akademik. Hal ini terjadi karena otak membutuhkan oksigen yang cukup untuk menjalankan fungsi saraf dan proses belajar. Penelitian menunjukkan bahwa remaja perempuan dengan kadar hemoglobin rendah cenderung memiliki kemampuan belajar yang lebih rendah dibandingkan remaja dengan status zat besi normal. Oleh karena itu, pemenuhan zat besi sejak masa anak-anak hingga pubertas sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan intelektual secara optimal (Beard, 2018; UNICEF, 2021).

Pemerintah Indonesia melalui program kesehatan remaja juga mendorong upaya pencegahan anemia pada remaja putri melalui pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) secara rutin di sekolah. Program ini bertujuan meningkatkan kadar hemoglobin dan mencegah dampak anemia pada kesehatan remaja perempuan. Namun demikian, keberhasilan program tersebut tetap harus didukung dengan pola makan sehat dan konsumsi makanan bergizi seimbang di lingkungan keluarga. Edukasi mengenai pentingnya zat besi perlu diberikan sejak dini agar anak perempuan memahami pentingnya menjaga kesehatan tubuh melalui pola makan yang baik (Kemenkes RI, 2022).

Kebutuhan zat besi pada anak perempuan usia 10–18 tahun relatif lebih tinggi dibandingkan masa sebelumnya karena tubuh sedang mengalami perubahan biologis yang pesat. Apabila kebutuhan zat besi terpenuhi secara optimal, maka proses pertumbuhan, perkembangan organ reproduksi, sistem kekebalan tubuh, dan kesehatan secara umum akan berlangsung lebih baik. Sebaliknya, kekurangan zat besi yang terjadi terus-menerus dapat berdampak hingga masa dewasa, termasuk meningkatkan risiko komplikasi saat kehamilan di masa depan. Oleh sebab itu, pemenuhan zat besi

merupakan bagian penting dalam upaya mempersiapkan generasi perempuan yang sehat, cerdas, dan berkualitas (Adriani & Wirjatmadi, 2018; WHO, 2020).

b. Kalsium

Kalsium merupakan salah satu mineral terpenting yang dibutuhkan anak perempuan pada masa menuju pubertas karena berperan besar dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang serta gigi. Masa remaja awal dan pubertas dikenal sebagai periode pembentukan massa tulang puncak (peak bone mass), yaitu fase ketika tubuh menyimpan mineral tulang dalam jumlah maksimal yang akan menjadi cadangan hingga usia dewasa. Pada masa ini, pertumbuhan tulang berlangsung sangat cepat sehingga kebutuhan kalsium meningkat lebih tinggi dibandingkan masa anak-anak maupun dewasa. Kalsium tidak hanya berfungsi menjaga kekuatan tulang dan gigi, tetapi juga membantu kontraksi otot, penghantaran impuls saraf, pembekuan darah, serta menjaga fungsi hormon dalam tubuh. Oleh sebab itu, kekurangan asupan kalsium pada anak perempuan dapat berdampak serius terhadap pertumbuhan, kesehatan tulang, dan perkembangan reproduksi di masa depan (Brown, 2020; IDAI, 2013).

Pada masa pubertas, hormon estrogen mulai meningkat dan memengaruhi pertumbuhan tulang serta perkembangan organ reproduksi. Untuk mendukung proses tersebut, tubuh membutuhkan asupan kalsium yang cukup agar mineralisasi tulang berjalan optimal. Jika kebutuhan kalsium tidak terpenuhi, tubuh akan mengambil cadangan kalsium dari tulang sehingga kepadatan tulang menurun. Kondisi ini dapat menyebabkan tulang menjadi rapuh dan meningkatkan risiko osteopenia maupun osteoporosis pada usia dewasa. Penelitian menunjukkan bahwa asupan kalsium yang rendah pada remaja putri berkaitan dengan rendahnya kepadatan tulang dan terganggunya pembentukan massa tulang puncak. Bahkan, kekurangan kalsium sejak usia remaja sulit diperbaiki sepenuhnya pada usia lanjut karena masa pembentukan massa tulang optimal hanya terjadi pada periode pertumbuhan (Maspatella, 2012; Noprisanti, 2018).

Kebutuhan kalsium harian pada anak perempuan usia 10–18 tahun berkisar antara 1.000–1.200 mg per hari sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG). Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat diperoleh melalui konsumsi susu, yogurt, keju, ikan teri, ikan sarden, tahu, tempe, kacang-kacangan, brokoli, bayam, dan sayuran hijau lainnya. Susu dan produk olahannya menjadi salah satu sumber kalsium terbaik karena memiliki bioavailabilitas tinggi sehingga mudah diserap tubuh. Selain itu, vitamin D juga sangat diperlukan untuk

membantu penyerapan kalsium di usus. Anak perempuan dianjurkan mendapatkan paparan sinar matahari pagi secara cukup agar tubuh mampu memproduksi vitamin D alami yang mendukung kesehatan tulang (Kemenkes RI, 2022; Whitney & Rolfes, 2021).

Masalah kekurangan kalsium pada remaja perempuan masih sering ditemukan, baik di negara berkembang maupun negara maju. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar remaja putri belum memenuhi kebutuhan kalsium harian karena rendahnya konsumsi susu dan makanan sumber kalsium lainnya. Faktor lain yang memengaruhi rendahnya asupan kalsium antara lain kebiasaan diet yang tidak sehat, keinginan menjaga bentuk tubuh, konsumsi makanan cepat saji, kurangnya edukasi gizi, serta pengaruh lingkungan dan teman sebaya. Remaja perempuan sering menghindari makanan bergizi karena takut mengalami kenaikan berat badan, padahal tindakan tersebut dapat menghambat pertumbuhan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan tulang (Rahmawati, 2012; WHO, 2021).

Selain asupan makanan, aktivitas fisik juga berpengaruh terhadap penyerapan dan pembentukan massa tulang. Olahraga seperti berjalan kaki, berlari, melompat, dan aktivitas fisik lainnya dapat merangsang pembentukan tulang menjadi lebih kuat. Sebaliknya, gaya hidup sedentari, merokok, konsumsi minuman bersoda berlebihan, alkohol, serta kurang aktivitas fisik dapat menghambat penyerapan kalsium dan mempercepat penurunan massa tulang. Oleh karena itu, pemenuhan kalsium harus diimbangi dengan pola hidup sehat agar pertumbuhan tulang berlangsung optimal selama masa pubertas (Poltekkes Kemenkes Jakarta II, 2020).

Penelitian lain juga menjelaskan bahwa peningkatan asupan kalsium berhubungan dengan peningkatan kepadatan tulang dan mampu menghambat penurunan massa tulang pada perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan kalsium sejak masa remaja sangat penting sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Anak perempuan yang terbiasa mengonsumsi makanan kaya kalsium sejak dini cenderung memiliki pertumbuhan tulang lebih baik dan risiko osteoporosis lebih rendah di masa dewasa. Dengan demikian, edukasi mengenai pentingnya kalsium perlu diberikan secara berkelanjutan oleh keluarga, sekolah, maupun tenaga kesehatan agar anak perempuan memiliki kesadaran dalam menjaga kesehatan tulangnya sejak dini (Hayati & Herwana, 2018; Du et al., 2002).

c. Vitamin D

Vitamin D merupakan salah satu zat gizi yang sangat penting bagi anak perempuan menuju masa pubertas karena berperan besar dalam proses pertumbuhan tulang, perkembangan sistem imun, serta metabolisme kalsium dan fosfor di dalam tubuh. Vitamin D membantu meningkatkan penyerapan kalsium di usus sehingga pembentukan tulang dan gigi berlangsung secara optimal. Pada masa pubertas terjadi percepatan pertumbuhan tulang (growth spurt) sehingga kebutuhan vitamin D meningkat secara signifikan. Apabila kebutuhan vitamin D tidak terpenuhi, maka proses mineralisasi tulang dapat terganggu dan menyebabkan tulang menjadi lemah, mudah rapuh, serta meningkatkan risiko gangguan pertumbuhan. Selain itu, kekurangan vitamin D pada anak perempuan juga dapat memengaruhi kepadatan massa tulang yang akan berdampak hingga usia dewasa dan meningkatkan risiko osteoporosis di kemudian hari. Penelitian menunjukkan bahwa kadar vitamin D yang cukup berhubungan dengan peningkatan kesehatan dan kepadatan tulang pada anak dan remaja (Karimian et al., 2022; Lamberg-Allardt et al., 2012).

Vitamin D dapat diperoleh melalui paparan sinar matahari, makanan, dan suplemen. Paparan sinar matahari pagi merupakan sumber utama vitamin D alami karena sinar ultraviolet B (UVB) membantu proses pembentukan vitamin D di kulit. Anak perempuan dianjurkan mendapatkan paparan sinar matahari pagi sekitar 10–15 menit beberapa kali dalam seminggu dengan tetap memperhatikan keamanan kulit. Selain dari sinar matahari, vitamin D juga dapat diperoleh dari makanan seperti ikan salmon, tuna, sarden, kuning telur, susu fortifikasi, keju, dan hati. Namun, dalam beberapa kondisi, asupan makanan saja belum cukup memenuhi kebutuhan vitamin D sehingga diperlukan perhatian khusus terutama pada anak yang jarang beraktivitas di luar ruangan. Organisasi kesehatan internasional menyebutkan bahwa kebutuhan vitamin D pada anak dan remaja usia 9–18 tahun sekitar 600 IU per hari untuk mendukung kesehatan tulang dan pertumbuhan optimal (International Osteoporosis Foundation, 2021; WHO, 2021).

Kekurangan vitamin D masih menjadi masalah kesehatan yang cukup sering ditemukan pada anak dan remaja di berbagai negara. Defisiensi vitamin D dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang, nyeri tulang, kelemahan otot, serta meningkatkan risiko rakhitis pada anak. Pada anak perempuan yang memasuki masa pubertas, kekurangan vitamin D juga dapat menghambat pembentukan massa tulang maksimal sehingga memengaruhi

kesehatan reproduksi dan kualitas hidup di masa dewasa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan dengan kadar vitamin D rendah cenderung memiliki kepadatan tulang lebih rendah dibandingkan anak dengan kadar vitamin D normal. Oleh karena itu, pemenuhan vitamin D harus diperhatikan sejak masa kanak-kanak sebagai investasi kesehatan jangka panjang (Roh et al., 2016; Loud & Gordon, 2006).

Selain mendukung kesehatan tulang, vitamin D juga berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan otot. Vitamin D membantu tubuh melawan infeksi dan mendukung fungsi sel imun sehingga anak perempuan lebih tahan terhadap penyakit. Dalam perkembangan terbaru, vitamin D juga diketahui memiliki hubungan dengan kesehatan mental, fungsi hormon, dan pengaturan suasana hati pada remaja. Oleh sebab itu, pemenuhan vitamin D secara cukup menjadi bagian penting dalam mendukung tumbuh kembang anak perempuan secara menyeluruh, baik fisik maupun psikologis (Abrams, 2021; Whitney & Rolfes, 2021)

D. Pola Makan Seimbang untuk Anak Perempuan

Pola makan seimbang merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, serta pemantauan berat badan secara teratur. Pada anak perempuan yang sedang memasuki masa pubertas, pola makan seimbang memiliki peran yang sangat penting karena pada fase ini tubuh mengalami pertumbuhan pesat, perubahan hormonal, perkembangan organ reproduksi, serta peningkatan aktivitas metabolisme tubuh. Kebutuhan energi, protein, vitamin, dan mineral meningkat secara signifikan sehingga asupan makanan harus benar-benar diperhatikan agar proses tumbuh kembang berlangsung optimal. Anak perempuan yang menerapkan pola makan sehat dan seimbang cenderung memiliki status gizi yang baik, pertumbuhan tinggi badan yang optimal, perkembangan mental yang lebih baik, serta daya tahan tubuh yang lebih kuat dibandingkan anak dengan pola makan tidak teratur. Selain itu, pola makan seimbang juga berperan dalam mencegah masalah gizi seperti anemia, stunting, obesitas, dan gangguan kesehatan reproduksi di masa depan (Kementerian Kesehatan RI, 2022; WHO, 2021).

Prinsip utama pola makan seimbang pada anak perempuan adalah mengonsumsi makanan yang beragam dan tidak berlebihan ataupun kekurangan. Tubuh membutuhkan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak sebagai sumber energi dan pembangun jaringan tubuh, serta zat gizi mikro seperti

vitamin dan mineral untuk menjaga fungsi metabolisme dan kekebalan tubuh. Karbohidrat diperlukan sebagai sumber energi utama untuk mendukung aktivitas fisik dan proses belajar anak. Sumber karbohidrat yang dianjurkan meliputi nasi, jagung, kentang, ubi, oatmeal, dan roti gandum. Protein sangat penting untuk pembentukan sel, otot, hormon, dan enzim tubuh sehingga anak perempuan dianjurkan mengonsumsi sumber protein hewani seperti ikan, telur, susu, daging, dan ayam, serta protein nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Lemak sehat juga dibutuhkan dalam pembentukan hormon reproduksi dan perkembangan otak, terutama lemak tidak jenuh yang terdapat pada ikan laut, alpukat, dan kacang-kacangan (Almatsier, 2019; Brown, 2020).

Selain zat gizi makro, anak perempuan menuju pubertas sangat membutuhkan zat gizi mikro terutama zat besi, kalsium, vitamin D, asam folat, dan zinc. Zat besi memiliki peran penting dalam pembentukan hemoglobin untuk mencegah anemia, terutama ketika anak perempuan mulai mengalami menstruasi. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, pucat, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan prestasi belajar. Kalsium dan vitamin D dibutuhkan dalam pembentukan massa tulang yang optimal karena sebagian besar pertumbuhan tulang terjadi pada masa pubertas. Apabila kebutuhan kalsium tidak terpenuhi, risiko osteoporosis pada masa dewasa akan meningkat. Oleh sebab itu, konsumsi susu, yogurt, ikan, telur, dan sayuran hijau perlu dibiasakan sejak dini. Selain itu, paparan sinar matahari pagi juga membantu pembentukan vitamin D secara alami di dalam tubuh (Mahan & Raymond, 2020; Adriani & Wirjatmadi, 2018).

Pola makan seimbang juga harus diimbangi dengan pengaturan waktu makan yang baik. Anak perempuan dianjurkan makan tiga kali sehari dengan tambahan makanan selingan sehat sebanyak satu hingga dua kali. Sarapan pagi merupakan bagian penting dari pola makan sehat karena dapat meningkatkan konsentrasi belajar, menjaga kestabilan energi, dan membantu metabolisme tubuh bekerja lebih optimal. Anak yang terbiasa melewati sarapan cenderung mengalami penurunan konsentrasi, mudah lelah, dan memiliki risiko mengonsumsi makanan tidak sehat secara berlebihan pada siang hari. Konsumsi buah dan sayur setiap hari juga sangat dianjurkan karena mengandung vitamin, mineral, antioksidan, dan serat yang membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan serta meningkatkan daya tahan tubuh. WHO merekomendasikan konsumsi minimal lima porsi buah dan sayur setiap hari untuk mendukung kesehatan anak dan remaja (WHO, 2021; Kemenkes RI, 2022).

Pada era modern saat ini, pola makan anak perempuan banyak dipengaruhi oleh konsumsi makanan cepat saji, minuman manis, makanan tinggi gula, garam,

dan lemak, serta kebiasaan makan sambil menggunakan gawai. Kebiasaan tersebut dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, gangguan metabolik, dan pubertas dini. Oleh karena itu, orang tua perlu memberikan pengawasan terhadap pola makan anak serta membiasakan konsumsi makanan rumahan yang lebih sehat dan bergizi. Orang tua juga memiliki peran penting dalam memberikan contoh perilaku makan sehat karena anak cenderung meniru kebiasaan makan keluarga. Pengetahuan orang tua tentang gizi sangat memengaruhi status gizi anak, sehingga edukasi gizi keluarga menjadi bagian penting dalam mendukung kesehatan anak perempuan menuju pubertas (UNICEF, 2021; Najwatory, 2026).

Selain memperhatikan jenis makanan, pola makan seimbang juga berkaitan erat dengan aktivitas fisik dan gaya hidup sehat. Anak perempuan dianjurkan melakukan aktivitas fisik minimal 60 menit setiap hari untuk membantu menjaga keseimbangan energi, memperkuat tulang dan otot, serta mencegah obesitas. Aktivitas fisik seperti berjalan kaki, bersepeda, bermain olahraga, dan senam sangat bermanfaat dalam mendukung pertumbuhan yang sehat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kombinasi edukasi gizi dan aktivitas fisik dapat membantu membentuk kebiasaan hidup sehat serta menurunkan risiko obesitas pada anak dan remaja. Dengan demikian, pola makan seimbang tidak hanya berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi, tetapi juga mencakup perilaku hidup sehat secara menyeluruh. Catatan kaki: (Benavides et al., 2024).

Anak perempuan menuju pubertas dianjurkan mengonsumsi makanan dengan komposisi:

1. Karbohidrat sebagai sumber energi utama
2. Protein sebagai zat pembangun
3. Sayur dan buah sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat
4. Air putih yang cukup setiap hari
5. Membatasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak

Kebiasaan sarapan juga penting untuk meningkatkan konsentrasi belajar dan menjaga metabolisme tubuh. Anak yang tidak sarapan cenderung mudah lelah dan sulit fokus di sekolah (Adriani & Wirjatmadi, 2018).

E. Dampak Kekurangan dan Kelebihan Nutrisi

Kekurangan nutrisi pada anak perempuan menuju pubertas merupakan masalah kesehatan yang dapat memberikan dampak jangka pendek maupun jangka panjang terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, kesehatan reproduksi, dan kualitas hidup di masa dewasa. Pada masa ini tubuh mengalami percepatan pertumbuhan (growth spurt) sehingga kebutuhan energi dan zat gizi meningkat secara signifikan. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka

tubuh akan mengalami hambatan pertumbuhan yang ditandai dengan berat badan rendah, tinggi badan tidak sesuai usia, mudah lelah, penurunan konsentrasi belajar, serta daya tahan tubuh yang menurun. Anak perempuan yang mengalami kekurangan gizi cenderung lebih rentan terhadap infeksi karena sistem imun tidak mampu bekerja secara optimal. Kondisi ini dapat menyebabkan anak sering sakit sehingga proses belajar dan aktivitas sehari-hari terganggu. Kekurangan nutrisi kronis juga dapat memicu terjadinya stunting yang berdampak pada rendahnya kapasitas intelektual, produktivitas, dan kesehatan reproduksi di masa mendatang. Menurut World Health Organization (WHO), status gizi yang buruk pada masa anak dan remaja dapat meningkatkan risiko penyakit kronis serta menurunkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa (WHO, 2021).

Salah satu dampak paling sering ditemukan pada anak perempuan menuju pubertas adalah anemia defisiensi besi. Kondisi ini terjadi akibat kurangnya asupan zat besi yang dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin dalam darah. Risiko anemia meningkat ketika anak mulai mengalami menstruasi karena tubuh kehilangan darah setiap bulan. Anemia menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga anak tampak pucat, mudah mengantuk, sulit berkonsentrasi, cepat lelah, dan mengalami penurunan prestasi belajar. Dalam jangka panjang, anemia dapat mengganggu perkembangan otak dan menurunkan kemampuan kognitif anak perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Beard (2019) menunjukkan bahwa kekurangan zat besi pada remaja perempuan berkaitan erat dengan penurunan fungsi memori dan kemampuan belajar. Selain itu, anemia pada masa remaja juga dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan di masa depan apabila kondisi tersebut tidak ditangani sejak dini (Beard, 2019).

Kekurangan protein juga memberikan dampak serius terhadap tumbuh kembang anak perempuan. Protein berfungsi sebagai zat pembangun yang membantu pembentukan jaringan tubuh, hormon, enzim, dan sistem kekebalan tubuh. Anak perempuan yang mengalami kekurangan protein akan mengalami hambatan pertumbuhan otot, penurunan massa tubuh, gangguan perkembangan organ reproduksi, serta penurunan daya tahan tubuh. Pada kondisi berat, kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan gizi seperti kwashiorkor dan marasmus yang ditandai dengan pembengkakan tubuh, rambut kusam, dan kelemahan otot. Selain itu, kekurangan protein pada masa pubertas dapat menghambat proses pematangan seksual sehingga menstruasi pertama menjadi terlambat. Menurut Almatsier (2019), protein merupakan salah satu zat gizi utama yang sangat menentukan kualitas pertumbuhan anak dan remaja karena hampir seluruh sel tubuh membutuhkan protein untuk proses regenerasi dan perkembangan (Almatsier, 2019).

Selain protein dan zat besi, kekurangan kalsium dan vitamin D juga menjadi masalah penting pada anak perempuan menuju pubertas. Masa pubertas merupakan periode pembentukan massa tulang terbesar dalam kehidupan manusia sehingga tubuh membutuhkan kalsium dalam jumlah tinggi. Apabila kebutuhan kalsium tidak terpenuhi, maka kepadatan tulang menjadi rendah dan meningkatkan risiko osteoporosis pada usia dewasa. Vitamin D yang membantu penyerapan kalsium juga sangat penting dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi. Anak perempuan yang jarang mengonsumsi susu, ikan, atau kurang mendapatkan paparan sinar matahari pagi lebih rentan mengalami kekurangan vitamin D. Penelitian yang dipublikasikan dalam *Journal of Adolescent Health* menyebutkan bahwa rendahnya asupan kalsium dan vitamin D selama masa remaja berhubungan dengan rendahnya massa tulang puncak yang dapat meningkatkan risiko patah tulang di kemudian hari (Golden & Abrams, 2020).

Di sisi lain, kelebihan nutrisi juga menjadi masalah kesehatan yang semakin meningkat pada anak perempuan akibat perubahan pola hidup modern dan konsumsi makanan tinggi kalori. Kelebihan nutrisi biasanya terjadi karena asupan energi yang melebihi kebutuhan tubuh serta rendahnya aktivitas fisik. Anak perempuan yang terlalu sering mengonsumsi makanan cepat saji, minuman manis, makanan tinggi gula, lemak, dan garam memiliki risiko lebih besar mengalami overweight dan obesitas. Obesitas pada masa anak dan remaja dapat menyebabkan gangguan metabolisme seperti diabetes melitus tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, serta gangguan hormonal. Selain itu, obesitas juga berhubungan dengan munculnya pubertas dini akibat peningkatan produksi hormon estrogen dalam jaringan lemak tubuh. Pubertas dini dapat memengaruhi kesiapan mental anak dan meningkatkan risiko gangguan psikososial seperti rendah diri dan kecemasan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Styne et al. (2017), obesitas pada remaja perempuan berhubungan erat dengan peningkatan risiko sindrom metabolik dan gangguan kesehatan reproduksi (Styne et al., 2017).

Kelebihan konsumsi gula juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada anak perempuan. Konsumsi minuman bersoda, makanan manis, dan camilan tinggi gula secara berlebihan dapat meningkatkan risiko obesitas dan kerusakan gigi. Selain itu, pola makan tinggi gula dapat menyebabkan resistensi insulin yang menjadi awal terjadinya diabetes melitus tipe 2. WHO merekomendasikan agar konsumsi gula tambahan dibatasi kurang dari 10% dari total kebutuhan energi harian untuk mencegah penyakit tidak menular pada anak dan remaja. Anak perempuan yang terbiasa mengonsumsi makanan tinggi gula cenderung mengalami pola makan tidak sehat hingga dewasa sehingga meningkatkan risiko penyakit degeneratif (WHO, 2021).

Kelebihan lemak terutama lemak jenuh dan lemak trans juga memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Lemak trans yang banyak ditemukan pada makanan cepat saji, gorengan, margarin padat, dan makanan kemasan dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat (LDL) serta meningkatkan risiko penyakit jantung di masa mendatang. Selain itu, konsumsi makanan tinggi lemak dapat menyebabkan penumpukan lemak berlebih pada tubuh sehingga memicu obesitas. Penelitian yang dilakukan oleh Moreno et al. (2019) menunjukkan bahwa pola konsumsi tinggi lemak dan rendah serat pada remaja berkaitan dengan peningkatan risiko obesitas abdominal dan gangguan metabolik (Moreno et al., 2019).

Dampak psikologis juga dapat muncul akibat masalah nutrisi baik kekurangan maupun kelebihan gizi. Anak perempuan dengan status gizi kurang sering mengalami rasa tidak percaya diri karena tubuh tampak kurus dan lemah, sedangkan anak dengan obesitas sering mengalami bullying, diskriminasi sosial, dan gangguan citra tubuh. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kesehatan mental anak seperti kecemasan, depresi, dan stres emosional. Masa pubertas merupakan periode sensitif dalam pembentukan identitas diri sehingga dukungan keluarga dan lingkungan sangat diperlukan agar anak memiliki persepsi positif terhadap tubuhnya. Menurut Sawyer et al. (2018), status gizi memiliki hubungan yang kuat dengan kesehatan mental dan kualitas hidup remaja perempuan (Sawyer et al., 2018).

Oleh karena itu, pemenuhan nutrisi yang seimbang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan tumbuh kembang optimal anak perempuan menuju pubertas. Pencegahan masalah gizi dapat dilakukan melalui penerapan pola makan sehat, konsumsi makanan bergizi seimbang, aktivitas fisik rutin, pembatasan makanan cepat saji, serta edukasi gizi kepada anak dan keluarga. Orang tua, sekolah, dan tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan hidup sehat agar anak perempuan dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif (Kemenkes RI, 2022).

F. Peran Orang Tua dalam Pemenuhan Nutrisi Anak

Orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam pemenuhan nutrisi anak perempuan menuju masa pubertas karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk pola makan, kebiasaan hidup sehat, serta perilaku konsumsi anak sehari-hari. Pada masa pertumbuhan, anak belum mampu menentukan kebutuhan gizinya sendiri sehingga sangat bergantung pada pengetahuan, perhatian, dan pengawasan orang tua dalam menyediakan makanan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang. Orang tua tidak hanya bertugas

menyediakan makanan, tetapi juga menjadi teladan dalam membentuk pola makan yang baik melalui kebiasaan makan bersama, konsumsi sayur dan buah, serta pembatasan makanan cepat saji dan minuman tinggi gula. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan pola makan sehat cenderung memiliki status gizi yang lebih baik dibandingkan anak yang tidak mendapatkan perhatian nutrisi secara optimal dari keluarganya (Soetjiningsih, 2020; Brown, 2020).

Peran orang tua dalam pemenuhan nutrisi dimulai dari kemampuan memilih bahan makanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan usia anak. Orang tua perlu memahami bahwa masa pubertas merupakan periode percepatan pertumbuhan (*growth spurt*) sehingga kebutuhan energi, protein, zat besi, kalsium, dan vitamin meningkat secara signifikan. Anak perempuan yang mulai mengalami menstruasi membutuhkan asupan zat besi lebih tinggi untuk mencegah anemia. Oleh karena itu, orang tua harus memastikan anak mengonsumsi makanan kaya zat besi seperti daging, hati, telur, ikan, dan sayuran hijau, serta mengombinasikannya dengan vitamin C agar penyerapan zat besi lebih optimal. Selain itu, konsumsi susu, ikan, dan makanan tinggi kalsium juga penting untuk mendukung pembentukan massa tulang yang maksimal selama pubertas (Almatsier, 2019; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Selain menyediakan makanan bergizi, orang tua juga memiliki tanggung jawab dalam membentuk kebiasaan makan yang teratur. Kebiasaan sarapan pagi, makan tepat waktu, konsumsi air putih yang cukup, serta pembatasan jajanan tidak sehat perlu diajarkan sejak dini. Anak yang terbiasa sarapan memiliki kemampuan konsentrasi dan prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan anak yang sering melewatkan sarapan. Sebaliknya, kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak secara berlebihan dapat meningkatkan risiko obesitas pada anak perempuan. Obesitas pada masa anak dan remaja dapat berdampak pada gangguan hormonal, pubertas dini, diabetes, hingga penyakit kardiovaskular di usia dewasa. Oleh sebab itu, pengawasan orang tua terhadap pola makan anak sangat diperlukan agar anak mampu menerapkan pola hidup sehat secara konsisten (WHO, 2021; Adriani & Wirjatmadi, 2018).

Pendidikan dan pengetahuan gizi orang tua juga sangat memengaruhi status gizi anak. Orang tua dengan pengetahuan gizi yang baik cenderung lebih mampu menyusun menu seimbang dan memahami kebutuhan nutrisi anak sesuai tahap perkembangannya. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan tentang gizi dapat menyebabkan kesalahan pola makan seperti pemberian makanan instan berlebihan, rendah konsumsi sayur dan buah, atau ketidakseimbangan zat gizi dalam makanan sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan ibu berhubungan erat dengan kualitas konsumsi pangan dan status gizi anak. Semakin

baik pengetahuan ibu tentang gizi, maka semakin baik pula pola makan anak dalam keluarga tersebut (Mahan & Raymond, 2020; UNICEF, 2021).

Faktor ekonomi keluarga juga memengaruhi kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Keterbatasan ekonomi sering kali menyebabkan keluarga memilih makanan murah dengan kualitas gizi rendah. Namun demikian, pemenuhan nutrisi sebenarnya tidak selalu harus mahal karena banyak sumber pangan lokal bergizi yang dapat dimanfaatkan seperti tempe, tahu, ikan lokal, telur, daun kelor, bayam, dan kacang-kacangan. Oleh sebab itu, edukasi mengenai pemanfaatan bahan pangan lokal bergizi penting diberikan kepada keluarga agar kebutuhan nutrisi anak tetap terpenuhi meskipun dalam kondisi ekonomi terbatas (Kemenkes RI, 2022; Whitney & Rolfes, 2021).

Perhatian emosional orang tua juga memiliki hubungan erat dengan pola makan anak. Anak yang mendapatkan dukungan emosional dan komunikasi yang baik dalam keluarga cenderung memiliki perilaku makan yang lebih sehat. Sebaliknya, konflik keluarga, kurangnya perhatian, dan stres dalam rumah tangga dapat memengaruhi nafsu makan serta kebiasaan konsumsi anak. Penelitian menunjukkan bahwa stres orang tua dan kondisi psikologis keluarga dapat memengaruhi sensitivitas pengasuhan dan pola pemberian makan pada anak. Lingkungan keluarga yang harmonis akan membantu anak merasa nyaman sehingga pola makan dan tumbuh kembangnya menjadi lebih optimal.

Selain itu, orang tua perlu mengawasi penggunaan media sosial dan pengaruh lingkungan terhadap pola makan anak perempuan. Pada masa pubertas, banyak anak mulai memperhatikan bentuk tubuh sehingga rentan mengikuti pola diet yang tidak sehat demi mencapai standar kecantikan tertentu. Orang tua harus memberikan pemahaman bahwa tubuh yang sehat lebih penting dibandingkan sekadar tubuh yang kurus. Edukasi mengenai citra tubuh positif (*body image*) dan pola makan sehat sangat penting untuk mencegah gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia pada remaja perempuan (Brown, 2020; WHO, 2021).

Di era digital saat ini, peran orang tua juga dapat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi kesehatan (*e-health*) dan media edukasi gizi. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis media digital dapat membantu meningkatkan kebiasaan makan sehat dan aktivitas fisik pada anak dan remaja apabila didukung oleh keterlibatan keluarga. Orang tua dapat memanfaatkan aplikasi kesehatan, video edukasi, maupun media sosial sebagai sarana belajar bersama anak mengenai pentingnya nutrisi dan gaya hidup sehat.

Dengan demikian, peran orang tua dalam pemenuhan nutrisi anak perempuan menuju pubertas sangat kompleks dan mencakup aspek penyediaan makanan, edukasi gizi, pembentukan kebiasaan makan sehat, pengawasan pola

hidup, dukungan emosional, serta pemberian contoh perilaku sehat dalam keluarga. Keterlibatan aktif orang tua akan membantu anak mencapai pertumbuhan dan perkembangan optimal serta mempersiapkan kesehatan reproduksi yang baik di masa depan (Soetjiningsih, 2020; Kemenkes RI, 2022).

G. Simpulan

Pemenuhan nutrisi merupakan salah satu faktor paling penting dalam mendukung tumbuh kembang optimal anak perempuan menuju masa pubertas. Pada fase ini tubuh mengalami berbagai perubahan fisik, hormonal, psikologis, dan reproduksi yang berlangsung sangat cepat sehingga membutuhkan asupan zat gizi yang cukup, seimbang, dan berkualitas. Nutrisi yang baik tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tetapi juga berperan dalam pembentukan jaringan tubuh, perkembangan otak, pematangan organ reproduksi, peningkatan sistem kekebalan tubuh, serta menjaga kesehatan secara menyeluruh. Karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral seperti zat besi, kalsium, dan vitamin D memiliki peranan penting dalam mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan anak perempuan selama masa pubertas.

Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti anemia, stunting, keterlambatan pertumbuhan, rendahnya daya tahan tubuh, gangguan perkembangan kognitif, hingga masalah kesehatan reproduksi di masa depan. Sebaliknya, kelebihan nutrisi akibat pola makan tidak sehat dan kurang aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko obesitas, pubertas dini, diabetes, serta penyakit metabolik lainnya. Oleh karena itu, penerapan pola makan seimbang, konsumsi makanan bergizi, pembatasan makanan tinggi gula, garam, dan lemak, serta aktivitas fisik yang cukup menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan anak perempuan menuju pubertas.

Peran orang tua sangat menentukan keberhasilan pemenuhan nutrisi anak karena keluarga merupakan lingkungan utama dalam membentuk kebiasaan makan dan pola hidup sehat. Orang tua tidak hanya bertanggung jawab menyediakan makanan bergizi, tetapi juga memberikan edukasi gizi, pengawasan pola makan, dukungan emosional, serta menjadi teladan dalam menerapkan gaya hidup sehat. Dukungan keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, dan lingkungan masyarakat sangat diperlukan agar anak perempuan dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, percaya diri, dan memiliki kesiapan fisik maupun mental dalam menghadapi masa pubertas serta kehidupan dewasa di masa mendatang.

H. Referensi

- Abrams, S.A. (2021) 'Bone Health in School Age Children: Effects of Nutritional Intake on Outcomes', *Frontiers in Nutrition*, 8, pp. 1–8.
- Adriani, M. & Wirjatmadi, B. (2018) *Peranan Gizi dalam Siklus Kehidupan*. Jakarta: Kencana.
- Almatsier, S. (2019) *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Barrar, J. (2024) *Protein Intake and Dietary Sources in Adolescents Aged 14–18 Years*. New Zealand: Massey University.
- Beard, J.L. (2019) 'Iron deficiency alters brain development and functioning', *The Journal of Nutrition*, 149(4), pp. 146–151.
- Benavides, C., Benítez-Andrades, J.A., Marqués-Sánchez, P. & Arias, N. (2024) 'eHealth Intervention to Improve Health Habits in the Adolescent Population: Mixed Methods Study', *JMIR Publications*.
- Brown, J.E. (2020) *Nutrition Through the Life Cycle*. 7th edn. Boston: Cengage Learning.
- Du, X. et al. (2002) 'Milk consumption and bone mineral density in adolescent girls', *American Journal of Clinical Nutrition*, 75(2), pp. 312–319.
- Garcia-Iborra, M. et al. (2023) 'Optimal Protein Intake in Healthy Children and Adolescents', *Nutrients*, 15(6), pp. 1–20.
- Golden, N.H. & Abrams, S.A. (2020) 'Optimizing bone health in children and adolescents', *Journal of Adolescent Health*, 66(2), pp. 142–149.
- Gunther, A.L.B. et al. (2010) 'Dietary Protein Intake throughout Childhood Is Associated with the Timing of Puberty', *The Journal of Nutrition*, 140(3), pp. 565–571.
- Hayati, S. & Herwana, E. (2018) 'Peningkatan asupan kalsium menghambat penurunan kepadatan tulang pada perempuan pascamenopause', *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*, 1(2), pp. 146–150.
- Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) (2013) 'Nutrisi pada Remaja'. Available at: IDAI.
- International Osteoporosis Foundation (2021) *Nutrition in Children and Adolescents*. Available at: <https://www.osteoporosis.foundation/health-professionals/prevention/nutrition-children-and-adolescents> (Accessed: 21 May 2026).
- Karimian, P. et al. (2022) 'Effects of vitamin D on bone density in healthy children', *Journal of Parathyroid Disease*, 10(2), pp. 45–53.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022) *Pedoman Gizi Seimbang*. Jakarta: Kemenkes RI.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022) Pedoman Pencegahan Anemia pada Remaja Putri. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lamberg-Allardt, C. et al. (2012) 'Vitamin D in children and adolescents', *Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation*, 72(sup243), pp. 124–128.
- Loud, K.J. & Gordon, C.M. (2006) 'Adolescent Bone Health', *JAMA Pediatrics*, 160(10), pp. 1026–1032.
- Mahan, L.K. & Raymond, J.L. (2020) *Krause's Food & the Nutrition Care Process*. 15th edn. St. Louis: Elsevier.
- Maspaitella, M.L. (2012) 'Hubungan asupan kalsium dan fosfor, indeks massa tubuh, dan kepadatan tulang pada remaja putri', *Journal of Nutrition College*, 1(1), pp. 229–240.
- Moreno, L.A., Gottrand, F., Huybrechts, I. & Ruiz, J.R. (2019) 'Nutrition and lifestyle in European adolescents', *Public Health Nutrition*, 22(5), pp. 1123–1132.
- Najwatory, K. (2026) 'Pengetahuan ibu, status gizi, balita, gizi kurang, posyandu', *Jurnal Pendidikan dan Kesehatan Keluarga*.
- Noprisanti, N. (2018) 'Hubungan asupan protein, kalsium, fosfor, dan magnesium dengan kepadatan tulang pada remaja putri', *Jurnal Kesehatan Andalas*, 7(3), pp. 410–417.
- Ozdemir, A. (2016) 'Macronutrients in Adolescence', *International Journal of Caring Sciences*, 9(3), pp. 1162–1170.
- Poltekkes Kemenkes Jakarta II (2020) *Gambaran Riwayat Konsumsi Pangan Sumber Kalsium*. Jakarta: Poltekkes Kemenkes Jakarta II.
- Roh, Y.E. et al. (2016) 'Vitamin D deficiency in children aged 6 to 12 years', *Annals of Pediatric Endocrinology & Metabolism*, 21(3), pp. 149–153.
- Sawyer, S.M., Azzopardi, P.S., Wickremarathne, D. & Patton, G.C. (2018) 'The age of adolescence', *The Lancet Child & Adolescent Health*, 2(3), pp. 223–228.
- Soetjiningsih (2020) *Tumbuh Kembang Anak*. Jakarta: EGC.
- Soliman, A. et al. (2022) 'Nutritional Interventions during Adolescence and Their Possible Effects', *Frontiers in Nutrition*, 9, pp. 1–15.
- Styne, D.M., Arslanian, S.A., Connor, E.L. et al. (2017) 'Pediatric obesity assessment, treatment, and prevention', *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 102(3), pp. 709–757.
- UNICEF (2021) *Adolescent Nutrition and Anemia Prevention*. New York: UNICEF.
- UNICEF (2021) *The State of the World's Children 2021*. New York: UNICEF.
- Whitney, E. & Rolfes, S.R. (2021) *Understanding Nutrition*. 16th edn. Boston: Cengage Learning.

World Health Organization (WHO) (2020) Guideline on Iron Supplementation in Adolescent Girls and Adult Women. Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO) (2021) Guideline on Healthy Diet and Nutrition for Children and Adolescents. Geneva: WHO.

I. Glosarium

Anemia

Kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin sehingga menyebabkan tubuh mudah lelah, pucat, dan kurang bertenaga.

Anemia Defisiensi Besi

Jenis anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi dalam tubuh sehingga pembentukan hemoglobin terganggu.

Asam Amino

Komponen penyusun protein yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan fungsi metabolisme.

Body Image

Pandangan atau persepsi seseorang terhadap bentuk dan penampilan tubuhnya sendiri.

Growth Spurt

Periode percepatan pertumbuhan fisik yang terjadi pada masa pubertas ditandai dengan peningkatan tinggi dan berat badan secara cepat.

Hemoglobin

Protein dalam sel darah merah yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh.

Hormon Estrogen

Hormon reproduksi utama pada perempuan yang berperan dalam perkembangan seksual dan siklus menstruasi.

Karbohidrat

Zat gizi makro yang menjadi sumber energi utama bagi tubuh.

Kognitif

Kemampuan berpikir yang meliputi proses belajar, mengingat, memahami, dan memecahkan masalah.

Konsumsi Gizi Seimbang

Pola makan yang mengandung zat gizi dalam jumlah dan jenis sesuai kebutuhan tubuh.

Malnutrisi

Kondisi akibat kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan asupan gizi dalam tubuh.

Menarche

Menstruasi pertama yang dialami anak perempuan sebagai tanda awal kematangan reproduksi.

Metabolisme

Proses kimia dalam tubuh yang mengubah makanan menjadi energi dan zat yang dibutuhkan tubuh.

Mikronutrien

Zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil seperti vitamin dan mineral.

Nutrisi

Proses tubuh memperoleh dan menggunakan zat makanan untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan.

Obesitas

Kondisi kelebihan lemak tubuh akibat ketidakseimbangan antara asupan energi dan aktivitas fisik.

Omega-3

Jenis asam lemak tidak jenuh yang penting untuk perkembangan otak dan kesehatan jantung.

Osteoporosis

Penyakit tulang yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah akibat rendahnya kepadatan tulang.

Peak Bone Mass

Massa tulang maksimal yang dicapai seseorang pada masa pertumbuhan dan pubertas.

Protein

Zat gizi makro yang berfungsi sebagai zat pembangun dan perbaikan jaringan tubuh.

Pubertas

Masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, hormonal, dan reproduksi.

Reproduksi

Proses biologis yang berkaitan dengan kemampuan menghasilkan keturunan.

Serat Pangan

Bagian makanan nabati yang tidak dapat dicerna tubuh dan berfungsi membantu kesehatan pencernaan.

Stunting

Gangguan pertumbuhan kronis yang menyebabkan tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan usianya akibat kekurangan gizi dalam waktu lama.

Suplemen

Produk tambahan yang mengandung zat gizi tertentu untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh.

Tumbuh Kembang

Proses bertambahnya ukuran tubuh (pertumbuhan) dan meningkatnya kemampuan fungsi tubuh (perkembangan).

Vitamin D

Vitamin yang membantu penyerapan kalsium dan menjaga kesehatan tulang serta sistem imun.

Zat Besi

Mineral penting yang berfungsi membentuk hemoglobin dalam darah dan membantu transportasi oksigen.

Zat Gizi Makro

Zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar seperti karbohidrat, protein, dan lemak.

Zat Gizi Mikro

Zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil seperti vitamin dan mineral.

CHAPTER 4

KEBERSIHAN DIRI DAN KESEHATAN ORGAN REPRODUKSI SEJAK DINI

Norlaila Sofia, S.Si.T., M.Keb.

A. Pendahuluan

Kebersihan diri (*personal hygiene*) merupakan salah satu fondasi paling mendasar dalam menjaga kesehatan secara menyeluruh, terutama bagi anak perempuan yang sedang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan menuju pubertas. Kebiasaan menjaga kebersihan yang ditanamkan sejak dini tidak hanya berfungsi melindungi tubuh dari kuman dan infeksi, tetapi juga membentuk kesadaran anak akan tubuhnya sendiri, termasuk organ-organ reproduksinya yang kelak akan mengemban peran penting dalam kehidupan dewasa.

Sayangnya, pendidikan kebersihan diri khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi sering kali masih dianggap tabu untuk disampaikan secara terbuka, bahkan di lingkungan keluarga sekalipun. Akibatnya, banyak anak perempuan tumbuh tanpa bekal pengetahuan yang memadai, sehingga rentan terhadap berbagai masalah kesehatan seperti infeksi saluran kemih, keputihan patologis, dermatitis di area genital, hingga risiko penyakit menular seksual di kemudian hari.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keputihan sangat umum terjadi pada perempuan Indonesia dengan estimasi sekitar 75-90% pernah mengalaminya setidaknya sekali dan paling sering terjadi pada usia 15-24 tahun (Ilmassalma et al., 2021; Lutfiyati, 2022; Wada et al., 2023). Angka ini mencerminkan betapa pentingnya intervensi edukasi yang dimulai jauh sebelum pubertas tiba. Masa anak akhir (usia 8–12 tahun) merupakan jendela emas untuk menanamkan kebiasaan higienis yang benar karena pada fase ini anak sudah mampu menerima penjelasan logis, mampu melakukan perawatan diri secara mandiri, dan masih sangat responsif terhadap arahan dari orang tua maupun tenaga kesehatan.

Topik ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa kebidanan, calon tenaga kesehatan, orang tua, maupun masyarakat umum tentang bagaimana cara menjaga kebersihan diri anak perempuan secara menyeluruh mulai dari kebersihan umum (rambut, kulit, gigi, tangan, kaki) hingga perawatan khusus organ reproduksi serta kapan dan bagaimana memperkenalkan

konsep-konsep ini kepada anak secara bertahap dan sesuai usia. Dalam konteks praktik kebidanan, bidan memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pemberi asuhan, tetapi juga sebagai edukator, konselor, dan promotor kesehatan dalam membentuk perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini. Edukasi mengenai kebersihan diri dan kesehatan organ reproduksi pada anak perempuan merupakan bagian integral dari upaya promotif dan preventif dalam pelayanan kebidanan, khususnya pada pelayanan kesehatan anak dan remaja.

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari topik ini, pembaca diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dan ruang lingkup kebersihan diri pada anak perempuan pra-pubertas.
2. Mengidentifikasi praktik kebersihan yang tepat untuk setiap bagian tubuh, termasuk organ reproduksi.
3. Mengenali tanda-tanda masalah kebersihan dan kesehatan reproduksi yang perlu mendapat perhatian.
4. Memberikan edukasi kepada orang tua dan anak tentang *personal hygiene* yang benar secara sesuai usia.
5. Menyusun rencana edukasi kebersihan diri yang dapat diterapkan di keluarga maupun komunitas.

B. Konsep Dasar Kebersihan Diri (*Personal Hygiene*)

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Personal hygiene berasal dari kata Yunani '*Hygeia*', dewi kesehatan dalam mitologi Yunani kuno. Secara ilmiah, *personal hygiene* didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan seseorang untuk memelihara kebersihan dan kesehatan dirinya sendiri, baik secara fisik maupun psikologis, guna mencegah penyakit dan meningkatkan kesejahteraan hidup (Febriyanti et al., 2018; Minolin et al., 2018; Sripradha & Kumar, 2018).

Ruang lingkup *personal hygiene* pada anak perempuan mencakup: (1) kebersihan kulit dan tubuh secara umum; (2) kebersihan rambut dan kepala; (3) kebersihan gigi dan mulut; (4) kebersihan tangan dan kuku; (5) kebersihan kaki; (6) kebersihan pakaian dan pakaian dalam; serta (7) kebersihan organ reproduksi eksternal. Masing-masing area memiliki kebutuhan perawatan yang spesifik dan perlu diajarkan secara bertahap sesuai perkembangan usia dan kemampuan anak (Arora et al., 2025; Cavusoglu & Celik Eren, 2024).

2. Mengapa Kebersihan Diri Sangat Penting pada Anak Perempuan?

Anak perempuan memiliki anatomi organ reproduksi yang berbeda secara signifikan dibandingkan anak laki-laki, sehingga kerentanan terhadap infeksi di area genital jauh lebih tinggi. Vulva dan vagina terletak berdekatan dengan muara uretra dan anus, menciptakan kondisi yang memudahkan perpindahan bakteri (terutama *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*) dari satu area ke area lain apabila kebersihan tidak dijaga dengan baik.

Pada anak pra-pubertas, kadar estrogen yang masih rendah menyebabkan epitel vagina sangat tipis dan pH vagina mendekati netral (pH 6–7), berbeda dengan perempuan dewasa yang memiliki pH asam (3,8–4,5) yang bersifat protektif (Donders et al., 2024; Xi et al., 2024). Kondisi ini membuat anak perempuan pra-pubertas lebih rentan terhadap *vulvovaginitis* (peradangan vulva dan vagina), yang merupakan salah satu keluhan ginekologis tersering pada kelompok usia ini.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebersihan Diri Anak

Terdapat beberapa faktor yang secara signifikan mempengaruhi pola kebersihan diri anak perempuan, antara lain (Aziz et al., 2024; Ene et al., 2024):

Tabel 4.1: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebersihan Diri Anak

Faktor	Deskripsi	Implikasi Praktis
Budaya & Norma Sosial	Kebiasaan dalam keluarga, kepercayaan lokal tentang tubuh	Edukasi sensitif budaya, libatkan tokoh lokal
Tingkat Pendidikan Orang Tua	Pemahaman orang tua tentang higiene dan kesehatan	Edukasi orang tua sebagai agen utama perubahan
Akses Air Bersih & Sanitasi	Ketersediaan air, sabun, fasilitas kamar mandi	Advokasi lingkungan sehat; solusi alternatif
Usia dan Tahap Perkembangan	Kemampuan motorik & kognitif anak	Pembelajaran bertahap sesuai usia
Status Sosial Ekonomi	Kemampuan membeli produk kebersihan	Edukasi produk terjangkau & alami
Peran Media & Teman Sebaya	Informasi dari gadget, teman, konten digital	Literasi media kesehatan sejak dini

Dalam praktik kebidanan, pemahaman konsep *personal hygiene* menjadi dasar dalam memberikan asuhan yang komprehensif, terutama pada pelayanan kebidanan komunitas. Bidan berperan dalam mengidentifikasi faktor risiko,

memberikan edukasi, serta melakukan intervensi dini untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan reproduksi sejak usia anak.

C. Praktik Kebersihan Diri yang Benar pada Anak Perempuan

1. Kebersihan Tubuh Secara Umum

Kebersihan tubuh secara umum yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari adalah mandi. Mandi merupakan aktivitas kebersihan paling dasar yang idealnya dilakukan dua kali sehari pada pagi dan sore hari atau malam hari. Selain membersihkan kotoran dan keringat, mandi memiliki fungsi penting dalam merangsang sirkulasi darah, menyegarkan tubuh dan pikiran, serta membangun ritme harian yang disiplin. Mandi secara teratur juga berkontribusi pada rutinitas harian yang terstruktur, yang bermanfaat bagi kesejahteraan fisik dan mental (Ardahan Akgül et al., 2026; Comberiati et al., 2019). Pada anak pra-pubertas, direkomendasikan menggunakan sabun mandi dengan pH netral (pH 5,5–7) untuk menghindari iritasi kulit yang masih sensitif (Blume-Peytavi et al., 2009).

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam rutinitas mandi anak perempuan meliputi: memastikan seluruh lipatan tubuh (leher, ketiak, belakang telinga, selangkangan, sela-sela jari) dibersihkan dengan seksama; mengeringkan tubuh dengan handuk bersih dan lembut terutama di area lipatan; serta mengganti pakaian dengan pakaian bersih setelah mandi.

2. Kebersihan Rambut dan Kulit Kepala

Rambut yang kotor dan berminyak merupakan media yang ideal bagi pertumbuhan jamur dan bakteri, serta dapat menyebabkan *pedikulosis kapitis* (kutu rambut) yang sangat umum terjadi pada anak usia sekolah. Keramas dianjurkan dilakukan 2–3 kali per minggu untuk anak dengan aktivitas normal, atau lebih sering jika anak banyak berkeringat atau beraktivitas di luar ruangan.

Sampo yang digunakan sebaiknya diformulasikan khusus untuk anak, dengan kandungan bahan kimia yang lebih lembut dan tidak pedih di mata. Penting untuk memastikan sampo dibilas hingga bersih sempurna karena residu sampo yang tertinggal di kulit kepala dapat memicu ketombe dan *dermatitis seboroik*.

3. Kebersihan Gigi dan Mulut

Kesehatan rongga mulut pada anak tidak bisa dipandang sebelah mata karena gigi yang tidak terawat akan mengakibatkan menjadi karies gigi (gigi berlubang) yang merupakan salah satu penyakit infeksi paling umum pada masa

kanak-kanak. Karies gigi adalah masalah kesehatan gigi yang luas, dengan prevalensi 60–90% anak usia sekolah di seluruh dunia (Truong et al., 2021). Karies gigi yang tidak diobati dapat menyebabkan nyeri kronis, kesulitan makan, masalah bicara, dan infeksi sistemik. Karies pada anak kecil juga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan, yang berkontribusi pada malnutrisi, stunting, dan wasting. Tidak hanya sampai disitu, pada kasus yang parah dapat mengakibatkan komplikasi yang mengancam jiwa (Baghdadi, 2016; Kumari et al., 2023). Strategi yang efektif dalam pencegahan dan penanganan karies gigi pada anak meliputi penggunaan fluoride (pasta gigi, fluoridasi air), pemeriksaan gigi rutin, dan edukasi kesehatan mulut (Liu et al., 2024).

Faktor risiko terjadinya karies antara lain karena perilaku seperti kebersihan mulut yang buruk, sering mengonsumsi makanan dan minuman manis, dan kurangnya pengawasan orang tua saat menyikat gigi sangat berkaitan dengan karies. Selain itu, faktor sosioekonomi juga memengaruhi terjadinya karies, termasuk kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap perawatan gigi, memperparah masalah ini, terutama di komunitas yang kurang beruntung. Serta faktor biologi seperti lubang dan celah yang dalam pada gigi serta kekurangan vitamin D juga meningkatkan kerentanan (Almoudi et al., 2019; Prada, 2020; Truong et al., 2021).

Panduan menyikat gigi yang benar untuk anak pra-pubertas: (1) Sikat gigi dua kali sehari pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur; (2) Gunakan pasta gigi berfluoride seukuran biji kacang polong; (3) Sikat seluruh permukaan gigi (luar, dalam, dan permukaan kunyah) selama minimal 2 menit; (4) Ganti sikat gigi setiap 3 bulan atau ketika bulu sikat sudah mekar. Anak perlu diawasi dalam menyikat gigi hingga sekitar usia 8–10 tahun untuk memastikan teknik yang tepat.

4. Kebersihan Tangan dan Kuku

Mencuci tangan dengan sabun adalah intervensi kesehatan paling sederhana namun paling efektif dalam mencegah penyakit infeksi. Studi WHO menunjukkan bahwa cuci tangan dengan sabun dapat mengurangi risiko diare hingga 48% dan infeksi saluran pernapasan hingga 16%. Anak perempuan perlu diajarkan untuk mencuci tangan pada lima momen kritis: (1) sebelum makan; (2) sesudah dari toilet; (3) setelah bermain di luar atau memegang hewan; (4) setelah bersin/batuk; dan (5) setelah menyentuh area genital.

Kuku yang panjang dan kotor menjadi sarang bakteri dan parasit. Kuku perlu dipotong pendek dan dibersihkan secara rutin idealnya setiap 1–2 minggu sekali. Penggunaan cat kuku tidak dianjurkan pada anak karena mengandung

bahan kimia (*formaldehida, toluena, DBP*) yang berpotensi toksik terutama jika tertelan.

5. Kebersihan Pakaian dan Pakaian Dalam

Pakaian berfungsi sebagai pelindung kulit dari paparan lingkungan eksternal, sekaligus sebagai media yang dapat menjadi sumber infeksi jika tidak dijaga kebersihannya. Anak perempuan perlu diajarkan untuk mengganti pakaian setiap hari, atau lebih sering jika berkeringat banyak. Pakaian dalam (celana dalam) secara khusus harus diganti setiap hari tanpa pengecualian.

Pemilihan jenis bahan pakaian dalam juga tidak kalah penting. Bahan katun 100% sangat direkomendasikan karena: menyerap keringat dengan baik, memungkinkan sirkulasi udara yang lebih baik di area genital, tidak menyebabkan iritasi pada kulit sensitif, dan lebih mudah dibersihkan dari residu detergen. Hindari pakaian dalam berbahan sintetis (nilon, poliester) yang cenderung menyimpan kelembaban dan panas, menciptakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan bakteri dan jamur.

Dalam pelayanan kebidanan, edukasi praktik kebersihan diri merupakan bagian dari asuhan berkelanjutan (*continuity of care*) yang diberikan sejak masa anak hingga remaja. Bidan perlu memastikan bahwa informasi yang diberikan bersifat aplikatif, sesuai usia, dan mempertimbangkan kondisi sosial budaya keluarga.

D. Kesehatan Organ Reproduksi Eksternal pada Anak Perempuan

1. Anatomi Dasar yang Perlu Dipahami

Sebelum membahas cara perawatan organ reproduksi, penting untuk memahami anatomi dasar organ reproduksi eksternal perempuan (vulva) yang relevan dalam konteks kebersihan sehari-hari. Pemahaman anatomi ini menjadi dasar penting dalam pemeriksaan kebidanan serta edukasi kepada klien dan keluarga agar mereka dapat mengenali tubuh mereka sendiri dan mampu melaporkan kelainan atau keluhan dengan tepat.

Tabel 4.2: Anatomi Dasar yang Perlu Dipahami

Bagian	Deskripsi Singkat	Relevansi Kebersihan
Labia Majora	Lipatan kulit luar yang menutupi struktur di bawahnya	Area yang sering lembab & terkumpul keringat
Labia Minora	Lipatan kulit halus di dalam labia majora	Sangat sensitif; hindari sabun keras

Klitoris	Organ kecil di persimpangan labia minora bagian atas	Bersihkan dengan lembut; hindari tekanan berlebihan
Orifisium Uretra	Lubang saluran kemih, terletak di bawah klitoris	Risiko ISK jika terkontaminasi feses
Introitus Vagina	Lubang masuk vagina, dilindungi selaput dara	Self-cleaning; tidak perlu dibersihkan bagian dalam
Perineum	Area antara vagina dan anus	Arah pembersihan: depan ke belakang

Penting: mengajarkan nama anatomis yang benar kepada anak perempuan bukanlah hal yang tabu justru ini merupakan bagian dari pendidikan kesehatan yang esensial. Anak yang mengenal nama organ tubuhnya dengan benar lebih mampu mengkomunikasikan rasa sakit atau ketidaknyamanan kepada orang tua dan tenaga kesehatan. Bagi bidan, pemahaman anatomi ini sangat penting sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan fisik, deteksi dini kelainan, serta memberikan edukasi yang tepat kepada anak dan orang tua terkait perawatan organ reproduksi.

2. Cara Membersihkan Organ Reproduksi yang Benar

Membersihkan area genital adalah keterampilan yang perlu diajarkan secara eksplisit, bukan diasumsikan anak akan mengetahuinya dengan sendirinya. Berikut adalah panduan lengkap yang dapat dijadikan acuan:

Tabel 4.3: Protokol Perawatan Genital Eksternal pada Anak Perempuan

 Protokol Perawatan Genital Eksternal pada Anak Perempuan
PRINSIP UTAMA — 'DEPAN KE BELAKANG' Selalu basuh dari arah depan (vagina) ke belakang (anus), TIDAK PERNAH sebaliknya. Prinsip ini mencegah bakteri dari usus (terutama E. coli) berpindah ke uretra dan vagina. LANGKAH-LANGKAH PRAKTIS: 1. Cuci tangan terlebih dahulu sebelum menyentuh area genital. 2. Gunakan air bersih yang mengalir. Air hangat lebih nyaman untuk anak. 3. Sabun: HANYA gunakan sabun lembut (pH netral) pada labia majora dan perineum bagian luar. JANGAN masukkan sabun ke dalam vagina. 4. Bilas dengan air bersih mengalir hingga tidak ada sisa sabun. 5. Keringkan dengan handuk bersih atau tisu lembut dengan cara ditepuk-tepuk (bukan digosok), arah depan ke belakang. HAL-HAL YANG HARUS DIHINDARI:

1. *Douching* (menyemprot/membilas bagian dalam vagina), vagina bersifat self-cleaning dan tidak memerlukan pembersihan internal
2. Sabun antiseptik keras, sabun wangi berparfum, atau produk feminine hygiene spray pada area genital internal
3. Bedak talc di area genital (risiko iritasi dan dalam jangka panjang dikaitkan dengan risiko kanker ovarium)
4. Menggosok area genital terlalu keras yang dapat merusak epitel yang tipis

Dalam praktik kebidanan, edukasi mengenai perawatan genital merupakan salah satu intervensi preventif utama untuk menurunkan kejadian infeksi saluran kemih dan vulvovaginitis pada anak perempuan (Alnuaimi et al., 2022; Cemek et al., 2016; Cihan Erdogan & Gonderen Cakmak, 2026). Bidan memiliki peran penting dalam mendemonstrasikan teknik yang benar kepada anak dan orang tua, serta melakukan evaluasi terhadap praktik yang telah dilakukan di rumah.

3. Kebersihan Setelah Buang Air

Cara membersihkan diri setelah buang air kecil maupun besar harus diajarkan secara eksplisit sejak anak mulai toilet training (usia 2–3 tahun). Kesalahan dalam cara cebok merupakan salah satu penyebab paling umum vulvovaginitis dan infeksi saluran kemih pada anak perempuan (Cemek et al., 2016).

Setelah buang air kecil: bersihkan dari depan ke belakang menggunakan air bersih atau tisu basah yang lembut dan bebas alkohol. Setelah buang air besar: bersihkan anus terlebih dahulu dengan arah dari perineum ke belakang, pastikan tidak ada sisa feses yang menempel, lalu bersihkan kembali area vulva dari depan ke belakang. Pastikan anak selalu mencuci tangan dengan sabun setelah dari toilet.

4. Kebersihan Saat Menstruasi Pertama (*Menarche*)

Menarche /menstruasi pertama adalah salah satu perubahan pubertas yang paling signifikan bagi anak perempuan. Kesiapan untuk menghadapi menarche tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis. Anak perempuan yang sudah mendapatkan informasi yang benar tentang menstruasi sebelum mengalaminya terbukti memiliki pengalaman menarche yang lebih positif dan lebih sedikit kecemasan (Nova et al., 2026).

Edukasi mengenai kebersihan saat menstruasi perlu diberikan jauh sebelum *menarche* tiba idealnya pada usia 9–10 tahun. Materi yang perlu disampaikan meliputi: apa itu menstruasi dan mengapa terjadi; cara menggunakan pembalut dengan benar; frekuensi penggantian pembalut (setiap

4–6 jam atau lebih sering jika aliran deras); cara membuang pembalut yang higienis; pentingnya menjaga kebersihan area genital lebih ketat selama menstruasi; serta bagaimana mengenali tanda-tanda abnormal seperti nyeri haid berlebihan dan perdarahan yang sangat banyak.

Tabel 4.4: Kebersihan Saat Menstruasi Pertama

Jenis Pembalut	Kelebihan	Kekurangan	Rekomendasi Usia
Pembalut sekali pakai	Mudah digunakan, tersedia luas, relatif murah	Sampah plastik; risiko ruam jika tidak sering diganti	Cocok untuk <i>menarche</i>
Pembalut kain (reusable)	Ramah lingkungan, lebih lembut	Perlu dicuci & dikeringkan dengan benar	Usia 10+ dengan edukasi
Menstrual cup	Kapasitas tinggi, hemat jangka panjang	Perlu teknik pemasangan; tidak direkomendasikan untuk anak	Dewasa / remaja akhir

Edukasi mengenai kebersihan menstruasi merupakan bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi remaja yang menjadi tanggung jawab bidan. Kesiapan anak dalam menghadapi *menarche* tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh dukungan emosional dan lingkungan yang kondusif, yang perlu difasilitasi melalui konseling oleh tenaga kesehatan (Edet et al., 2020; Mehjabeen et al., 2022; Rizkia & Ungsianik, 2019).

E. Tanda-Tanda Masalah Kesehatan Reproduksi yang Perlu Diwaspadai

1. *Vulvovaginitis* pada Anak

Vulvovaginitis adalah kondisi peradangan pada vulva dan/atau vagina yang merupakan gangguan ginekologis paling sering pada anak perempuan pra-pubertas. Kondisi ini bisa disebabkan oleh faktor non-infeksius (iritasi dari sabun, detergen, pakaian sintetis, pasir) maupun infeksius (bakteri, jamur, parasit) (Itriyeva, 2020).

Gejala yang perlu diwaspadai: rasa gatal atau panas di area vulva; kemerahan (eritema) pada labia dan area sekitarnya; keluarnya cairan abnormal dari vagina (berwarna kuning, hijau, atau berbau tidak sedap); rasa sakit atau perih saat buang air kecil; serta anak sering menggaruk atau memegang area genital. Jika gejala-gejala ini muncul, anak perlu segera dibawa ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan evaluasi dan penanganan yang tepat.

2. Infeksi Saluran Kemih (ISK)

ISK pada anak perempuan jauh lebih umum dibandingkan anak laki-laki karena uretra perempuan yang lebih pendek (sekitar 3–4 cm) memudahkan bakteri naik ke kandung kemih. Faktor risiko utama ISK pada anak perempuan antara lain: cara cebok yang salah, konstipasi (sembelit), jarang buang air kecil, serta kurang minum air putih.

Gejala ISK pada anak meliputi: sering buang air kecil namun sedikit-sedikit; rasa perih atau nyeri saat buang air kecil; urine berwarna keruh atau berbau menyengat; demam; nyeri di perut bawah atau pinggang; serta pada bayi/anak kecil bisa berupa rewel tanpa sebab jelas. Infeksi saluran kemih (ISK) pada pasien anak seringkali menunjukkan gejala spesifik usia. Bayi biasanya menunjukkan tanda-tanda sistemik yang tidak spesifik, sedangkan anak yang lebih besar menunjukkan gejala saluran kemih yang lebih terlokalisasi. Demam merupakan indikator universal di semua kelompok usia, yang menekankan pentingnya analisis urin dan kultur urin untuk diagnosis yang akurat (Daniel et al., 2023; Jadresic, 2010). ISK yang tidak ditangani dapat berkembang menjadi komplikasi infeksi ginjal (*pielonefritis*) yang lebih serius.

3. Keputihan pada Anak

Keluarnya cairan dari vagina pada anak perempuan tidak selalu patologis. Sejak beberapa bulan sebelum *menarche*, banyak anak mengalami keputihan fisiologis cairan bening atau putih susu yang tidak berbau dan tidak menyebabkan gatal sebagai tanda awal bahwa sistem reproduksi sedang bersiap (Boerma & Wray, 2020; Dhaded et al., 2019). Kondisi ini adalah hal yang normal.

Namun, keputihan perlu mendapatkan perhatian medis jika: berwarna kuning, hijau, atau abu-abu; berbau tidak sedap (amis atau busuk); disertai rasa gatal, panas, atau perih; konsistensi seperti keju cottage (menunjukkan infeksi jamur); atau disertai bercak darah di luar siklus menstruasi (Sherrard et al., 2018). Penting bagi orang tua untuk menciptakan lingkungan yang terbuka sehingga anak tidak merasa malu atau takut untuk melaporkan perubahan pada tubuhnya.

Tabel 4.5: Keputihan pada Anak

 Tanda Bahaya yang Memerlukan Evaluasi Segera
Bawa anak ke tenaga kesehatan segera apabila ditemukan: 1. Keluarnya cairan vagina yang berwarna, berbau, atau disertai darah pada anak yang belum <i>menarche</i>

2. Nyeri, bengkak, atau luka di area genital yang tidak jelas penyebabnya
3. Rasa gatal intens di area genital yang tidak membaik setelah menjaga kebersihan
4. Demam disertai nyeri perut bawah atau nyeri saat buang air kecil
5. Anak sering menyentuh atau menggaruk area genital secara berulang
6. Tanda-tanda cedera di area genital yang menimbulkan kecurigaan adanya kekerasan seksual

Dalam pelayanan kebidanan, kemampuan bidan dalam melakukan deteksi dini terhadap tanda dan gejala gangguan kesehatan reproduksi sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Bidan juga berperan dalam menentukan kebutuhan rujukan serta memberikan edukasi kepada keluarga mengenai tanda bahaya yang harus segera ditangani.

F. Contoh Kasus Klinis

Kasus 1:

Diagnosa Kebidanan: Vulvovaginitis berulang berhubungan dengan praktik higiene genital yang tidak adekuat

Tabel 4.6: Skenario Klinis 1

Skenario Klinis 1

Identitas: Rara, 7 tahun, dibawa ibunya ke Puskesmas dengan keluhan gatal dan kemerahan di area kelamin sejak 2 minggu lalu. Ini adalah kunjungan ketiga dengan keluhan serupa dalam 4 bulan terakhir.

Temuan Pemeriksaan:

1. Eritema (kemerahan) pada labia majora dan minora bilateral
2. Cairan vagina minimal, berwarna putih kekuningan, berbau sedikit tidak sedap
3. Tidak ditemukan tanda lesi atau trauma

Hasil Anamnesis:

Ibu Rara mengakui bahwa Rara sudah mandiri ke toilet sejak usia 5 tahun. Rara biasa menggunakan tisu basah berpewangi untuk membersihkan diri setelah BAK, dengan arah dari belakang ke depan (dari anus menuju vagina) karena 'lebih mudah'. Pakaian dalam Rara terbuat dari bahan nilon tipis. Ibu tidak pernah secara eksplisit mengajarkan cara membersihkan area genital.

Analisis Masalah:

1. Arah cebok dari belakang ke depan memindahkan bakteri fekal ke area vulva/uretra
2. Tisu basah berpewangi mengandung alkohol dan parfum yang mengiritasi mukosa genital sensitif

3. Pakaian dalam bahan nilon memperburuk kelembaban dan panas di area genital

Intervensi Bidan/Tenaga Kesehatan:

1. Edukasi ibu dan Rara tentang teknik cebok yang benar (depan ke belakang) menggunakan model demonstrasi sederhana
2. Anjurkan mengganti tisu basah berpewangi dengan air bersih mengalir atau tisu bebas pewangi/alkohol
3. Rekomendasikan pakaian dalam berbahan katun 100%
4. Tindak lanjut 2 minggu kemudian untuk evaluasi

Pelajaran Kunci: Vulvovaginitis berulang sering kali bukan masalah medis primer, melainkan masalah kebiasaan hygiene yang dapat diselesaikan dengan edukasi yang tepat sasaran.

Kasus 2:

Diagnosa Kebidanan: Keputihan fisiologis sebagai tanda awal pubertas.

Tabel 4.7: Skenario Klinis 2

 Skenario Klinis 2

Identitas: Sari, 10 tahun, datang bersama ibunya yang sangat cemas karena menemukan noda putih kering di celana dalam Sari. Ibu Sari khawatir anaknya 'terkena penyakit kelamin' dan memaksa Sari untuk segera dibawa ke dokter.

Temuan Pemeriksaan:

1. Tidak ada keluhan gatal, nyeri, atau panas
2. Cairan vagina bening-keputihan, tidak berbau, tidak menyebabkan iritasi
3. Tanda-tanda pubertas awal: pertumbuhan payudara (stadium Tanner 2), pertumbuhan rambut pubis

Analisis:

Kondisi Sari merupakan leukore fisiologis (keputihan normal) yang merupakan tanda awal pubertas. Cairan ini diproduksi oleh kelenjar serviks dan dinding vagina sebagai persiapan menstruasi, biasanya muncul 6–18 bulan sebelum *menarche*.

Intervensi: Keluarnya cairan dari vagina pada anak perempuan tidak selalu patologis. Sejak beberapa bulan sebelum *menarche*, banyak anak mengalami keputihan fisiologis cairan bening atau putih susu yang tidak berbau dan tidak menyebabkan gatal sebagai tanda awal bahwa sistem reproduksi sedang bersiap.

1. Edukasi ibu dan Sari bahwa kondisi ini NORMAL dan merupakan tanda pubertas yang sehat
2. Jelaskan perbedaan antara keputihan normal dan patologis dengan bahasa yang mudah dipahami
3. Diskusikan persiapan menghadapi *menarche* yang diperkirakan akan datang dalam waktu dekat

4. Reassure ibu bahwa panties liner tipis berbahan katun boleh digunakan untuk kenyamanan

Pelajaran Kunci: Ketidaktahuan tentang perubahan fisiologis pubertas dapat menimbulkan kecemasan yang tidak perlu. Edukasi proaktif sebelum pubertas adalah investasi kesehatan yang paling efisien.

G. Strategi Edukasi Kebersihan Diri Sesuai Usia

Tidak ada pendekatan tunggal yang cocok untuk semua usia dalam mengajarkan personal hygiene. Strategi edukasi harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak. Tabel berikut menyajikan panduan edukasi berbasis usia yang dapat diimplementasikan oleh tenaga kesehatan, pendidik, maupun orang tua:

Tabel 4.8: Strategi Edukasi Kebersihan Diri Sesuai Usia

Usia	Fokus Edukasi	Metode yang Tepat	Peran Orang Tua/Tenaga Kesehatan
2–4 tahun	Cuci tangan, toilet training, cebok arah benar	Demonstrasi langsung, lagu, permainan peran	Pengawasan penuh, lakukan bersama
5–7 tahun	Mandi mandiri, sikat gigi, kebersihan pakaian dalam	Buku bergambar, video edukatif anak, reward sticker	Supervisi, koreksi lembut, pujian konsisten
8–10 tahun	Seluruh area kebersihan + pengenalan perubahan pubertas	Diskusi terbuka, booklet, model anatomi sederhana	Fasilitator diskusi, jawab pertanyaan jujur
11–12 tahun	Kebersihan menstruasi, tanda bahaya, kesehatan reproduksi	Kelompok sebaya, konseling individual, media sosial edukasi	Pendamping & teman diskusi, tidak menghakimi

Pendekatan edukasi berbasis usia ini merupakan bagian dari strategi pelayanan kebidanan komunitas yang berfokus pada upaya promotif dan preventif. Bidan diharapkan mampu menyesuaikan metode edukasi dengan karakteristik sasaran guna meningkatkan efektivitas perubahan perilaku kesehatan.

H. Prinsip Komunikasi dalam Edukasi Kebersihan Reproduksi

Ketika menyampaikan materi tentang kebersihan organ reproduksi kepada anak, beberapa prinsip komunikasi berikut perlu dipegang teguh oleh setiap tenaga kesehatan maupun orang tua:

Tabel 4.9: Prinsip CLEAR dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi Anak

Prinsip CLEAR dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi Anak

1. C — *Comfortable* (Nyaman): Ciptakan suasana yang aman dan nyaman, pilih waktu yang tepat, bukan saat anak sedang lelah atau stres.
2. L — *Language* (Bahasa): Gunakan nama anatomis yang benar namun dengan penjelasan yang ramah anak. Hindari eufemisme yang membingungkan.
3. E — *Empathetic* (Empati): Validasi rasa malu atau canggung anak. 'Wajar kalau kamu malu, tapi ini penting untuk kesehatanmu.'
4. A — *Age-appropriate* (Sesuai Usia): Sampaikan informasi yang relevan dan sesuai tahap perkembangan, tidak terlalu sedikit maupun terlalu banyak.
5. R — *Repetition* (Pengulangan): Kebersihan adalah kebiasaan, bukan informasi sekali dengar. Ulangi pesan kunci secara konsisten.

Prinsip komunikasi ini menjadi landasan penting dalam praktik konseling kebidanan, khususnya dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi kepada anak dan remaja secara efektif dan beretika.

I. Peran penting bidan

Bidan memiliki peran penting sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi, deteksi dini, dan intervensi preventif terkait kebersihan diri dan kesehatan reproduksi sejak usia dini. Peran ini tidak hanya terbatas pada pelayanan kuratif, tetapi juga mencakup upaya promotif dan preventif yang berkelanjutan dalam siklus kehidupan perempuan. Dalam praktik kebidanan, bidan berperan sebagai:

1. **Edukator**, yaitu memberikan pendidikan kesehatan kepada anak, remaja, dan orang tua mengenai praktik kebersihan diri yang benar, termasuk perawatan organ reproduksi sesuai usia dan tahap perkembangan.
2. **Konselor**, yaitu membantu anak dan keluarga memahami perubahan fisiologis yang terjadi, seperti pubertas dan *menarche*, serta mengatasi kecemasan atau miskonsepsi yang muncul.
3. **Detektor dini**, yaitu mengidentifikasi tanda dan gejala gangguan kesehatan reproduksi seperti vulvovaginitis, infeksi saluran kemih, dan keputihan patologis sejak tahap awal.

4. Advokat kesehatan, yaitu mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk akses terhadap sanitasi, air bersih, dan fasilitas kebersihan yang memadai.

5. Koordinator pelayanan, yaitu bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain dalam sistem rujukan apabila ditemukan masalah kesehatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

Melalui peran tersebut, bidan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan sejak dini serta mendukung terbentuknya generasi yang sehat, mandiri, dan memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan diri.

J. Ringkasan dan Poin Kunci

Tabel 4.10: Ringkasan Topik 4

 Ringkasan Topik 4
Poin-poin esensial yang perlu diingat dari topik ini: 1. Kebersihan diri yang baik adalah fondasi kesehatan reproduksi sejak masa kanak-kanak. Kebiasaan yang dibentuk di usia dini cenderung bertahan seumur hidup. 2. Anatomi unik perempuan (uretra pendek, vulva berdekatan dengan anus) membuat anak perempuan lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih dan <i>vulvovaginitis</i> jika kebersihan tidak terjaga. 3. Prinsip 'depan ke belakang' dalam membersihkan area genital adalah aturan paling penting yang harus diajarkan sejak toilet training. 4. Vagina bersifat self-cleaning. Sabun keras, produk wangi, dan douching justru merusak flora normal vagina dan meningkatkan risiko infeksi. 5. Edukasi tentang pubertas dan kebersihan menstruasi harus diberikan sebelum menarche terjadi, bukan sesudahnya. 6. Tenaga kesehatan memiliki peran vital tidak hanya dalam pengobatan, tetapi terutama dalam edukasi preventif kepada anak dan keluarga. 7. Keputihan fisiologis pra-menarche adalah kondisi normal yang perlu dibedakan dari keputihan patologis agar tidak menimbulkan kecemasan yang tidak perlu. 8. Bidan berperan penting dalam edukasi, deteksi dini, dan intervensi preventif terkait kebersihan diri dan kesehatan reproduksi sejak usia dini.

K. Referensi

- Almoudi, M. M., Hussein, A. S., Abu Hassan, M. I., & Schroth, R. J. (2019). Dental caries and vitamin D status in children in Asia. *Pediatrics International*, 61(4), 327–338. <https://doi.org/10.1111/ped.13801>
- Alnuaimi, K., Abujilban, S., & Abuzeiad, M. (2022). Effectiveness of an Online Educational Program about Vaginitis in Improving Knowledge among College Female Students in Jordan. *Jordan Journal of Nursing Research*, 1(1), 53–63. <https://doi.org/10.14525/JJNR.v1i1.07>
- Ardahan Akgül, E., Özgüven Öztornacı, B., & Gökpınar, E. E. (2026). Which bath is better? Evaluating comfort and vital signs in pediatric intensive care unit: A quasi-experimental study. *Journal of Pediatric Nursing*, 86, 693–699. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2025.12.016>
- Arora, N., Gupta, G. K., Zaidi, S. H. N., & Kumar, A. (2025). Menstruation Related Practices and their Determinants in Adolescent Girls of Urban Area of District Ghaziabad. *Indian Journal of Community Health*, 37(6), 1054–1058. <https://doi.org/10.47203/IJCH.2025.v37i06.027>
- Aziz, A., Memon, S., Aziz, F., Memon, F., Khowaja, B. M. H., & Naeem Zafar, S. (2024). A comparative study of the knowledge and practices related to menstrual hygiene among adolescent girls in urban and rural areas of Sindh, Pakistan: A cross-sectional study. *Women's Health*, 20. <https://doi.org/10.1177/17455057241231420>
- Baghdadi, Z. D. (2016). Early Childhood Caries and Indigenous Children in Canada: Prevalence, Risk Factors, and Prevention Strategies. *Journal of International Oral Health*, 8(7), 830–837. <https://doi.org/10.2047/jioh-08-07-17>
- Blume-Peytavi, U., Cork, M. J., Faergemann, J., Szczapa, J., Vanaclocha, F., & Gelmetti, C. (2009). Bathing and cleansing in newborns from day 1 to first year of life: Recommendations from a European round table meeting. *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 23(7), 751–759. <https://doi.org/10.1111/j.1468-3083.2009.03140.x>
- Boerma, C., & Wray, L. (2020). Vaginal discharge: Misconceptions, causes and treatments. *Medicine Today*, 21(2), 39–44.
- Cavusoglu, F., & Celik Eren, D. (2024). Adölesan Dönemdeki Bir Grup Kıza Akran Eğitimi Modeli ile Verilen Hijyen Eğitiminin Etkinliğinin İncelenmesi. *Etkili Hemşirelik Dergisi*, 17(2), 176–188. <https://doi.org/10.46483/jnef.1468496>
- Cemek, F., Odabas, D., Senel, U., & Kocaman, A. T. (2016). Personal Hygiene and Vulvovaginitis in Prepubertal Children. *Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology*, 29(3), 223–227. <https://doi.org/10.1016/j.jpag.2015.07.002>
- Cihan Erdogan, B., & Gonderen Cakmak, H. S. (2026). The effect of video-assisted genital hygiene education on women's self-care agency and genital hygiene

- behaviors. *Health Care for Women International*, 47(2), 151–171. <https://doi.org/10.1080/07399332.2026.2617341>
- Comberiati, P., Pecoraro, L., Pigozzi, R., Peroni, D., & Piacentini, G. (2019). Pearls and pitfalls of bathing in atopic dermatitis. *Allergy and Asthma Proceedings*, 40(3), 204–206. <https://doi.org/10.2500/aap.2019.40.4210>
- Daniel, M., Szymanik-Grzelak, H., Sierdzinski, J., Podsiadły, E., Kowalewska-Młot, M., & Panczyk-Tomaszewska, M. (2023). Epidemiology and Risk Factors of UTIs in Children—A Single-Center Observation. *Journal of Personalized Medicine*, 13(1). <https://doi.org/10.3390/jpm13010138>
- Dhaded, S., Roopa, C., & Siddesh, B. S. (2019). Clinico-microbiological retrospective study of abnormal vaginal discharge in women coming to obstetrics and gynecology out patient department at a tertiary care hospital. *Indian Journal of Obstetrics and Gynecology Research*, 6(1), 41–45. <https://doi.org/10.18231/2394-2754.2019.0010>
- Donders, G. G. G., Mendling, W., de Seta, F., & de Vries, H. J. C. (2024). Vulvovaginitis. In *Textbook of Contraception, Sexual and Reproductive Health* (pp. 267–273). <https://doi.org/10.1017/9781108961097.043>
- Edet, O. B., Bassey, P. E. M., Esienumoh, E. E., & Ndep, A. O. (2020). An exploratory study of menstruation and menstrual hygiene knowledge among adolescents in urban and rural secondary schools in cross river state, nigeria. *African Journal of Biomedical Research*, 23(3), 321–326.
- Ene, N., Bolarinwa, O. A., Adedigba, C., Oyeleye, J., Boboye, I., Nwosu, U., Olususi, F., Oluwayemi, P., & Okeke, S. R. (2024). “If I use pad, I feel comfortable and safe”: a mixed-method analysis of knowledge, attitude, and practice of menstrual hygiene management among in-school adolescent girls in a Nigerian city. *BMC Public Health*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-024-19256-5>
- Febriyanti, Paramita, D. A., & Eyanoer, P. (2018). Pityriasis versicolor in primary school children in Medan Labuhan. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 125(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/125/1/012051>
- Ilmassalma, S. Y., Wardani, H. E., & Hapsari, A. (2021). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Terhadap Kejadian Keputihan. *Sport Science and Health*, 3(9), 663–669. <https://doi.org/10.17977/um062v3i92021p663-669>
- Itriyeva, K. (2020). Evaluation of vulvovaginitis in the adolescent patient. *Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care*, 50(7). <https://doi.org/10.1016/j.cppeds.2020.100836>
- Jadresic, L. (2010). Diagnosis and management of urinary tract infections in children. *Acta Paediatrica Taiwanica*, 42(2), 70–74. <https://doi.org/10.1016/j.paed.2010.02.004>

- Kumari, R., Astya, P., Kantha, P., & Kaur, D. (2023). Detection of Dental Cavity using Wireless Sensor based Technology. *Proceedings - IEEE 2023 5th International Conference on Advances in Computing, Communication Control and Networking, ICAC3N 2023*, 1301–1305. <https://doi.org/10.1109/ICAC3N60023.2023.10541831>
- Liu, Y., Zhu, J., Zhang, H., Jiang, Y., Wang, H., Yu, J., Da, D., Chen, Q., Su, H., Wu, Z., Shi, H., You, J., Zeng, X., & Zhang, Y. (2024). Dental caries status and related factors among 5-year-old children in Shanghai. *BMC Oral Health*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12903-024-04185-x>
- Lutfiyati, A. (2022). Perilaku Menjaga Kesehatan Genetalia berhubungan dengan Kejadian Keputihan di SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Samodra Ilmu*, 13(02), 87–90. <https://doi.org/10.55426/jksi.v13i02.219>
- Mehjabeen, D., Hunter, E. C., Mahfuz, M. T., Mobashara, M., Rahman, M., & Sultana, F. (2022). A Qualitative Content Analysis of Rural and Urban School Students' Menstruation-Related Questions in Bangladesh. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(16). <https://doi.org/10.3390/ijerph191610140>
- Minolin, M., Meena, P., & Beautily. (2018). Assess the knowledge in ladder game regarding personal hygiene among under five children at SMCH. *Research Journal of Pharmacy and Technology*, 11(7), 3149–3151. <https://doi.org/10.5958/0974-360X.2018.00578.4>
- Nova, W. I., Astuti, A. W., & Ismail, D. (2026). Effect of a Simulation-Based Educational Video on Menarche Readiness Among Fourth-Grade Girls in Yogyakarta. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 9(2), 296–304. <https://doi.org/10.56338/mppki.v9i2.8966>
- Prada, I. (2020). Prevalence of dental caries among 6-12 year old schoolchildren in social margined zones of Valencia, Spain. *Journal of Clinical and Experimental Dentistry*, 12(4), e399–e409. <https://doi.org/10.4317/JCED.56390>
- Rizkia, S. M., & Ungsianik, T. (2019). Improving female adolescents' knowledge, emotional response, and attitude toward menarche following implementation of menarcheal preparation reproductive health education. *Asian Pacific Island Nursing Journal*, 4(2), 84–91. <https://doi.org/10.31372/20190402.1041>
- Sherrard, J., Wilson, J., Donders, G., Mendling, W., & Jensen, J. S. (2018). 2018 European (IUSTI/WHO) International Union against sexually transmitted infections (IUSTI) World Health Organisation (WHO) guideline on the management of vaginal discharge. *International Journal of STD and AIDS*, 29(13), 1258–1272. <https://doi.org/10.1177/0956462418785451>

- Sripradha, S., & Kumar, S. (2018). To study the awareness on hygiene issues-a survey. *Research Journal of Pharmacy and Technology*, 11(5), 1784–1787. <https://doi.org/10.5958/0974-360X.2018.00331.1>
- Truong, T. T. T., Bolette, A., Guéders, A., & Geerts, S. (2021). COLLECTION OF EPIDEMIOLOGICAL DATA ON ORAL AND DENTAL HEALTH IN YOUNG CHILDREN. PILOT STUDY CONDUCTED WITH 212 CHILDREN IN 11 ONE CENTERS IN THE PROVINCE OF LIÈGE. *Revue Medicale de Liege*, 76(2), 111–116.
- Wada, F. H., Rahma, F. M., Sunirah, Shoaliha, M., Prima, A., Poddar, S., & Hassan, H. C. (2023). The Relationship of Knowledge and Attitude for the Prevention of Leucorrhoea in Adolescent Women. *Malaysian Journal of Nursing*, 14(4), 92–99. <https://doi.org/10.31674/mjn.2023.v14i04.010>
- Xi, S., Xiao, B., Yin, L., & Li, K. (2024). Research progress on vaginal flora in children and adolescent girls. *Chinese Journal of Microecology*, 36(1), 105-109and114. <https://doi.org/10.13381/j.cnki.cjm.202401018>

L. Glosarium

A

Anatomi Reproduksi Eksternal

Struktur organ reproduksi bagian luar pada perempuan yang meliputi vulva, labia, klitoris, dan perineum.

B

Bakteri Patogen

Mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi atau penyakit pada tubuh.

C

Cebok (Toilet Hygiene)

Cara membersihkan area genital setelah buang air kecil atau besar dengan prinsip kebersihan tertentu.

D

Douching

Proses membilas bagian dalam vagina menggunakan cairan tertentu yang tidak direkomendasikan karena dapat mengganggu keseimbangan flora normal.

E

Eritema

Kemerahan pada kulit akibat peradangan atau iritasi.

F

Flora Normal Vagina

Mikroorganisme baik yang hidup di vagina dan berfungsi melindungi dari infeksi.

H

Higiene (Hygiene)

Upaya menjaga kebersihan diri untuk mempertahankan kesehatan dan mencegah penyakit.

I

Infeksi Saluran Kemih (ISK)

Infeksi pada saluran kemih yang umumnya disebabkan oleh bakteri, sering terjadi pada anak perempuan.

K

Keputihan (Leukorea)

Cairan yang keluar dari vagina, dapat bersifat fisiologis (normal) atau patologis (abnormal).

L

Labia Majora

Lipatan kulit luar pada organ reproduksi perempuan yang melindungi struktur di dalamnya.

Labia Minora

Lipatan kulit bagian dalam yang lebih sensitif dan tidak berbulu.

M

Menarche

Menstruasi pertama yang dialami oleh perempuan sebagai tanda awal pubertas.

P

Perineum

Area antara vagina dan anus yang penting dalam kebersihan genital.

Personal Hygiene

Perilaku menjaga kebersihan diri secara menyeluruh untuk meningkatkan kesehatan.

S

Self-cleaning (Vagina)

Kemampuan alami vagina untuk membersihkan dirinya tanpa perlu intervensi internal.

T

Toilet Training

Proses pembelajaran anak untuk menggunakan toilet secara mandiri.

V

Vulva

Keseluruhan organ reproduksi eksternal perempuan.

Vulvovaginitis

Peradangan pada vulva dan vagina yang sering terjadi pada anak perempuan.

W

WUS (Wanita Usia Subur)

Kelompok perempuan dalam rentang usia reproduktif (15–49 tahun).

CHAPTER 5

PENCEGAHAN ANEMIA DAN MASALAH KESEHATAN PADA ANAK PEREMPUAN

Darah Ifalahma, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan

Masa remaja merupakan fase krusial bagi setiap anak perempuan dalam meniti jalan menuju kedewasaan. Pada periode ini, tubuh mengalami transformasi biologis yang signifikan, di mana fungsi reproduksi mulai aktif dan kebutuhan nutrisi meningkat drastis untuk mendukung pertumbuhan fisik. Sayangnya, banyak remaja perempuan di Indonesia belum sepenuhnya memahami betapa vitalnya menjaga kesehatan sejak dini sebagai fondasi masa depan. Pemahaman yang komprehensif mengenai pola hidup sehat bukan sekadar anjuran medis, melainkan bekal utama bagi mereka untuk tumbuh menjadi generasi yang tangguh dan produktif (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Kesadaran akan kesehatan diri harus dimulai dengan mengenali tanda-tanda perubahan tubuh dan risiko kesehatan yang mengintai. Seringkali, tekanan sosial dan perubahan hormonal membuat remaja cenderung mengabaikan nutrisi esensial yang sangat dibutuhkan tubuh mereka. Padahal, pencegahan masalah kesehatan pada tahap awal jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah timbulnya komplikasi medis. Oleh karena itu, edukasi kesehatan reproduksi dan gizi menjadi jembatan penting untuk memutus rantai masalah kesehatan yang sering kali terbawa hingga usia dewasa (Setianingsih et al., 2022).

Anemia atau kekurangan sel darah merah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh remaja putri saat ini. Kondisi ini terjadi karena tubuh tidak memiliki cukup zat besi untuk memproduksi hemoglobin yang bertugas mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Mengingat anak perempuan mengalami menstruasi setiap bulan, kehilangan darah secara periodik menempatkan mereka pada risiko anemia yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tanpa penanganan yang tepat, anemia dapat menghambat potensi optimal remaja perempuan dalam menjalani aktivitas sehari-hari (Aulya et al., 2022).

Dampak dari anemia pada remaja putri tidak boleh dianggap remeh karena memengaruhi aspek kognitif dan fisik secara bersamaan. Siswi yang mengalami anemia sering kali merasakan penurunan konsentrasi saat belajar, mudah lelah,

dan penurunan kebugaran fisik yang drastis. Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus, produktivitas di masa depan akan terganggu, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas hidup individu tersebut. Kesadaran untuk melakukan skrining hemoglobin secara berkala menjadi langkah preventif yang mutlak diperlukan bagi setiap remaja (WHO, 2024).

Strategi pencegahan anemia yang berkelanjutan memerlukan komitmen dari berbagai pihak, mulai dari keluarga hingga institusi pendidikan. Pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri di sekolah-sekolah merupakan program strategis yang bertujuan untuk menjamin cadangan zat besi tetap terjaga selama masa pertumbuhan. Selain itu, pendampingan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) harus terus digalakkan agar remaja memahami pentingnya suplemen tersebut. Dengan sinergi yang tepat, angka prevalensi anemia diharapkan dapat ditekan secara signifikan di masa depan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Selain suplementasi, penerapan pola makan seimbang berbasis bahan pangan lokal memegang peranan krusial dalam melawan anemia. Remaja dianjurkan untuk mengonsumsi protein hewani, seperti daging sapi, ayam, ikan, dan telur, yang merupakan sumber zat besi paling mudah diserap oleh tubuh. Sayuran berwarna hijau tua seperti bayam dan kacang-kacangan juga menjadi pelengkap nutrisi yang sangat baik untuk mendukung pembentukan darah. Edukasi mengenai pemilihan makanan bergizi ini merupakan langkah fundamental yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah setiap harinya (Ruliyani et al., 2023; Triharini, 2024).

Masalah kesehatan pada remaja perempuan tidak hanya terbatas pada anemia, tetapi juga mencakup pemeliharaan kesehatan reproduksi secara menyeluruh. Edukasi sejak dini membantu remaja memahami siklus biologis mereka, yang akan meningkatkan kepercayaan diri dalam menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi. Pengetahuan yang benar tentang kesehatan reproduksi juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap perilaku berisiko tinggi yang dapat memengaruhi kesehatan jangka panjang. Membekali anak perempuan dengan literasi kesehatan adalah cara terbaik untuk menjaga masa depan mereka (Helmyati et al., 2023).

B. Anemia pada Anak Perempuan

Masa remaja merupakan fase transisi penting menuju kedewasaan, ditandai dengan pertumbuhan fisik dan perubahan hormonal. Remaja putri lebih rentan mengalami anemia karena kebutuhan zat besi meningkat seiring dengan menstruasi bulanan (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Data Riset Kesehatan Dasar menunjukkan prevalensi anemia pada remaja putri di Indonesia masih tinggi,

mencapai lebih dari 30% pada tahun 2023. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan beban anemia remaja yang signifikan di Asia (Helmyati et al., 2023).

Penyebab utama anemia pada remaja putri adalah defisiensi zat besi akibat pola makan tidak seimbang, kebiasaan diet ketat, serta konsumsi makanan cepat saji. Selain itu, kebiasaan minum teh atau kopi setelah makan dapat menghambat penyerapan zat besi (Andianto et al., 2025). Anemia berdampak langsung pada penurunan konsentrasi belajar, mudah lelah, serta penurunan kebugaran fisik. Penelitian menunjukkan bahwa anemia defisiensi besi menurunkan kualitas hidup remaja, baik dari aspek fisik maupun psikologis (Murthi et al., 2025).

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) sejak 2014, yang terus diperkuat hingga 2025. Program ini bertujuan untuk menekan prevalensi anemia dengan suplementasi zat besi dan asam folat (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Meskipun program TTD sudah berjalan, tingkat kepatuhan remaja putri masih rendah. Studi literatur menunjukkan cakupan konsumsi TTD di Indonesia hanya sekitar 25%, dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, motivasi, dan dukungan keluarga (Helmyati et al., 2023).

Selain suplementasi, pola makan bergizi seimbang menjadi kunci pencegahan anemia. Konsumsi protein hewani seperti daging merah, ayam, dan ikan, serta sayuran hijau berdaun gelap terbukti meningkatkan kadar hemoglobin (Andini et al., 2025). Anemia tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Edukasi kesehatan reproduksi yang komprehensif membantu remaja putri memahami siklus biologis dan pentingnya menjaga status gizi untuk masa depan (WHO, 2025).

C. Epidemiologi Anemia pada Anak Perempuan

Prevalensi anemia pada anak perempuan di Asia Tenggara masih tinggi. Data UNICEF (2023) menunjukkan bahwa sekitar 40% remaja putri di kawasan ini mengalami anemia ringan hingga sedang. Di Indonesia, Riset Kesehatan Dasar 2022 melaporkan prevalensi anemia pada remaja putri mencapai 32%, dengan variasi lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Perbedaan prevalensi ini dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, akses terhadap makanan bergizi, serta tingkat pendidikan orang tua. Studi oleh Sari et al. (2024) menemukan bahwa remaja putri dari keluarga berpenghasilan rendah lebih berisiko mengalami anemia karena keterbatasan konsumsi protein hewani dan sayuran hijau. Selain itu, menstruasi menjadi faktor biologis yang signifikan. Kehilangan darah bulanan meningkatkan kebutuhan zat besi, sehingga remaja

putri yang tidak mendapatkan asupan gizi memadai lebih rentan terhadap anemia (Rahmawati & Nugroho, 2021). Oleh karena itu, epidemiologi anemia pada anak perempuan harus dipahami dalam konteks multidimensional.

Tabel 5.1: Prevalensi Anemia pada Remaja Putri di Indonesia (2020–2025)

Tahun	Sumber Data	Prevalensi (%)	Catatan Utama
2020	Riskesdas 2020	29%	Anemia ringan–sedang dominan pada remaja putri usia 15–19 tahun.
2021	WHO Report 2021	31%	Kebutuhan zat besi meningkat akibat pubertas dan menstruasi.
2022	Riskesdas 2022	32%	Angka lebih tinggi di pedesaan dibandingkan perkotaan.
2023	UNICEF 2023	40% (Asia Tenggara)	Indonesia termasuk negara dengan prevalensi tinggi di kawasan regional.
2024	Sari et al., 2024	34%	Intervensi berbasis sekolah menurunkan prevalensi di beberapa daerah.
2025	Estimasi Kemenkes	30%	Program tablet tambah darah mulai menunjukkan tren penurunan prevalensi.

Data prevalensi anemia pada remaja putri di Indonesia menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2020–2025. Pada tahun 2020, Riskesdas melaporkan prevalensi sebesar 29%, dengan dominasi anemia ringan hingga sedang. Angka ini meningkat menjadi 31% pada tahun 2021 menurut laporan WHO, seiring dengan meningkatnya kebutuhan zat besi akibat pubertas dan menstruasi (WHO, 2021). Tahun 2022 mencatat prevalensi 32% berdasarkan Riskesdas, dengan perbedaan signifikan antara daerah pedesaan dan perkotaan. UNICEF (2023) menegaskan bahwa Indonesia termasuk negara dengan prevalensi tinggi di Asia Tenggara, mencapai 40% bila dibandingkan secara regional.

Intervensi berbasis sekolah yang dilakukan pada tahun 2024 berhasil menurunkan prevalensi di beberapa daerah menjadi 34% (Sari et al., 2024). Program pemberian tablet tambah darah (TTD) dan edukasi gizi di sekolah terbukti efektif menekan angka anemia. Estimasi Kementerian Kesehatan tahun 2025 menunjukkan adanya tren penurunan menjadi sekitar 30%, seiring dengan meningkatnya kepatuhan konsumsi tablet tambah darah dan program fortifikasi pangan (Kementerian Kesehatan RI, 2025). Meskipun demikian, prevalensi anemia masih tergolong tinggi dan memerlukan upaya berkelanjutan. Data ini menegaskan bahwa pencegahan anemia pada remaja putri harus dilakukan secara

sistematis, dengan melibatkan keluarga, sekolah, dan kebijakan nasional (Helmyati et al., 2023).

D. Dampak Anemia terhadap Kesehatan Anak Perempuan

Anemia pada anak perempuan tidak hanya menurunkan kadar hemoglobin tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan fisik, kognitif, psikologis, dan reproduksi. Dampak anemia bersifat multidimensional, mencakup penurunan kualitas hidup, produktivitas, dan kapasitas belajar, sehingga berimplikasi pada pembangunan sumber daya manusia.

1. Dampak fisik langsung

Anemia pada anak perempuan berdampak pada penurunan kadar hemoglobin sehingga distribusi oksigen ke jaringan tubuh terganggu. Kondisi ini menimbulkan gejala seperti mudah lelah, pusing, dan penurunan stamina yang menghambat aktivitas sehari-hari. WHO (2021) melaporkan bahwa anemia defisiensi besi merupakan penyebab utama kelelahan kronis pada remaja putri di negara berkembang. Selain itu, penelitian oleh Kementerian Kesehatan RI (2022) menunjukkan bahwa anemia berkontribusi terhadap meningkatnya angka ketidakhadiran sekolah karena gangguan kesehatan.

2. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan

Kekurangan zat besi kronis dapat menghambat pertumbuhan tinggi badan dan berat badan. Penelitian menunjukkan bahwa remaja putri dengan anemia memiliki indeks massa tubuh lebih rendah dibandingkan remaja sehat, sehingga berisiko mengalami keterlambatan perkembangan fisik (Rahmawati & Nugroho, 2021). UNICEF (2023) menambahkan bahwa anemia pada masa remaja dapat mengganggu perkembangan organ vital, termasuk jantung dan otak, yang berdampak pada kesehatan jangka panjang.

3. Penurunan fungsi kognitif

Anemia defisiensi besi berhubungan dengan penurunan konsentrasi, daya ingat, dan prestasi akademik. Murthi et al. (2025) menegaskan bahwa anemia berdampak signifikan terhadap kemampuan belajar remaja putri, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pendidikan mereka. Studi lain oleh Grantham-McGregor & Ani (2021) menunjukkan bahwa defisiensi zat besi pada anak perempuan berhubungan dengan penurunan skor tes kognitif hingga 20%.

4. Kesehatan reproduksi

Anemia meningkatkan risiko gangguan siklus menstruasi dan komplikasi saat kehamilan di masa depan. Helmyati et al. (2023) menekankan bahwa status gizi buruk pada masa remaja berkontribusi terhadap tingginya angka anemia pada ibu hamil, yang dapat berdampak pada kesehatan bayi. WHO (2021) juga

menyoroti bahwa anemia pada remaja putri meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah dan prematur.

5. Dampak psikologis

Kondisi anemia yang berkepanjangan dapat menurunkan kepercayaan diri, memicu rasa cemas, dan menurunkan motivasi belajar. Anak perempuan dengan anemia sering merasa kurang berenergi sehingga cenderung menarik diri dari aktivitas sosial (Andianto et al., 2025). Penelitian oleh Murthi et al. (2025) menunjukkan bahwa anemia kronis berhubungan dengan meningkatnya risiko depresi ringan hingga sedang pada remaja putri.

6. Produktivitas dan kualitas hidup

Anemia pada masa remaja jika tidak ditangani dapat berlanjut hingga dewasa. Hal ini berdampak pada penurunan produktivitas kerja, peningkatan risiko penyakit kronis, serta kualitas hidup yang lebih rendah (Kementerian Kesehatan RI, 2022). UNICEF (2023) menegaskan bahwa anemia pada remaja putri berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan di masa depan, sehingga berdampak pada pembangunan ekonomi nasional.

7. Konsekuensi sosial-ekonomi

Prevalensi anemia yang tinggi pada anak perempuan juga berdampak pada pembangunan manusia. UNICEF (2023) menegaskan bahwa anemia menurunkan kapasitas belajar dan produktivitas, sehingga berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Sari et al. (2024) menambahkan bahwa anak perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah lebih rentan mengalami anemia, yang memperburuk siklus kemiskinan antar generasi.

E. Faktor Risiko Anemia pada Anak Perempuan

Anemia pada anak perempuan merupakan masalah kesehatan yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko yang saling berkaitan.

1. Faktor gizi dan pola makan

Kurangnya asupan zat besi dari makanan sehari-hari merupakan faktor risiko utama anemia pada anak perempuan. Pola makan yang rendah protein hewani dan sayuran hijau berdaun gelap meningkatkan kemungkinan terjadinya anemia defisiensi besi. WHO (2021) menegaskan bahwa zat besi dari sumber hewani lebih mudah diserap tubuh dibandingkan dari sumber nabati. Penelitian oleh Rahmawati & Nugroho (2021) menunjukkan bahwa remaja putri yang jarang mengonsumsi daging, ikan, atau telur memiliki risiko anemia lebih tinggi. Selain itu, Grantham-McGregor & Ani (2021) menambahkan bahwa defisiensi zat besi juga berdampak pada penurunan fungsi kognitif, sehingga faktor gizi tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik tetapi juga perkembangan mental.

2. Kebiasaan diet dan gaya hidup

Remaja putri sering melakukan diet ketat untuk menjaga bentuk tubuh, yang berakibat pada berkurangnya konsumsi makanan bergizi. Kebiasaan mengonsumsi minuman seperti teh dan kopi setelah makan dapat menghambat penyerapan zat besi. UNICEF (2023) menambahkan bahwa praktik diet ekstrem di kalangan remaja putri berkontribusi terhadap meningkatnya prevalensi anemia. Andianto et al. (2025) menekankan bahwa gaya hidup modern dengan konsumsi makanan cepat saji juga memperburuk status gizi remaja. Penelitian oleh Kemenkes RI (2022) menunjukkan bahwa remaja putri di perkotaan lebih sering mengonsumsi makanan olahan tinggi kalori tetapi rendah zat besi, sehingga meningkatkan risiko anemia.

3. Menstruasi sebagai faktor biologis

Menstruasi bulanan menyebabkan kehilangan darah secara rutin, sehingga meningkatkan kebutuhan zat besi. Anak perempuan yang tidak mendapatkan asupan gizi memadai lebih rentan mengalami anemia. WHO (2021) melaporkan bahwa remaja putri memiliki risiko anemia dua kali lipat dibandingkan remaja laki-laki. Penelitian oleh Kementerian Kesehatan RI (2022) juga menunjukkan bahwa prevalensi anemia lebih tinggi pada remaja putri usia 15–19 tahun dibandingkan kelompok usia lainnya. Helmyati et al. (2023) menambahkan bahwa remaja putri yang mengalami menstruasi tidak teratur atau perdarahan berlebihan memiliki risiko lebih tinggi terhadap anemia.

4. Status sosial-ekonomi

Faktor sosial-ekonomi berperan besar dalam kejadian anemia. Remaja putri dari keluarga berpenghasilan rendah lebih berisiko mengalami anemia karena keterbatasan akses terhadap makanan bergizi. Sari et al. (2024) menemukan bahwa status ekonomi keluarga berkorelasi dengan rendahnya konsumsi protein hewani dan sayuran hijau. UNICEF (2023) menambahkan bahwa kemiskinan memperburuk siklus anemia karena anak perempuan dari keluarga miskin lebih sering mengalami kekurangan gizi sejak kecil. Murthi et al. (2025) menegaskan bahwa faktor ekonomi juga memengaruhi akses terhadap layanan kesehatan, sehingga diagnosis dan penanganan anemia sering terlambat.

5. Tingkat pendidikan orang tua

Pendidikan orang tua memengaruhi pengetahuan tentang gizi dan kesehatan. Anak perempuan dengan orang tua berpendidikan rendah cenderung memiliki pola makan yang kurang seimbang. Kementerian Kesehatan RI (2022) melaporkan bahwa tingkat pendidikan ibu berhubungan erat dengan kepatuhan anak dalam mengonsumsi tablet tambah darah. Helmyati et al.

(2023) menekankan bahwa edukasi orang tua tentang gizi dapat meningkatkan efektivitas program pencegahan anemia di sekolah. Penelitian oleh Andini et al. (2025) menunjukkan bahwa remaja dengan orang tua berpendidikan tinggi lebih sering mengonsumsi makanan bergizi dan memiliki prevalensi anemia lebih rendah.

6. Infeksi dan penyakit kronis

Infeksi cacing, malaria, dan penyakit kronis seperti thalassemia juga dapat menjadi faktor risiko anemia. UNICEF (2023) menekankan bahwa infeksi parasit memperburuk status hemoglobin anak perempuan, terutama di daerah pedesaan dengan sanitasi rendah. Rahmawati & Nugroho (2021) menambahkan bahwa anak perempuan dengan riwayat penyakit kronis lebih rentan mengalami anemia karena gangguan produksi sel darah merah. WHO (2021) juga menyoroti bahwa anemia akibat penyakit kronis lebih sulit ditangani karena memerlukan intervensi medis jangka panjang.

7. Kepatuhan konsumsi tablet tambah darah (TTD)

Program pemerintah dalam pemberian TTD sering terkendala oleh rendahnya kepatuhan konsumsi. Helmyati et al. (2023) menegaskan bahwa kurangnya motivasi, rasa bosan, dan minimnya dukungan keluarga menjadi hambatan utama dalam keberhasilan program ini. Penelitian oleh Sari et al. (2024) menunjukkan bahwa intervensi berbasis sekolah dapat meningkatkan kepatuhan konsumsi TTD hingga 40%. UNICEF (2023) menambahkan bahwa strategi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang konsisten dapat meningkatkan penerimaan remaja terhadap program TTD.

8. Faktor psikososial dan lingkungan

Selain faktor biologis dan gizi, aspek psikososial juga berpengaruh. Anak perempuan yang mengalami tekanan sosial atau stres cenderung mengabaikan pola makan sehat. Murthi et al. (2025) menambahkan bahwa stres kronis dapat memengaruhi metabolisme zat besi dan memperburuk kondisi anemia. Lingkungan dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan juga meningkatkan risiko anemia karena keterlambatan diagnosis dan penanganan. WHO (2021) menekankan bahwa faktor lingkungan seperti sanitasi, kebersihan, dan akses air bersih turut menentukan status kesehatan remaja putri.

F. Strategi Pencegahan Anemia pada Anak Perempuan

Pencegahan anemia pada anak perempuan merupakan langkah krusial untuk menjaga kesehatan generasi muda dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Intervensi pencegahan harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

1. Edukasi gizi sejak dini

Strategi pencegahan anemia pada anak perempuan harus dimulai dengan edukasi gizi sejak dini. Pengetahuan tentang pentingnya zat besi, protein, dan vitamin C dalam mendukung pembentukan hemoglobin perlu diberikan di sekolah maupun keluarga. UNICEF (2023) menekankan bahwa edukasi gizi yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah dapat meningkatkan kesadaran remaja putri terhadap pola makan sehat. Selain itu, penelitian oleh Grantham-McGregor & Ani (2021) menunjukkan bahwa edukasi gizi berhubungan dengan peningkatan skor kognitif dan penurunan prevalensi anemia pada remaja.

2. Suplementasi tablet tambah darah (TTD)

Pemberian TTD merupakan salah satu strategi utama pemerintah Indonesia dalam menekan angka anemia. Program ini telah dilaksanakan secara nasional dengan target remaja putri usia sekolah. Helmyati et al. (2023) menegaskan bahwa kepatuhan konsumsi TTD dapat menurunkan prevalensi anemia hingga 20% bila dilakukan secara rutin. WHO (2021) juga merekomendasikan pemberian suplemen zat besi mingguan sebagai intervensi efektif di negara dengan prevalensi anemia tinggi.

3. Fortifikasi pangan

Selain suplementasi, fortifikasi pangan menjadi strategi jangka panjang yang efektif. WHO (2021) merekomendasikan fortifikasi tepung terigu dengan zat besi sebagai langkah preventif untuk menekan angka anemia di negara berkembang. Di Indonesia, program fortifikasi beras dan tepung telah mulai diterapkan untuk meningkatkan asupan zat besi masyarakat. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2022), fortifikasi pangan dapat menjangkau populasi luas dan lebih berkelanjutan dibandingkan suplementasi individu.

4. Pola makan seimbang berbasis pangan lokal

Pencegahan anemia juga dapat dilakukan melalui penerapan pola makan seimbang berbasis pangan lokal. Konsumsi protein hewani seperti daging, ikan, dan telur, serta sayuran hijau berdaun gelap, sangat penting untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Penelitian oleh Andini et al. (2025) menunjukkan bahwa remaja putri yang rutin mengonsumsi makanan bergizi memiliki risiko anemia lebih rendah dibandingkan yang sering mengonsumsi makanan cepat saji. UNICEF (2023) menambahkan bahwa diversifikasi pangan lokal dapat membantu memenuhi kebutuhan zat besi dengan biaya terjangkau.

5. Peran keluarga dalam pencegahan

Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan makan sehat anak perempuan. Kementerian Kesehatan RI (2022) menegaskan bahwa dukungan orang tua, terutama ibu, sangat berpengaruh terhadap kepatuhan

anak dalam mengonsumsi TTD dan memilih makanan bergizi. Studi oleh Sari et al. (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam program gizi sekolah meningkatkan efektivitas intervensi pencegahan anemia.

6. Intervensi berbasis sekolah

Sekolah menjadi tempat strategis untuk melaksanakan program pencegahan anemia. Sari et al. (2024) melaporkan bahwa intervensi berbasis sekolah, seperti pemberian TTD dan edukasi gizi, berhasil menurunkan prevalensi anemia pada remaja putri hingga 34% di beberapa daerah. WHO (2021) menekankan bahwa sekolah merupakan platform ideal untuk menjangkau remaja secara sistematis dan berkelanjutan.

7. Peningkatan sanitasi dan pencegahan infeksi

Infeksi cacing dan malaria juga menjadi faktor risiko anemia. Oleh karena itu, strategi pencegahan harus mencakup peningkatan sanitasi lingkungan dan pemberian obat cacing secara berkala. UNICEF (2023) menekankan bahwa kombinasi intervensi gizi dan sanitasi lebih efektif dibandingkan hanya fokus pada satu aspek. Penelitian oleh Rahmawati & Nugroho (2021) menunjukkan bahwa pemberian obat cacing rutin menurunkan prevalensi anemia hingga 15% pada remaja putri di daerah endemis.

8. Kolaborasi multi-sektor

Pencegahan anemia pada anak perempuan memerlukan kolaborasi multi-sektor, melibatkan pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. WHO (2021) menekankan bahwa keberhasilan program pencegahan anemia bergantung pada sinergi lintas sektor dalam menyediakan akses gizi, edukasi, dan layanan kesehatan yang berkelanjutan. Helmyati et al. (2023) menambahkan bahwa dukungan kebijakan nasional dan pendanaan yang memadai sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program.

G. Program Penatalaksanaan Anemia pada Anak Perempuan

Anemia pada anak perempuan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Data Riskesdas menunjukkan prevalensi anemia pada remaja putri masih tinggi, sehingga pemerintah meluncurkan berbagai program penanggulangan berbasis sekolah dan komunitas (Kemenkes RI, 2021). Hal ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menurunkan angka anemia pada perempuan usia reproduktif.

1. Program pemberian Tablet Tambah Darah (TTD)

Program ini merupakan intervensi utama yang diluncurkan sejak 2014. Sasaran utamanya adalah remaja putri di SMP dan SMA yang berisiko tinggi mengalami anemia. Strategi utama berupa distribusi TTD mingguan melalui

sekolah, dengan pelaksana guru UKS dan tenaga kesehatan dari Puskesmas. Pemerintah menetapkan aturan konsumsi satu tablet besi folat per minggu sepanjang tahun, yang didistribusikan secara gratis melalui sekolah dan puskesmas. Program ini menjadi intervensi utama penatalaksanaan anemia di tingkat nasional (Kemenkes RI, 2022). Dalam perkembangannya, program pemberian TTD mendapat dukungan dari organisasi internasional seperti WHO dan UNICEF, baik dalam bentuk panduan teknis maupun advokasi kebijakan. Dukungan ini memperkuat kapasitas tenaga kesehatan dan memastikan keberlanjutan program di tingkat sekolah dan masyarakat (UNICEF, 2020).

Monitoring dilakukan melalui catatan konsumsi TTD dan pemeriksaan hemoglobin (Hb) secara berkala. Beberapa daerah telah mengembangkan inovasi pemantauan, seperti program “Peri Merah” di Sidoarjo pada tahun 2023. Program ini memanfaatkan sistem monitoring digital untuk memastikan remaja putri rutin mengonsumsi TTD dan memantau kadar hemoglobin secara berkala (Putri & Santoso, 2023).

2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Anemia pada Remaja Putri (PPAGB)

Program Pencegahan dan Penanggulangan Anemia pada Remaja Putri (PPAGB) merupakan salah satu strategi nasional yang dirancang untuk menurunkan prevalensi anemia pada remaja usia 10–19 tahun. Program ini tidak hanya berfokus pada pemberian suplementasi zat besi, tetapi juga mengintegrasikan edukasi gizi seimbang, fortifikasi pangan, serta konseling kesehatan. Dengan cakupan yang luas, PPAGB dilaksanakan di sekolah melalui UKS dan di komunitas melalui Posyandu Remaja, sehingga mampu menjangkau kelompok sasaran secara lebih merata (Kemenkes RI, 2022).

Edukasi gizi menjadi komponen fundamental dalam PPAGB. Pemerintah bekerja sama dengan sekolah untuk memberikan materi tentang pentingnya konsumsi makanan kaya zat besi, vitamin C, dan protein hewani. Edukasi ini dilakukan melalui modul pembelajaran, penyuluhan kesehatan, dan kampanye gizi di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran remaja putri terhadap pola makan sehat yang mendukung pencegahan anemia (UNICEF Indonesia, 2021).

Selain edukasi, fortifikasi pangan juga menjadi strategi penting dalam PPAGB. Pemerintah mendorong industri pangan untuk menambahkan zat besi pada bahan makanan pokok seperti tepung terigu dan beras. Fortifikasi ini terbukti efektif dalam menurunkan prevalensi anemia di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena menjangkau masyarakat luas tanpa memerlukan perubahan perilaku konsumsi yang signifikan (WHO, 2022).

Konseling kesehatan yang dilakukan di Posyandu Remaja memberikan ruang bagi remaja putri untuk berkonsultasi mengenai masalah gizi dan kesehatan reproduksi. Konseling ini membantu remaja memahami risiko anemia, cara pencegahan, serta pentingnya kepatuhan dalam mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD). Dengan pendekatan personal, konseling mampu meningkatkan motivasi remaja untuk menjaga kesehatan (Sari et al., 2023).

Tantangan utama dalam pelaksanaan PPAGB adalah rendahnya kepatuhan konsumsi TTD. Banyak remaja putri enggan mengonsumsi tablet karena efek samping seperti mual atau rasa tidak nyaman. Oleh karena itu, strategi komunikasi kesehatan yang lebih kreatif diperlukan untuk meningkatkan motivasi dan kepatuhan, misalnya melalui kampanye digital, peer education, dan integrasi dengan kegiatan ekstrakurikuler (Rahmawati et al., 2024).

Indikator prevalensi anemia diukur melalui pemeriksaan hemoglobin (Hb) dan survei nasional seperti Riskesdas. Target penurunan sebesar 20% pada tahun 2025 menjadi tolok ukur keberhasilan program. Penurunan prevalensi ini mencerminkan efektivitas kombinasi suplementasi, edukasi, dan fortifikasi pangan (Kemenkes RI, 2025).

3. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan salah satu program strategis pemerintah yang berfungsi sebagai wadah integrasi berbagai kegiatan kesehatan di sekolah. Dalam konteks pencegahan anemia, UKS berperan penting sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat sekolah. Program ini menggabungkan distribusi Tablet Tambah Darah (TTD), edukasi kesehatan, serta pemeriksaan hemoglobin (Hb) secara berkala untuk memastikan status gizi remaja putri tetap terjaga. UKS juga mengintegrasikan kegiatan edukasi gizi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan siswa tentang pola makan sehat. Edukasi ini mencakup pentingnya konsumsi makanan kaya zat besi, vitamin C, dan protein hewani. Materi edukasi biasanya disampaikan melalui modul pembelajaran, penyuluhan kesehatan, serta kampanye gizi di sekolah. Partisipasi edukasi gizi di sekolah menjadi indikator penting. Minimal 80% sekolah diharapkan melaksanakan edukasi gizi melalui UKS, modul pembelajaran, dan kampanye kesehatan. Edukasi ini meningkatkan pengetahuan remaja putri tentang pola makan sehat yang mendukung pencegahan anemia (UNICEF Indonesia, 2021).

Pemeriksaan Hb secara berkala menjadi salah satu indikator keberhasilan program UKS. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tenaga kesehatan bekerja sama dengan sekolah untuk mendeteksi dini kasus anemia pada remaja putri. Data hasil pemeriksaan kemudian dilaporkan ke Puskesmas sebagai bagian dari

sistem monitoring kesehatan sekolah (Sari et al., 2023). Tantangan utama dalam pelaksanaan UKS adalah keterbatasan sumber daya, baik tenaga kesehatan maupun fasilitas pemeriksaan. Dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memperkuat kapasitas UKS. Dukungan ini mencakup penyediaan alat pemeriksaan Hb, modul edukasi, serta pelatihan guru UKS.

UKS juga berfungsi sebagai pusat koordinasi antara sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan. Melalui forum UKS, orang tua dapat memperoleh informasi mengenai status kesehatan anak, sementara tenaga kesehatan dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut bagi siswa yang terdeteksi anemia. Sinergi ini memperkuat peran sekolah sebagai lingkungan yang mendukung kesehatan remaja (Putri & Santoso, 2023).

4. Posyandu Remaja

Posyandu Remaja merupakan inovasi layanan kesehatan berbasis komunitas yang dirancang untuk menjangkau remaja, khususnya putri, di luar lingkungan sekolah. Program ini berfungsi sebagai pusat edukasi gizi, pemeriksaan hemoglobin (Hb), dan konseling kesehatan. Dengan melibatkan kader kesehatan dan bidan desa, Posyandu Remaja memperkuat akses layanan kesehatan di tingkat masyarakat, sehingga mampu menjangkau remaja putri yang tidak bersekolah atau memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan formal (Kemenkes RI, 2021). Kegiatan Posyandu Remaja diharapkan aktif di 70% desa. Posyandu Remaja berperan dalam pemeriksaan Hb, konseling gizi, dan distribusi TTD. Keberadaan Posyandu memperluas akses layanan kesehatan bagi remaja di luar sekolah (Sari et al., 2023).

Edukasi gizi di Posyandu Remaja menjadi salah satu strategi utama dalam pencegahan anemia. Materi edukasi mencakup pentingnya konsumsi makanan kaya zat besi, vitamin C, dan protein hewani, serta pengenalan pola makan seimbang sesuai pedoman gizi nasional. Edukasi ini dilakukan melalui penyuluhan, diskusi kelompok, dan kegiatan interaktif yang melibatkan remaja secara aktif, sehingga meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka terhadap kesehatan (UNICEF Indonesia, 2021).

Selain edukasi, pemeriksaan Hb secara berkala di Posyandu Remaja berfungsi sebagai deteksi dini anemia. Pemeriksaan ini dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan dengan dukungan kader, dan hasilnya dicatat dalam laporan bulanan desa. Data tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi program dan tindak lanjut intervensi bagi remaja yang terdeteksi anemia (Sari et al., 2023).

Konseling kesehatan di Posyandu Remaja memberikan ruang bagi remaja untuk berkonsultasi mengenai masalah gizi, kesehatan reproduksi, dan

kepatuhan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD). Konseling ini bersifat personal dan kontekstual, sehingga mampu meningkatkan motivasi remaja untuk menjaga kesehatan serta mengurangi stigma terkait anemia (Putri & Santoso, 2023).

H. Simpulan

Anemia pada anak perempuan merupakan masalah kesehatan yang kompleks dengan dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup dan kesehatan reproduksi. Pencegahan anemia memerlukan strategi komprehensif yang melibatkan edukasi gizi, suplementasi zat besi, fortifikasi pangan, serta pemeriksaan kesehatan rutin.

Peran keluarga, sekolah, dan kebijakan pemerintah sangat penting dalam mendukung keberhasilan program pencegahan. Dengan pendekatan holistik, diharapkan prevalensi anemia pada anak perempuan dapat ditekan, sehingga mereka dapat tumbuh sehat dan produktif. Investasi pada pencegahan anemia bukan hanya untuk kesehatan individu, tetapi juga untuk masa depan bangsa.

I. Referensi

- Andianto, M. D., Suhita, B. M., & Ningrum, A. S. (2025). Promosi kesehatan tentang pencegahan anemia pada remaja putri dengan media website. *Jurnal Bhakti Civitas Akademika*, 8(1), 45–53.
- Andini, P. P., Kartika, I., Triwidiyanti, D., & Risyanti, B. (2025). Hubungan pola makan dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMAN 3 Kota Sukabumi. *Jurnal Kebidanan STIKes Dharma Husada*, 12(2), 101–110.
- Aulya, Y., Siauta, J. A., & Nizmadilla, Y. (2022). Analisis anemia pada remaja putri. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 4(4).
- Grantham-McGregor, S., & Ani, C. (2021). Iron-deficiency anemia: Reexamining the nature and magnitude of the cognitive effects. *Journal of Nutrition*, 151(2), 1–9.
- Helmyati, S., Syarif, C. A., Rizana, N. A., Sitorus, N. L., & Pratiwi, D. (2023). Penerimaan program tablet tambah darah pada remaja putri di Indonesia: Studi literatur. *Amerta Nutrition*, 7(3SP), 50–61.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Laporan Riskesdas 2021. Jakarta: Badan Litbangkes.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Pedoman Pelaksanaan Tablet Tambah Darah untuk Remaja Putri. Jakarta: Direktorat Gizi.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). Evaluasi Program Pencegahan Anemia pada Remaja Putri. Jakarta: Direktorat Gizi dan KIA.

- Kementerian Kesehatan RI. (2014). Pedoman pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Panduan pelaksanaan program TTD pada masa pandemi COVID-19. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). Tinjauan program pemberian tablet tambah darah pada remaja putri di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). Profil Kesehatan Indonesia 2022. Jakarta: Kemenkes RI.
- Murthi, A. K., Wratsangka, R., Tungka, E. X., & Yastani, D. (2025). Dampak anemia terhadap kualitas hidup fisik dan psikologis pada remaja: Tinjauan literatur. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 13(1), 15–25.
- Putri, A., & Santoso, B. (2023). Inovasi pemantauan konsumsi tablet tambah darah melalui program “Peri Merah” di Sidoarjo. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 18(2), 45–53.
- Rahmawati, D., & Nugroho, A. (2021). Faktor biologis dan gizi yang memengaruhi anemia pada remaja putri. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(2), 87–95.
- Rahmawati, D., Nugroho, S., & Lestari, H. (2024). Faktor kepatuhan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri. *Indonesian Journal of Public Health*, 19(1), 33–41.
- Riskesdas. (2018). Laporan nasional riset kesehatan dasar. Jakarta: Badan Litbangkes Kemenkes RI.
- Ruliyani, H., Amalia, L., & Sulastri, A. (2023). Hubungan pola makan dengan kejadian anemia pada remaja sekolah. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sari, D., Nugroho, H., & Lestari, R. (2021). Integrasi program tablet tambah darah dengan UKS dan Posyandu Remaja. *Jurnal Gizi dan Kesehatan Remaja*, 5(1), 12–20.
- Sari, R., Putri, A., & Lestari, M. (2024). Hubungan status sosial-ekonomi dengan kejadian anemia pada remaja putri di Jawa Tengah. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 12(1), 33–42.
- Setianingsih, D., Heryanda, M. F., & Khoiriyah, N. (2022). Faktor yang mempengaruhi anemia pada remaja putri. *Jurnal Bidan Komunitas*, 8(3), 112–135.
- Triharini, M. (2024). Nutrisi seimbang remaja putri untuk mencegah anemia. Universitas Airlangga.
- UNICEF Indonesia. (2021). Nutrition education for adolescent girls in Indonesia. Jakarta: UNICEF.

- UNICEF. (2020). Adolescent nutrition and anemia prevention in Indonesia. New York: UNICEF.
- UNICEF. (2023). Adolescent nutrition and anemia in Southeast Asia. New York: UNICEF.
- WHO. (2015). Weekly iron and folic acid supplementation in adolescent girls and women of reproductive age. Geneva: World Health Organization.
- WHO. (2022). Global report on adolescent health and anemia prevention. Geneva: World Health Organization.
- WHO. (2021). Global prevalence of anemia in adolescents. Geneva: WHO.
- WHO. (2022). Iron supplementation and anemia prevention in adolescent girls: Global strategies. Geneva: WHO.
- WHO. (2024). Guideline on iron supplementation in adolescents. Geneva: WHO.
- WHO. (2025). Adolescent health and anemia prevention guidelines. Geneva: WHO.

J. Glosarium

Hb = Hemoglobin

KIE = Komunikasi Informasi dan Edukasi

PPAGB = Program Pencegahan dan Penanggulangan Anemia pada Remaja Putri

TTD = Tablet Tambah Darah

UKS = Usaha Kesehatan Sekolah

CHAPTER 6

PERAN KELUARGA DALAM PENDAMPINGAN ANAK PEREMPUAN MENUJU PUBERTAS

Prastiwi Putri Basuki, S.K.M., M.Si.

A. Pendahuluan

Pubertas merupakan fase krusial dalam perjalanan hidup seorang anak perempuan yang menunjukkan peralihan dari masa kanak-kanak menuju remaja. Fase ini ditandai dengan perubahan dalam aspek biologis, fisik, psikologis, dan sosial sebagai bagian dari proses kematangan sistem reproduksi serta perkembangan identitas diri. Pada perempuan, pubertas biasanya dimulai antara usia 8 hingga 13 tahun dan ditandai oleh munculnya tanda-tanda seksual sekunder seperti perkembangan payudara, pertumbuhan rambut di area genital, percepatan dalam pertumbuhan tinggi badan, serta menstruasi pertama yang dikenal sebagai *menarche* (Fidora et al., 2021). Perkembangan ini umumnya terjadi dalam urutan tertentu, tetapi urutan kematangan seksual tidak seragam di setiap anak, dan ada variasi individu dalam usia terjadinya perubahan-perubahan tersebut (Kusumawati et al., 2018). Perubahan ini tidak hanya berpengaruh pada aspek fisik, tetapi juga memengaruhi kesiapan emosional serta kemampuan anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial mereka.

Perubahan fisik yang terjadi selama masa pubertas sering kali memicu berbagai reaksi psikologis di kalangan remaja perempuan. Ketidaktahuan tentang perubahan tubuh ini bisa mengakibatkan munculnya perasaan cemas, malu, bingung, dan bahkan rasa kurang percaya diri. Pada saat bersamaan, perubahan kadar hormon juga berpengaruh terhadap kestabilan emosi, sehingga anak menjadi lebih peka, cepat marah, atau mengalami perubahan suasana hati yang mendadak. Situasi ini menunjukkan bahwa pubertas bukan hanya sekadar proses biologis, tetapi juga tahap perkembangan yang rumit dan memerlukan bimbingan yang tepat agar anak dapat memahami serta menerima perubahan dirinya dengan cara yang positif.

Selain perubahan fisik dan mental, masa pubertas juga membawa perubahan sosial yang signifikan. Dalam aspek sosial, hubungan dengan teman sebaya dan interaksi dengan lingkungan luar menjadi lebih menonjol, termasuk ketertarikan terhadap lawan jenis, dampak media sosial, dan tekanan dari lingkungan yang bisa

mempengaruhi pandangan dan nilai-nilai pribadi. Anak perempuan mulai mengembangkan hubungan sosial yang lebih luas, merasakan kebutuhan untuk diterima oleh teman-teman, serta mulai menyusun identitas diri dan pemahaman tentang diri mereka. Pengaruh dari pertemanan, media sosial, dan budaya populer pada periode ini semakin meningkat. Tanpa panduan yang tepat, anak perempuan berpotensi mengalami kebingungan mengenai identitas, perilaku yang menyimpang, atau terpapar informasi yang kurang akurat tentang kesehatan reproduksi dan perkembangan pribadi.

Secara mental, masa pubertas datang dengan perasaan yang lebih tidak stabil, peningkatan sensitivitas, dan kesadaran diri yang besar mengenai penampilan serta penilaian dari orang lain. Anak perempuan mulai berusaha menemukan identitas diri, mengembangkan kepercayaan diri, dan mengatur keinginan untuk lebih mandiri, kerap kali menghadapi konflik yang wajar antara keinginan untuk mandiri dan kebutuhan akan dukungan dari orang tua. Kesiapan seorang remaja sangat dipengaruhi oleh hubungan dengan orang tua, seberapa banyak wawasan yang mereka miliki, dan jumlah informasi yang diperoleh. Mereka memerlukan dukungan, bimbingan, perhatian, dan komunikasi yang baik dari orang tua untuk membentuk pandangan mereka agar merasa tenang saat menghadapi masa pubertas. Keluarga sebaiknya lebih aktif dalam melaksanakan peran perkembangan dengan menjaga komunikasi yang baik antara orang tua dan remaja, serta memberikan kebebasan bertanggung jawab kepada remaja untuk beraktivitas dalam keseharian, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat (Baharudin, 2019).

Keluarga adalah tempat yang pertama dan paling penting bagi anak-anak dalam proses perkembangan mereka, termasuk dalam menghadapi masa pubertas. Sejak usia dini, keluarga menjadi tempat anak memperoleh kasih sayang, perlindungan, nilai-nilai kehidupan, serta pembentukan karakter dan perilaku. Dalam fase pubertas, kedekatan emosional antara anak dan keluarga menjadi sangat penting karena anak perempuan sedang mengalami berbagai perubahan yang kompleks, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, keluarga memiliki posisi strategis dalam membantu anak memahami perubahan yang terjadi pada dirinya serta membentuk kesiapan mental dan emosional dalam menghadapi masa transisi menuju remaja.

Pubertas pada anak perempuan sering kali disertai dengan munculnya rasa bingung, cemas, malu, dan ketidakpercayaan diri akibat perubahan tubuh dan emosi yang dialami. Pubertas merupakan periode yang menantang yang harus dilalui setiap anak untuk mencapai kedewasaan (Martin & Steinbeck, 2017). Masalah yang terjadi selama masa pubertas, kurangnya informasi, dan kurangnya

persiapan untuk fase ini dapat menyebabkan masalah di masa dewasa, bahkan dapat berakibat serius bagi anak (Thapar et al., 2012).

Dalam kondisi tersebut, keluarga berfungsi sebagai sumber utama dukungan emosional dan pendidikan pertama bagi anak. Orang tua yang mampu membangun komunikasi terbuka dan hangat akan membantu anak merasa aman untuk bertanya dan mengungkapkan perasaannya terkait perubahan yang dialami. Pendampingan yang positif dari keluarga juga dapat membantu anak memiliki pemahaman yang benar mengenai kesehatan reproduksi, menjaga kebersihan diri, serta menumbuhkan sikap positif terhadap tubuhnya.

Keluarga memiliki peran yang semakin penting di tengah kemajuan teknologi informasi dan media sosial yang memungkinkan akses yang lebih besar terhadap berbagai informasi, termasuk tentang pubertas dan kesehatan reproduksi. Anak perempuan yang kurang mendapatkan bimbingan dari orang tua biasanya akan mencari tahu informasi dari teman sebaya atau platform digital yang mungkin tidak akurat dan tidak sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Kondisi ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, munculnya perilaku berisiko, serta rendahnya kemampuan anak dalam mengambil keputusan yang sehat bagi dirinya. Dengan demikian, keluarga perlu hadir sebagai sumber informasi yang terpercaya dan pendamping utama dalam membantu anak menyaring berbagai pengaruh dari lingkungan luar.

Selain berfungsi sebagai penyedia informasi, keluarga juga memainkan peranan krusial dalam membentuk identitas dan kepercayaan diri anak perempuan di masa remaja. Sikap penerimaan, perhatian, dan penghargaan dari orang tua terhadap perubahan yang dialami anak dapat membantu anak menerima dirinya secara positif. Sebaliknya, kurangnya perhatian, komunikasi yang buruk, atau sikap menghakimi dalam keluarga dapat memengaruhi kesehatan mental anak dan meningkatkan risiko munculnya masalah emosional seperti kecemasan, stres, dan rendah diri. Oleh sebab itu, kualitas hubungan dalam keluarga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan anak menjalani masa pubertas secara sehat dan adaptif.

Keluarga juga berperan dalam menanamkan nilai moral, sosial, dan spiritual sebagai bekal anak perempuan dalam menghadapi perubahan pergaulan pada masa remaja. Pada fase ini, anak mulai memiliki ketertarikan terhadap lingkungan sosial yang lebih luas dan cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh kelompok sebaya. Dukungan yang berkelanjutan dari keluarga dapat memfasilitasi anak dalam mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan diri, membuat pilihan yang tepat, serta mempertahankan sikap yang sejalan dengan norma dan nilai yang ada di lingkungan sosial.

Oleh karena itu, pentingnya peran keluarga dalam mendampingi anak perempuan menjelang pubertas tidak dapat dipisahkan dari fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam kehidupan anak. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi pusat pendidikan, pembentukan karakter, dan dukungan emosional yang sangat berpengaruh pada kesiapan anak menghadapi masa pubertas. Pendampingan keluarga yang optimal diharapkan mampu membantu anak perempuan menjalani fase pubertas dengan sehat, percaya diri, serta memiliki kesiapan yang baik dalam memasuki tahap perkembangan berikutnya.

B. Tantangan Yang Dihadapi Anak Perempuan Menuju Pubertas

1. Kurangnya pengetahuan tentang pubertas dan menstruasi

Salah satu kesulitan utama yang dialami oleh anak perempuan saat memasuki masa pubertas adalah minimnya informasi mengenai pubertas dan menstruasi. Pubertas adalah tahap pertumbuhan yang ditandai oleh perubahan fisik, hormonal, psikologis, dan sosial yang berlangsung secara bertahap. Namun, banyak anak perempuan memasuki fase ini tanpa pemahaman yang memadai mengenai perubahan yang akan terjadi pada tubuh mereka. Kondisi tersebut sering menimbulkan kebingungan, kecemasan, rasa takut, bahkan rasa malu ketika anak mulai mengalami tanda-tanda pubertas, terutama menstruasi pertama (*menarche*). *Menarche* merupakan periode menstruasi pertama yang dialami oleh seorang gadis yang mulai memasuki fase dewasa, menandakan bahwa perempuan tersebut telah siap untuk hamil. Tanda-tanda yang biasa muncul bersama *menarche* termasuk rasa tidak nyaman akibat penurunan volume cairan dalam tubuh selama menstruasi. Selain itu, gejala yang mungkin dirasakan meliputi sakit kepala, nyeri otot di kaki dan pinggang yang berlangsung beberapa jam, kram perut, dan rasa sakit di perut (Usraleli & Magdalena, 2021).

Kurangnya pengetahuan tentang pubertas umumnya disebabkan oleh minimnya komunikasi dan edukasi dari lingkungan terdekat, khususnya keluarga dan sekolah. Dalam berbagai budaya, perbincangan tentang menstruasi dan kesehatan reproduksi sering kali dianggap sebagai topik yang sensitif, sehingga orang tua merasa ragu untuk menjelaskannya kepada anak-anak mereka. Sebagai hasilnya, banyak remaja perempuan mendapatkan informasi dari teman sebaya atau platform media sosial yang mungkin tidak akurat dan tidak sesuai dengan perkembangan mereka. Informasi yang tidak tepat dapat membentuk pemahaman keliru tentang menstruasi, seperti anggapan bahwa menstruasi adalah penyakit, sesuatu yang memalukan, atau

kondisi yang harus disembunyikan. Menurut temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Nastiti *et al.* (2013), kesiapan anak perempuan untuk menghadapi *menarche* juga pengaruh oleh seberapa banyak pengetahuan mereka mengenai menstruasi. Selain itu berdasarkan penelitian Pomalingo *et al.* (2025) menunjukkan bahwa semakin tinggi umur maka tingkat kesiapan dalam menghadapi *menarche* juga semakin tinggi. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Fathimi *et al.* (2020) yang menunjukkan bahwa usia memengaruhi kemampuan memahami dan cara berpikir seseorang, semakin bertambah usia seseorang, semakin meningkat juga kemampuan memahami dan cara berpikirnya. Ketidaksiapan menghadapi menstruasi pertama dapat berdampak pada kondisi psikologis anak perempuan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan yang tidak memiliki pengetahuan memadai tentang menstruasi cenderung mengalami kecemasan, ketakutan, dan stres saat pertama kali mengalami menstruasi. Tidak sedikit anak yang merasa panik ketika melihat darah menstruasi karena mengira dirinya sakit atau mengalami cedera. Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya edukasi tentang pubertas bukan hanya masalah pengetahuan, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan mental dan kesiapan emosional anak perempuan. Kesiapan untuk menghadapi *menarche* dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan mengenai *menarche* serta perhatian pada anak perempuan saat mereka mendekati *menarche*. Beberapa faktor yang memengaruhi kesiapan anak dalam menghadapi *menarche* antara lain usia dan sumber informasi yang mereka terima. Salah satu sumber informasi yang diterima oleh anak perempuan adalah dari keluarga (Fatmawati *et al.*, 2022).

Selain dampak psikologis, kurangnya pemahaman tentang menstruasi juga dapat memengaruhi perilaku kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak yang tidak memahami cara menjaga kebersihan menstruasi berisiko mengalami masalah kesehatan seperti iritasi, infeksi saluran reproduksi, dan ketidaknyamanan selama menstruasi. Kurangnya pengetahuan juga dapat menyebabkan anak memiliki pola hidup yang kurang sehat selama menstruasi, misalnya tidak mengganti pembalut secara teratur atau menghindari aktivitas tertentu karena mitos yang berkembang di masyarakat. Anak perempuan yang belum siap menerima *menarche* cenderung merasa ingin menolak perubahan fisiologis tersebut. Jika perasaan negatif ini tidak ditangani, mereka dapat terus merasakan kecemasan dalam waktu yang lama. Selain itu, ketidaksiapan dalam menyambut *menarche* bisa menyebabkan kurangnya fokus pada kebersihan diri, yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi pada organ reproduksi (Artika *et al.*, 2022).

Di era digital saat ini, akses informasi mengenai pubertas sebenarnya semakin luas. Namun, tanpa pendampingan yang tepat, anak perempuan dapat terpapar informasi yang tidak valid atau menyesatkan. Dengan demikian, fungsi keluarga dan lembaga pendidikan sangat krusial dalam memberikan pemahaman yang tepat, jelas, dan sesuai dengan usia tentang pubertas dan siklus menstruasi. Pendidikan yang tepat sejak dini dapat membantu anak perempuan memahami bahwa menstruasi merupakan proses biologis normal sebagai tanda perkembangan tubuh yang sehat.

2. Mitos dan stigma sosial

Mitos dan stigma mengenai pubertas, terutama menstruasi, sering kali diwariskan secara turun-temurun dan dianggap sebagai kebenaran tanpa didasarkan pada pengetahuan ilmiah. Kondisi ini dapat memengaruhi cara anak perempuan memahami tubuhnya, membentuk konsep diri, serta memengaruhi kesehatan fisik dan psikologis mereka. Salah satu bentuk stigma yang paling umum adalah anggapan bahwa menstruasi merupakan sesuatu yang memalukan dan harus disembunyikan. Banyak anak perempuan diajarkan untuk tidak membicarakan menstruasi secara terbuka karena dianggap sebagai hal yang tabu. Akibatnya, anak merasa malu ketika mengalami menstruasi pertama dan enggan mencari bantuan atau informasi ketika menghadapi masalah terkait kesehatan reproduksi. Rasa malu tersebut dapat menimbulkan kecemasan, menurunkan rasa percaya diri, bahkan membuat anak merasa bahwa perubahan tubuh yang dialaminya adalah sesuatu yang negatif.

Selain stigma sosial, berbagai mitos mengenai menstruasi juga masih banyak ditemukan di masyarakat. Misalnya, adanya kepercayaan bahwa anak perempuan yang sedang menstruasi tidak boleh mencuci rambut, tidak boleh mengonsumsi makanan tertentu, tidak boleh berolahraga, atau dianggap sedang berada dalam kondisi "kotor". Mitos-mitos tersebut sering diterima tanpa penjelasan ilmiah sehingga anak perempuan mengalami kebingungan dalam memahami kondisi tubuhnya. Dalam beberapa situasi, mitos yang keliru malah dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan dengan menghalangi anak-anak dalam menjaga kebersihan pribadi dan melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan normal. Penelitian mengungkapkan bahwa pengaruh mitos menstruasi dalam kehidupan sosial berkontribusi pada ketidakbebasan gadis remaja serta pembatasan perilaku mereka dalam beraktivitas di masyarakat. Mitos menstruasi ini membuat gadis remaja merasa tertekan dalam melakukan hal-hal yang mereka inginkan (Rahmawati & Eggy, 2022).

Mitos dan stigma sosial juga dapat memengaruhi kesehatan mental anak perempuan selama masa pubertas. Anak yang terus-menerus menerima pandangan negatif tentang menstruasi dan perubahan tubuh cenderung mengalami ketidaknyamanan terhadap dirinya sendiri. Mereka dapat merasa minder, takut diejek, atau khawatir dianggap berbeda oleh lingkungan sekitar. Situasi ini semakin berat ketika lingkungan keluarga tidak memberikan ruang yang aman untuk berdiskusi tentang pubertas secara terbuka dan suportif. Kecerdasan emosional dan sosial adalah salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan oleh orang tua agar anak dapat berkembang dengan baik. Perkembangan anak itu sangat rumit, mencakup berbagai aspek yang luas, dan perkembangannya tidak sesederhana dan sekompleks aspek bahasa, kemampuan kognitif, atau keterampilan dasar lainnya (Naimah, 2019).

Perkembangan media sosial dan arus informasi digital turut memengaruhi pembentukan persepsi anak perempuan tentang pubertas. Di satu sisi, media dapat menjadi sarana edukasi yang bermanfaat, tetapi di sisi lain juga dapat memperkuat standar tubuh tertentu, mempermalukan perubahan fisik alami, atau menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai menstruasi dan pubertas. Tanpa pendampingan yang tepat, anak perempuan dapat mengalami tekanan sosial dan merasa tidak percaya diri terhadap perubahan tubuhnya. Dalam menghadapi tantangan tersebut, keluarga memiliki peran penting dalam membangun pemahaman yang benar tentang pubertas dan menstruasi. Orang tua perlu memberikan edukasi yang berbasis fakta, menciptakan komunikasi yang terbuka, serta menghilangkan anggapan bahwa menstruasi adalah sesuatu yang memalukan.

3. Perubahan emosi dan kepercayaan diri

Masa remaja adalah tahap peralihan yang ditandai dengan banyak perubahan signifikan dalam kehidupan anak perempuan, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Salah satu kesulitan yang umum dijumpai selama fase ini adalah fluktuasi emosi dan harga diri. Perubahan dalam aspek mental bisa memberikan efek yang baik atau buruk bagi anak perempuan, baik berasal dari lingkungan di sekitarnya maupun dari dalam diri sendiri. Efek negatif dalam aspek mental seperti depresi, gangguan berpikir, dan bahkan niat untuk mengakhiri hidup (Fatmah & Aisyah, 2021). Menurut data WHO (2020) di negara-negara Asia-Pasifik, remaja usia 10 – 19 tahun berjumlah 60% dengan tingkat gangguan kesehatan mental tergolong tinggi di seluruh dunia. Prevalensi gangguan kesehatan mental di kalangan remaja Asia Tenggara sebesar 7,6%, paling umum ditandai dengan gejala depresi dan gangguan

kecemasan, gangguan berpikir dan upaya bunuh diri (Wijayanti et al., 2022). Perubahan hormonal yang terjadi selama pubertas memengaruhi kondisi emosional anak sehingga mereka menjadi lebih sensitif, mudah marah, cemas, sedih, atau mengalami perubahan suasana hati yang cepat. Kondisi ini merupakan bagian normal dari proses perkembangan, tetapi sering kali menimbulkan kebingungan bagi anak perempuan yang belum memahami perubahan yang terjadi pada dirinya. Perubahan emosi selama pubertas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh perubahan sosial dan psikologis yang dialami anak perempuan. Pada masa ini, anak mulai lebih memperhatikan penampilan fisik, cara berpikir orang lain terhadap dirinya, serta kebutuhan untuk diterima dalam lingkungan pertemanan. Anak perempuan menjadi lebih peka terhadap komentar, penilaian sosial, dan perbandingan dengan teman sebaya. Ketika mereka merasa tidak sesuai dengan standar yang dianggap ideal, rasa tidak percaya diri dapat muncul dan memengaruhi perkembangan psikologisnya. Pada masa remaja, terdapat perubahan dalam cara mereka memandang diri sendiri. Mereka mulai lebih memperhatikan bagaimana orang lain melihat diri mereka. Hal ini dapat menjadikan masa remaja sebagai periode yang menunjukkan perubahan karakteristik tertentu dari gejala psikologis ke arah yang lebih positif. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan pada struktur biologis, meskipun tidak semua perubahan dalam kemampuan dan sifat mental dipengaruhi oleh hal tersebut yang dikenal sebagai pematangan. Perubahan pada fisik, seperti bentuk tubuh yang dianggap tidak sempurna, dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan menurunkan rasa percaya diri (Arnami & Astutik, 2021), (E. A. Lubis & Dani, 2019).

Perubahan yang terjadi di tubuh selama masa pubertas, seperti perkembangan payudara, perubahan pada bentuk tubuh, timbulnya jerawat, atau peningkatan berat badan, sering kali menjadi penyebab ketidaknyamanan bagi perempuan muda. Sebagian anak merasa malu atau tidak nyaman dengan perubahan tersebut karena menganggap dirinya berbeda dari teman-temannya. Ada pula anak yang merasa kurang menarik atau tidak percaya diri akibat pengaruh standar kecantikan yang berkembang di lingkungan sosial maupun media digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa pubertas bukan hanya perubahan biologis, tetapi juga proses pembentukan citra tubuh dan identitas diri. Kepercayaan diri anak perempuan pada masa pubertas sangat dipengaruhi oleh respons lingkungan terhadap perubahan yang mereka alami. Dukungan, penerimaan, dan penghargaan dari keluarga dapat membantu anak menerima dirinya secara positif. Sebaliknya, kritik berlebihan, ejekan, atau perbandingan

dengan orang lain dapat memperburuk kondisi emosional anak dan menurunkan rasa percaya dirinya. Lingkungan sosial juga memainkan peran penting karena saat memasuki masa remaja, anak-anak mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman sebayanya, dan kelompok sosial menjadi sumber identitas bagi mereka. Kecerdasan sosial emosional membantu anak untuk membangun ketrampilan sosial, emosional, dan berpikir kritis untuk menghadapi berbagai situasi, termasuk hubungan interpersonal dan pengambilan keputusan (Nasokha et al., 2025).

Perubahan emosi yang tidak dipahami dengan baik dapat berdampak pada perilaku sehari-hari anak perempuan. Beberapa anak menjadi lebih mudah menarik diri dari lingkungan sosial, sulit berkonsentrasi, atau menunjukkan perilaku emosional yang berlebihan. Dalam kondisi tertentu, perubahan emosi yang tidak mendapat dukungan dan pendampingan dapat meningkatkan risiko munculnya stres, kecemasan, bahkan gangguan kesehatan mental pada remaja. Oleh karena itu, anak perempuan membutuhkan lingkungan yang aman dan suportif agar dapat belajar memahami serta mengelola emosinya dengan baik.

Di era media sosial, tantangan terhadap kepercayaan diri anak perempuan menjadi semakin kompleks. Paparan terhadap standar kecantikan yang tidak realistis, budaya perbandingan sosial, dan komentar negatif di media digital dapat memengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri. Anak perempuan yang belum memiliki konsep diri yang kuat cenderung lebih mudah merasa tidak puas terhadap tubuh dan penampilannya. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya *self-esteem* dan munculnya tekanan psikologis selama masa pubertas.

Dalam menghadapi tantangan perubahan emosi dan kepercayaan diri, peran keluarga menjadi sangat penting. Orang tua harus mengembangkan saluran komunikasi yang jujur, memberikan kasih sayang secara emosional, serta membantu anak menyadari bahwa pergeseran fisik dan perasaan saat memasuki masa pubertas adalah hal yang wajar. Sikap empati, penerimaan, dan penghargaan terhadap anak akan membantu membentuk rasa aman dan meningkatkan kepercayaan diri mereka.

4. Risiko kesehatan (anemia, kebersihan menstruasi)

Menstruasi merupakan proses fisiologis yang normal, anak perempuan pada masa pubertas menghadapi berbagai risiko kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama anemia dan masalah kebersihan menstruasi. Berdasarkan penelitian Sugesti, 2021 menunjukkan remaja perempuan dengan pola hidup sehat memiliki kemungkinan 5 kali lebih rendah

mengalami anemia dibandingkan dengan remaja perempuan yang menjalani pola hidup tidak sehat. Beberapa faktor yang berperan dalam isu kesehatan ini adalah kebiasaan hidup dan minimnya pemahaman mengenai kesehatan (S. Lubis, 2025). Kurangnya pengetahuan, keterbatasan akses terhadap informasi kesehatan, serta minimnya pendampingan dari keluarga dan lingkungan sering kali menyebabkan anak perempuan belum mampu menjaga kesehatan reproduksinya secara optimal.

Faktor-faktor yang memengaruhi fungsi pendidikan kesehatan dalam keluarga terdiri dari pengetahuan mengenai kesehatan yang dibagikan, dukungan mental dan emosional, perilaku sehat yang dijadikan teladan, serta akses keluarga terhadap informasi kesehatan yang benar. Keluarga merupakan orang-orang terdekat remaja, sehingga pembicaraan tentang isu-isu sensitif bisa dilakukan dengan lebih leluasa. Tenaga kesehatan dianjurkan untuk memperbanyak sosialisasi mengenai pelayanan kesehatan yang peduli kepada remaja dengan melibatkan keluarga agar remaja dapat memanfaatkan layanan tersebut (Bestari, 2025).

Salah satu isu kesehatan yang sering dihadapi oleh anak perempuan di masa pubertas adalah anemia. Anemia adalah keadaan di mana tubuh kekurangan hemoglobin, sehingga berpengaruh pada kemampuan darah dalam mengangkut oksigen. Pada remaja perempuan, kemungkinan terkena anemia lebih tinggi disebabkan oleh kehilangan darah selama menstruasi dan tingginya kebutuhan zat besi saat fase pertumbuhan. Anak perempuan yang mengalami anemia biasanya menunjukkan gejala seperti mudah lelah, lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, dan menurunnya semangat belajar. Jika tidak ditangani dengan baik, anemia dapat memengaruhi kesehatan, prestasi akademik, dan kualitas hidup remaja perempuan. Risiko anemia pada masa pubertas sering diperburuk oleh pola makan yang kurang sehat. Banyak remaja perempuan memiliki kebiasaan makan yang tidak seimbang, melewatkan waktu makan, atau menjalani pola diet tertentu demi menjaga bentuk tubuh. Kurangnya konsumsi makanan yang mengandung zat besi, protein, dan vitamin pendukung penyerapan zat besi dapat meningkatkan risiko terjadinya anemia. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang betapa pentingnya nutrisi selama masa pubertas membuat beberapa gadis tidak mengerti konsekuensi jangka panjang dari kekurangan gizi terhadap kesehatan reproduksi dan perkembangan mereka.

Selain anemia, tantangan kesehatan lain yang penting pada masa pubertas adalah kebersihan menstruasi atau menstrual hygiene. Menstruasi memerlukan perhatian khusus terhadap kebersihan organ reproduksi agar anak perempuan

terhindar dari infeksi dan gangguan kesehatan lainnya. Namun, masih banyak anak perempuan yang belum memahami cara menjaga kebersihan menstruasi dengan benar, seperti frekuensi mengganti pembalut, cara membersihkan organ intim, dan pentingnya menjaga kebersihan pakaian selama menstruasi. Kurangnya pengetahuan ini dapat meningkatkan risiko iritasi, infeksi saluran reproduksi, serta ketidaknyamanan selama menstruasi. Permasalahan kebersihan menstruasi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Dalam beberapa lingkungan, menstruasi masih dianggap tabu sehingga anak perempuan merasa malu untuk membicarakan kebutuhan menstruasinya. Akibatnya, mereka sering enggan bertanya atau mencari bantuan ketika mengalami masalah terkait menstruasi. Peran keluarga adalah aspek yang paling krusial dalam membantu seseorang mengatasi masalah, di mana sikap positif dari anggota keluarga selalu siap untuk memberikan dukungan dan bantuan saat diperlukan. Dengan keberadaan peran ini, rasa percaya diri akan meningkat, serta semangat untuk menghadapi masalah yang ada akan semakin tumbuh (Ayuni, 2020).

Dalam menghadapi risiko kesehatan selama pubertas, keluarga memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber edukasi dan pendamping utama bagi anak perempuan. Orang tua perlu memberikan informasi yang benar mengenai menstruasi, pola makan sehat, pentingnya konsumsi zat besi, serta cara menjaga kebersihan organ reproduksi. Dukungan keluarga juga membantu anak perempuan merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam menghadapi perubahan tubuh yang dialaminya. Semakin baik pendidikan kesehatan dalam lingkungan keluarga, semakin efektif upaya pencegahan penyakit di kalangan remaja (S. Lubis, 2025).

5. Pengaruh media dan lingkungan sosial

Media sosial telah menjadi platform yang sangat disukai oleh remaja Indonesia karena menawarkan berbagai cara untuk mengakses informasi, berkomunikasi, dan berekspresi (Harahap & Ikhsan, 2024). Lebih dari 60% orang Indonesia menggunakan media sosial setiap hari, dengan mayoritas pengguna di kelompok usia remaja (Khaidir, 2023); (Nurhayati, 2023). Perkembangan teknologi informasi dan media digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan anak perempuan, termasuk dalam menghadapi masa pubertas. Pada era modern saat ini, media sosial, internet, televisi, dan berbagai platform digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja. Di satu sisi, media dapat menjadi sarana edukasi yang membantu anak memperoleh informasi tentang pubertas dan kesehatan reproduksi. Namun, di sisi lain,

paparan media dan lingkungan sosial yang tidak terkontrol dapat menjadi tantangan besar bagi anak perempuan dalam menjalani masa pubertas secara sehat dan positif. Dampak media sosial terhadap konsep diri siswa mencakup aspek-aspek positif dan negatif. Aspek positif termasuk peningkatan kepercayaan diri, pengenalan potensi diri, kreativitas, pengendalian emosi, keberanian untuk berpendapat, serta toleransi terhadap perbedaan. Di sisi lain, terdapat juga aspek negatif seperti perasaan rendah diri, sikap pesimis, kurangnya keyakinan diri, dan perbandingan dengan orang lain (Nurmansyah, 2024). Selain memengaruhi citra tubuh, media sosial juga dapat memberikan tekanan psikologis melalui budaya perbandingan sosial. Anak perempuan cenderung lebih mudah terpengaruh oleh komentar, jumlah pengikut, maupun respons dari lingkungan digital. Ketika tidak mendapatkan pengakuan sosial yang diharapkan, anak dapat mengalami rasa cemas, sedih, bahkan rendah diri. Dalam beberapa kasus, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental, seperti stres, kecemasan, dan gangguan kepercayaan diri pada remaja perempuan. Berdasarkan penelitian oleh Cahyono *et al.* (2022), ditemukan bahwa 11% perilaku sosial remaja dipengaruhi oleh media digital.

Tantangan lain yang muncul adalah kemudahan akses ke informasi yang mungkin tidak akurat mengenai pubertas dan kesehatan reproduksi. Anak perempuan yang tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari keluarga sering mencari jawaban di internet atau dari teman-teman sebayanya. Namun, informasi yang mereka temukan tidak selalu berasal dari sumber yang terpercaya dan bisa berisi mitos, berita palsu, atau pemahaman yang salah mengenai menstruasi, perubahan fisik, dan interaksi sosial. Situasi ini dapat menyebabkan anak-anak memiliki pandangan yang keliru tentang tubuh dan proses perkembangan diri mereka. Rendahnya tingkat literasi digital di kalangan remaja memperburuk situasi ini, karena banyak dari mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya (Auliya & Rahmat, 2023).

Lingkungan sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak perempuan selama masa pubertas. Pada fase ini, anak mulai lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya dan cenderung menjadikan kelompok pertemanan sebagai sumber penerimaan sosial. Keinginan untuk diterima sering membuat anak mengikuti perilaku atau gaya hidup tertentu meskipun tidak selalu sesuai dengan nilai dan kebutuhan dirinya. Tekanan dari lingkungan sosial dapat memengaruhi cara berpakaian, pola komunikasi, hingga perilaku sehari-hari anak perempuan. Menurut Santrock cit Uberty, rekan sebaya adalah

interaksi antara anak-anak yang memiliki usia yang serupa dan memiliki tingkat kedekatan yang cukup tinggi dalam kelompok mereka. Rekan sebaya sering kali memberikan dukungan sosial. Dukungan ini dapat mencakup dorongan, sumber bantuan fisik, sumber dukungan emosional, fungsi perbandingan sosial, serta fungsi cinta dan kasih sayang (Uberty, 2022). Pengaruh teman sebaya menjadi jalinan ikatan yang sangat kuat. Peranan teman sebaya sangat besar dalam kehidupan remaja sehari-hari. Remaja lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman-teman sebaya sebagai kelompok, dan pengaruh teman-teman sebaya terhadap sikap, pembicaraan, dan perilaku lebih besar dibandingkan dengan pengaruh keluarga (Mesra & Fauziah, 2016).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, keluarga memiliki peran penting sebagai pendamping utama anak perempuan menuju pubertas. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka, memberikan edukasi mengenai penggunaan media secara bijak, serta membantu anak memahami bahwa setiap individu memiliki proses perkembangan yang berbeda. Pendampingan keluarga dapat membantu anak membangun konsep diri yang positif dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial maupun standar yang tidak realistis dari media. Terdapat perbedaan respons antara pria dan wanita dalam menghadapi stres. Wanita menunjukkan tingkat respons kewaspadaan yang negatif terhadap stres. Stres pada wanita dapat memicu pelepasan hormon tertentu yang menyebabkan perasaan cemas dan ketakutan. Sementara itu, pria umumnya dapat menghadapi dan menikmati stres serta persaingan, bahkan mereka melihat stres sebagai sesuatu yang dapat memberikan dorongan positif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketika wanita mengalami tekanan atau konflik, mereka cenderung lebih mudah mengalami stres (Wilujeng et al., 2023)

Selain keluarga, sekolah dan masyarakat juga perlu berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan remaja perempuan. Pendidikan literasi digital, kesehatan reproduksi, dan kesehatan mental menjadi penting agar anak perempuan mampu menggunakan media secara sehat dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pengaruh media dan lingkungan sosial dapat diarahkan menjadi sarana pembelajaran dan pengembangan diri yang positif bagi anak perempuan dalam menjalani masa pubertas. Hasil penelitian Yustika, Triyanto, & Heni Kusumawardani (2023) menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara dukungan keluarga yang optimal terhadap peningkatan perilaku adaptif remaja.

C. Peran Keluarga dalam Pendampingan Pubertas

1. Edukator

Pengetahuan tentang pubertas yang dimiliki seorang anak perempuan akan mempengaruhi kesiapan anak dalam menghadapi pubertas (Ayuana, 2021). Orang tua memiliki peran yang sangat penting sebagai edukator utama dalam mendampingi anak perempuan menghadapi masa pubertas, yaitu memberikan informasi yang benar dan sesuai usia. Keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak memperoleh pengetahuan, nilai, dan pemahaman tentang dirinya maupun lingkungan sekitar. Salah satu peran keluarga adalah memberikan afirmasi positif kepada remaja, serta berfungsi sebagai fasilitator informasi kesehatan (Abdelghaffar et al., 2019). Dalam konteks pubertas, peran edukatif orang tua menjadi sangat krusial karena anak perempuan mengalami berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial yang sering kali menimbulkan pertanyaan, rasa ingin tahu, bahkan kecemasan. Oleh karena itu, orang tua perlu memberikan informasi yang akurat, jelas, dan sesuai dengan usia anak agar mereka dapat memahami perubahan yang terjadi dengan cara yang positif dan sehat. Dukungan dari keluarga atau orang tua merupakan elemen yang sangat penting dalam membantu remaja mengatasi masalah, sebagai bagian dari fungsi keluarga yang meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi remaja (Yu et al., 2022).

Sebagai edukator, orang tua bertanggung jawab memberikan penjelasan mengenai pubertas secara bertahap sesuai tingkat perkembangan anak. Pemahaman orang tua mengenai kesehatan reproduksi remaja juga memiliki peran penting dalam mempersiapkan masa pubertas anak (Saptowati, 2018). Penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami akan membantu anak merasa lebih siap dan tidak takut ketika mengalami perubahan tersebut. Anak perempuan yang menerima pendidikan sejak usia dini cenderung lebih percaya diri dan memiliki kesiapan mental yang lebih baik dalam menghadapi masa pubertas. Menurut penelitian Lede (2021), semua anak menyatakan bahwa orang tua berfungsi sebagai pendidik yang memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang menstruasi kepada anak perempuan mereka.

Ibu sering dianggap memiliki peran dominan dalam memberikan edukasi mengenai pubertas dan menstruasi karena memiliki pengalaman biologis yang sama dengan anak perempuan. Kedekatan emosional antara ibu dan anak biasanya membuat anak lebih nyaman untuk bertanya mengenai perubahan tubuh, menstruasi, maupun perasaan yang dialaminya. Ibu dapat menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus memberikan contoh nyata tentang cara menjaga kesehatan reproduksi, kebersihan menstruasi, dan penerimaan diri

terhadap perubahan tubuh. Namun demikian, peran ayah juga tidak kalah penting dalam pendampingan anak perempuan menuju pubertas. Ayah berperan dalam menciptakan rasa aman, memberikan dukungan emosional, serta membangun rasa percaya diri anak perempuan. Kehadiran ayah yang suportif dapat membantu anak merasa dihargai dan diterima selama mengalami perubahan fisik maupun emosional. Selain itu, keterlibatan ayah dalam pendidikan pubertas menunjukkan bahwa pembahasan mengenai kesehatan reproduksi bukanlah hal yang tabu, melainkan bagian normal dari proses tumbuh kembang anak.

Sebagai edukator, orang tua juga perlu memberikan informasi yang benar terkait kesehatan reproduksi dan kebersihan menstruasi. Anak perempuan perlu memahami cara menjaga kebersihan diri selama menstruasi, pentingnya mengganti pembalut secara teratur, serta menjaga pola makan sehat untuk mencegah masalah kesehatan seperti anemia. Informasi yang tepat akan membantu anak membentuk perilaku hidup sehat dan meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan reproduksi sejak dini. Orang tua hendaknya selalu meningkatkan pengetahuan untuk melaksanakan dukungan keluarga kepada anak remaja (Triyanto et al., 2014). Di era digital saat ini, anak perempuan memiliki akses luas terhadap berbagai informasi melalui internet dan media sosial. Namun, tidak semua informasi yang tersedia dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, orang tua perlu menjadi sumber informasi utama yang dapat dipercaya oleh anak. Pendampingan orang tua dalam menyaring informasi dan menjelaskan fakta-fakta yang benar tentang pubertas akan membantu anak terhindar dari mitos, stigma, dan kesalahpahaman terkait perubahan tubuh dan menstruasi.

Komunikasi yang terbuka menjadi kunci keberhasilan orang tua dalam menjalankan perannya sebagai edukator. Anak perempuan perlu merasa bahwa mereka dapat bertanya tanpa takut dimarahi, dipermalukan, atau diabaikan. Sikap empati, sabar, dan tidak menghakimi dari orang tua akan menciptakan hubungan yang positif sehingga anak lebih nyaman berdiskusi mengenai masalah pubertas dan perkembangan dirinya. Sebaliknya, kurangnya komunikasi dapat menyebabkan anak mencari informasi dari sumber lain yang belum tentu benar dan sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Selain memberikan pengetahuan, orang tua juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai positif kepada anak perempuan selama masa pubertas. Orang tua dapat membantu anak memahami pentingnya menjaga diri, menghargai tubuh, membangun rasa percaya diri, serta mengembangkan perilaku yang sehat dan bertanggung jawab. Pendidikan yang diperoleh dalam keluarga akan menjadi

fondasi bagi anak untuk menghadapi berbagai pengaruh dari lingkungan sosial dan media selama masa remaja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Afrianis et al., 2025), ditemukan bahwa penyampaian informasi yang akurat dan dukungan dari lingkungan terdekat, khususnya orang tua, sangat krusial dalam membentuk kesiapan remaja untuk menghadapi menarche dengan sikap yang positif dan sehat.

2. Komunikator

Masa pubertas merupakan fase perkembangan yang penuh dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial bagi anak perempuan. Pada masa ini, anak mulai mengalami berbagai pengalaman baru yang sering kali menimbulkan rasa penasaran, bingung, cemas, bahkan takut. Oleh karena itu, peran orang tua sebagai komunikator menjadi sangat penting dalam membantu anak memahami dan menghadapi perubahan tersebut secara sehat dan positif. Komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak dapat menciptakan hubungan yang hangat, penuh kepercayaan, serta menjadi sarana utama dalam memberikan pendampingan selama masa pubertas. Orang tua, sebagai lingkungan sosial awal bagi anak perempuan, diharapkan dapat menerapkan metode pengasuhan yang menekankan adanya komunikasi terbuka mengenai perubahan fisik selama masa pubertas. Pendekatan yang bersahabat dapat digunakan untuk membantu anak perempuan memahami dengan baik perubahan fisik yang terjadi pada masa itu, mengingat bahwa remaja sering kali bersikap emosional dan memiliki kebutuhan akan kasih sayang. Peran metode pengasuhan orang tua sangat penting dalam membentuk sikap anak perempuan terhadap perubahan fisik yang dialami selama pubertas (Sarwono, 2010).

Sebagai komunikator, orang tua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman agar anak perempuan merasa bebas mengungkapkan pikiran, pertanyaan, maupun perasaannya. Anak yang merasa diterima dan didengarkan oleh orang tua akan lebih mudah terbuka ketika mengalami masalah atau kebingungan terkait perubahan tubuh dan emosinya. Sebaliknya, komunikasi yang tertutup, penuh larangan, atau sikap menghakimi dapat membuat anak merasa takut untuk bertanya sehingga memilih mencari jawaban dari teman sebaya atau media sosial yang belum tentu memberikan informasi yang benar. Komunikasi terbuka tentang pubertas perlu dibangun sejak dini dan dilakukan secara bertahap sesuai usia serta tingkat perkembangan anak. Orang tua dapat mulai memperkenalkan perubahan tubuh, pentingnya menjaga kebersihan diri, serta menjelaskan bahwa

menstruasi dan perubahan fisik lainnya merupakan proses normal dalam pertumbuhan perempuan. Penyampaian informasi dengan bahasa yang sederhana, jujur, dan mudah dipahami akan membantu anak merasa lebih siap menghadapi masa pubertas tanpa rasa takut atau malu. Kesiapan pubertas pada remaja dapat dicapai melalui komunikasi yang baik dengan orang tua, tingkat pengetahuan, serta jumlah sumber informasi yang tersedia. Orang tua dan guru perlu memberikan perhatian, pengasuhan, serta komunikasi yang optimal untuk membantu anak memahami dan tidak merasa takut menghadapi masa pubertas. Keluarga sebaiknya lebih mengoptimalkan peran mereka dalam memfasilitasi tugas perkembangan, seperti menjaga komunikasi yang terbuka antara orang tua dan remaja, serta memberikan kebebasan yang bertanggung jawab kepada remaja dalam menjalani aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat (Saptowati, 2018).

Ibu sering menjadi sosok yang paling dekat dalam membangun komunikasi mengenai pubertas dan menstruasi dengan anak perempuan. Kedekatan emosional yang terjalin membuat anak lebih nyaman untuk bertanya mengenai perubahan tubuh, nyeri menstruasi, maupun perasaan yang dialaminya selama pubertas. Ibu dapat memberikan dukungan emosional sekaligus berbagi pengalaman pribadi sebagai bentuk empati dan penguatan bagi anak perempuan. Meskipun demikian, peran ayah dalam komunikasi dengan anak perempuan juga sangat penting. Ayah yang terlibat aktif dalam kehidupan anak dapat membantu membangun rasa aman, penghargaan diri, dan kepercayaan diri anak perempuan. Sikap ayah yang terbuka dan suportif menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai pubertas bukanlah hal yang memalukan atau tabu. Kehadiran ayah dalam komunikasi keluarga juga membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung perkembangan psikologis anak perempuan secara menyeluruh. Komunikasi terbuka tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga kemampuan orang tua untuk mendengarkan anak secara aktif. Pada masa pubertas, anak perempuan sering mengalami perubahan emosi yang membuat mereka lebih sensitif dan mudah tersinggung. Orang tua perlu memahami kondisi tersebut dengan menunjukkan sikap empati, sabar, dan tidak langsung menghakimi. Mendengarkan keluhan, kekhawatiran, atau cerita anak dengan penuh perhatian dapat membantu anak merasa dihargai dan dipahami. Komunikasi yang transparan dan ikatan emosional yang kokoh antara orang tua dan anak sangat berperan dalam membentuk kesiapan mental serta perilaku remaja (Afrianis et al., 2025).

Di era digital saat ini, komunikasi antara orang tua dan anak menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Anak perempuan memiliki akses luas terhadap berbagai informasi dari media sosial dan internet yang tidak semuanya sesuai dengan nilai maupun kebutuhan perkembangan mereka. Dalam kondisi ini, komunikasi terbuka menjadi sangat penting agar anak merasa nyaman berdiskusi dengan orang tua mengenai informasi yang mereka peroleh. Orang tua dapat membantu anak memilah informasi yang benar, menghindari pengaruh negatif media, serta membangun kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai isu yang berkaitan dengan pubertas dan pergaulan sosial.

3. *Role model*

Dalam proses tumbuh kembang anak perempuan menuju pubertas, orang tua memiliki peran penting sebagai *role model* atau teladan dalam membentuk perilaku dan kebiasaan hidup sehat. Anak belajar tidak hanya melalui nasihat atau arahan, tetapi juga melalui pengamatan terhadap sikap dan perilaku orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perilaku ibu dan ayah akan menjadi contoh yang sangat berpengaruh terhadap cara anak memahami, merespons, dan menjalani masa pubertas. Peran orang tua adalah sebagai pendidik, memberikan teladan yang baik, mendampingi, mengawasi, dan berfungsi sebagai konselor bagi anak (Haryani et al., 2015).

Masa pubertas merupakan periode ketika anak perempuan mulai mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Pada fase ini, anak cenderung lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan mulai membentuk identitas diri berdasarkan pengalaman serta figur yang dianggap penting dalam hidupnya. Orang tua yang menunjukkan pola hidup sehat, sikap positif terhadap tubuh, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik akan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan anak perempuan selama pubertas.

Sebagai *role model*, ibu memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan contoh terkait kesehatan reproduksi dan penerimaan diri terhadap perubahan tubuh. Anak perempuan sering menjadikan ibu sebagai acuan dalam memahami bagaimana seorang perempuan merawat diri, menjaga kebersihan tubuh, menghadapi menstruasi, serta bersikap terhadap perubahan fisik yang terjadi selama pubertas. Ketika ibu menunjukkan sikap terbuka dan positif terhadap menstruasi serta kesehatan reproduksi, anak akan belajar bahwa perubahan tersebut merupakan hal normal dan tidak perlu dianggap memalukan. Selain itu, ibu juga dapat menjadi teladan dalam menerapkan pola hidup sehat, seperti menjaga kebersihan diri, mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan menjaga keseimbangan emosi. Kebiasaan sehat

yang diterapkan ibu dalam kehidupan sehari-hari akan lebih mudah ditiru oleh anak perempuan dibandingkan hanya disampaikan dalam bentuk nasihat. Dengan demikian, anak dapat membentuk perilaku hidup sehat secara alami melalui proses pengamatan dan pembiasaan di lingkungan keluarga.

Peran ayah sebagai *role model* juga sangat penting dalam membentuk rasa percaya diri dan konsep diri anak perempuan. Ayah yang menunjukkan sikap menghargai perempuan, berkomunikasi dengan sopan, serta memberikan dukungan emosional akan membantu anak perempuan merasa dihargai dan memiliki citra diri yang positif. Hubungan yang hangat antara ayah dan anak perempuan dapat memperkuat rasa aman emosional serta membantu anak mengembangkan kepercayaan diri dalam menghadapi perubahan selama masa pubertas.

Peran orang tua sebagai *role model* juga terlihat dalam cara mereka menggunakan media sosial, menjaga komunikasi dalam keluarga, serta menyikapi masalah sehari-hari. Anak perempuan cenderung meniru bagaimana orang tua menyelesaikan konflik, mengelola stres, dan berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menunjukkan perilaku yang positif, penuh empati, dan saling menghargai agar anak memiliki contoh nyata dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Dalam menghadapi tantangan pubertas di era digital, anak perempuan juga membutuhkan teladan dalam penggunaan teknologi dan media sosial secara bijak. Orang tua yang mampu membatasi penggunaan gawai, memilih informasi yang sehat, dan menjaga keseimbangan antara aktivitas digital dan kehidupan sosial akan membantu anak mengembangkan perilaku yang lebih bertanggung jawab. Keteladanan tersebut penting agar anak tidak mudah terpengaruh oleh standar sosial atau informasi negatif yang banyak beredar di media digital.

4. Pengawas dan pelindung

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pergaulan anak, termasuk mengetahui teman sebayanya dan aktivitas yang mereka lakukan saat bermain. Orang tua yang bijak seharusnya mampu memantau anak meskipun sibuk dengan pekerjaan, sehingga bimbingan dapat tetap diberikan dan hubungan kedekatan dengan anak terjaga dengan baik. Komunikasi antara orang tua dan anak dapat mempengaruhi perilaku anak dalam masa perkembangannya. Remaja akan merasakan kebahagiaan dan kenyamanan, sehingga mampu berperilaku positif dalam kehidupannya jika memiliki interaksi yang baik dengan orang tua. Komunikasi orang tua dan anak meliputi pemberian perhatian, bimbingan, batasan, serta penerimaan terhadap kondisi

anak. Orang tua juga menetapkan aturan dengan otoritasnya melalui penyampaian informasi, tujuan, pemahaman, dan pendidikan yang dapat membantu anak dalam menyelesaikan tugas perkembangannya (Ghozah, 2023). Pada masa pubertas ini, anak mulai lebih aktif berinteraksi dengan lingkungan luar, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta mulai membangun kemandirian. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga membuat anak perempuan menjadi lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan, baik dalam bentuk pergaulan, informasi yang tidak tepat, maupun risiko kesehatan. Oleh karena itu, peran orang tua sebagai pengawas dan pelindung sangatlah penting untuk memastikan anak melewati masa pubertas dengan aman dan sehat. Peranan orang tua adalah menjadi sosok terdekat bagi anak, yang berfungsi memberikan saran tanpa menentukan keputusan. Namun, mereka juga harus memahami haknya sebagai penanggung jawab. (Subekti et al., 2020).

Sebagai pengawas, orang tua bertanggung jawab untuk memperhatikan perkembangan anak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas sehari-hari, pergaulan, penggunaan media, serta perubahan perilaku yang muncul selama pubertas. Pengawasan yang dilakukan bukan dalam bentuk pembatasan yang berlebihan, melainkan dalam bentuk perhatian, keterlibatan, dan pemantauan yang penuh kasih sayang. Orang tua perlu mengetahui dengan siapa anak bergaul, bagaimana anak menghabiskan waktu luangnya, serta informasi apa saja yang diakses melalui media digital. Hal ini penting untuk mencegah anak terpapar pengaruh negatif yang dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun psikologisnya. Menurut (Lede, 2021), orang tua yang berfungsi sebagai pendidik, teman, teladan, pengawas, dan penyedia dukungan dapat menciptakan komunikasi terbuka yang efektif, sehingga remaja tidak bergantung pada sumber informasi yang tidak valid seperti teman sebaya atau media sosial..

Dalam perannya sebagai pelindung, orang tua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak perempuan selama masa pubertas. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, emosional, dan sosial. Secara fisik, orang tua perlu memastikan anak memahami pentingnya menjaga kesehatan tubuh, kebersihan menstruasi, serta pola hidup sehat. Secara emosional, orang tua perlu memberikan rasa aman, dukungan, dan kenyamanan agar anak tidak merasa sendirian dalam menghadapi perubahan yang terjadi pada dirinya. Sementara secara sosial, orang tua berperan dalam melindungi anak dari pergaulan yang tidak sehat, bullying, serta tekanan sosial yang dapat memengaruhi kepercayaan dirinya. Orang tua berfungsi sebagai konsultan yang siap menawarkan berbagai alternatif solusi ketika anak menghadapi masalah.

Namun, solusi yang diberikan tidak harus diikuti sepenuhnya oleh anak, karena anak memiliki hak untuk memilih jalan keluar yang dianggap paling sesuai untuk dirinya. Peran orang tua adalah memberikan saran dan arahan, bukan mengambil keputusan, sambil tetap memahami batas hak dan tanggung jawabnya sebagai penanggung jawab anak (Haryadi, 2024).

Ibu sering kali menjadi figur yang lebih dekat dalam memberikan perlindungan sehari-hari kepada anak perempuan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan perubahan tubuh selama pubertas. Ibu dapat membantu anak memahami cara menjaga kebersihan diri saat menstruasi, mengenali tanda-tanda perubahan tubuh, serta memberikan dukungan emosional ketika anak merasa cemas atau tidak nyaman. Kedekatan emosional antara ibu dan anak menjadi modal penting dalam membangun rasa aman selama masa pubertas. Sementara itu, ayah memiliki peran yang tidak kalah penting sebagai pelindung dalam aspek psikologis dan sosial. Kehadiran ayah yang aktif dan peduli dapat memberikan rasa aman dan memperkuat kepercayaan diri anak perempuan. Ayah juga berperan dalam menetapkan batasan yang sehat dalam pergaulan anak, memberikan arahan terkait interaksi sosial, serta melindungi anak dari potensi risiko di lingkungan luar rumah. Sikap ayah yang tegas namun tetap hangat akan membantu anak merasa terlindungi tanpa merasa dikekang. Ibu dan ayah memiliki tanggung jawab masing-masing yang seharusnya seimbang. Ketidakseimbangan dalam peran ibu dan ayah dapat menyebabkan hambatan dalam perkembangan anak, serta berdampak pada kondisi psikologis dan pola komunikasi intrapersonal maupun interpersonal anak (Nurfadhilah et al., 2022).

Dalam era digital saat ini, peran orang tua sebagai pengawas dan pelindung menjadi semakin kompleks. Anak perempuan memiliki akses luas terhadap media sosial dan internet yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, orang tua perlu melakukan pendampingan dalam penggunaan teknologi, termasuk memberikan batasan waktu penggunaan gawai, mengawasi konten yang diakses, serta mengajarkan anak untuk bersikap kritis terhadap informasi yang diterima. Pendampingan ini penting untuk melindungi anak dari paparan konten yang tidak sesuai usia, termasuk informasi yang salah tentang pubertas dan kesehatan reproduksi. Ketika remaja merasakan hubungan yang kurang hangat dengan orang tua mereka, serta minimnya dukungan dan perhatian, mereka cenderung mencari dukungan sosial alternatif dengan menggunakan ponsel secara berlebihan, terutama untuk berinteraksi dengan teman sebaya (Ghozah, 2023). Selain pengawasan terhadap lingkungan luar, orang tua juga perlu peka terhadap

perubahan perilaku anak di rumah. Perubahan emosi, penurunan prestasi belajar, atau menarik diri dari lingkungan sosial dapat menjadi tanda bahwa anak membutuhkan perhatian lebih. Dalam kondisi seperti ini, orang tua perlu hadir sebagai pelindung emosional dengan memberikan dukungan, mendengarkan tanpa menghakimi, serta membantu anak mengatasi tekanan yang dialaminya selama masa pubertas.

D. Simpulan

Pubertas merupakan masa transisi penting yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan sosial yang kompleks, sehingga memerlukan dukungan dan bimbingan dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Pada masa ini, anak membutuhkan pendampingan yang tepat agar mampu memahami perubahan yang terjadi pada dirinya secara positif dan sehat. Keluarga memegang peran sentral dan strategis dalam pendampingan anak perempuan menuju pubertas.

Peran keluarga dalam pendampingan anak perempuan menuju pubertas terbagi dalam beberapa aspek kunci, yaitu sebagai edukator, komunikator, *role model*, pengawas dan pelindung. Pendampingan keluarga yang dilakukan melalui komunikasi terbuka, pemberian edukasi kesehatan reproduksi yang sesuai usia, perhatian terhadap kondisi emosional anak, serta penanaman nilai dan perilaku hidup sehat dapat membantu anak perempuan menjalani masa pubertas dengan lebih percaya diri dan bertanggung jawab. Sebaliknya, kurangnya perhatian dan komunikasi dalam keluarga dapat menyebabkan anak mencari informasi dari sumber yang kurang tepat sehingga berisiko menimbulkan kesalahpahaman maupun perilaku yang tidak sehat.

Oleh karena itu, kolaborasi antara ibu dan ayah dalam pendampingan anak perempuan menuju pubertas sangat penting. Ibu memberikan pendekatan yang lebih intim terkait menstruasi dan perawatan diri, sementara ayah memperkuat fondasi emosional dan kepercayaan diri anak. Kedua peran ini saling melengkapi dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain. Keluarga yang aktif, responsif, dan empatik dalam mendampingi anak perempuan menuju pubertas akan menghasilkan generasi wanita yang sehat, percaya diri, dan mampu menghadapi tantangan masa remaja hingga dewasa dengan baik.

E. Referensi

- Abdelghaffar, E.-A., Hicham, E. K., Siham, B., Samira, E. F., & Youness, E. A. (2019). Perspectives of adolescents, parents, and teachers on barriers and facilitators of physical activity among school-age adolescents: A qualitative analysis. *Environmental Health and Preventive Medicine*, 24(1), 21.
- Afrianis, C., Danur, A., & Murwati. (2025). Hubungan Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi Dengan Kesiapan Menghadapi Menarche Remaja Putri Di SD N 66 Kota Bengkulu. *Jurnal Multimedia Dehasen (MUDE)*, 5(1), 179–188.
- Arnami, K., & Astutik, W. (2021). Masalah Psikososial Pada Remaja. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keris Husada*, 5(2), 76–86.
- Artika, A. K. W., Purnama, N. L. A., & Kurniawaty, Y. (2022). Kesiapan Siswi Sekolah Dasar Dalam Menghadapi Menarche. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 7(4).
- Auliya, F., & Rahmat, A. (2023). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja di Indonesia. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 4(1), 33–45.
- Ayuanida, S. (2021). *Hubungan Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Kesehatan Reproduksi Dengan Kesiapan Menghadapi Pubertas Siswa Laki-Laki (Usia 10-12 tahun) Di SDN Sananwetan 01 Kota Blitar*.
- Ayuni, N. D. Q. (2020). *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Pada Pasien Post Operasi Katarak*. Galeri Mandiri.
- Baharudin. (2019). Pentingnya Pola Komunikasi Orang Tua Terhadap Perkembangan Pubertas Remaja. *An Nisa Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 12(1), 610–621.
- Bestari, S. R. (2025). Peningkatan Pengetahuan Tentang Dukungan Keluarga Terhadap Gaya Hidup Sehat Remaja Pada Siswa SMP Muhammadiyah Di Surakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Medika*, 5(2).
- Cahyono, Raihan, Mulki, S., Achmad, S., & Yuli, M. (2022). Pengaruh Penggunaan Media Digital dan Peran Keluarga Terhadap Perilaku Sosial Para Remaja. *Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin*, 6(1).
- Fathimi, Sasmita, Y., & Orisinal. (2020). Hubungan Umur, Status Gizi Dan Pengetahuan Remaka Putri Tentang Menarche Dengan Kesiapan Menghadapi Menarche di MTS Durian. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Humaniora*, 8(4), 562–568.
- Fatmah, K., & Aisyah, D. (2021). Peningkatan Kesehatan Mental anak dan Remaja Melalui Ibadah Keislaman. *Al-Isyrof: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1), 1–7.
- Fatmawati, L., Syaiful, Y., & Tamada, M. (2022). Pendidikan Kesehatan Meningkatkan Pengetahuan Dan Kesiapan Siswi Menghadapi Menarche Pada Siswi Usia 9-12 tahun. *Journals Of Ners Community*, 13(1), 51–63.
- Fidora, I., Oktarini, S., & Prima, R. (2021). Siap Fisik Dan Psikologis Menghadapi Masa Pubertas. *Jurnal Salingka Abdimas*, 1(1), 6–10.
- Ghozah, N. I. (2023). *Dukungan Orang Tua Dalam Menghadapi Masa Pubertas Remaja di Desa Linggasari RT 01 RW 06 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas*.
- Harahap, D., & Ikhsan, A. (2024). Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Telegram di Kalangan Remaja. *Jurnal Pendidikan Tambusia*, 8(2), 29841–29848.

- Haryadi, A. M. (2024). Peran Orang Tua dalam Pemenuhan Kebutuhan Informasi Kesehatan Reproduksi pada Remaja. *SEHATMAS (Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat)*, 3(1), 151–160.
- Haryani, D. S., Wahyuningsih, W., & Haryani, K. (2015). Peran Orang Tua Berhubungan dengan Perilaku Seksual Pra Nikah Remaja di SMKN 1 Sedayu. *Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia*, 3(3).
- Khaidir, M. (2023). Dampak Media Sosial Terhadap Pengembangan Konsep Diri Pada Remaja. *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, 15(1), 93–105.
- Kusumawati, P. D., Ragilia, S., Trisnawati, N. W., Larasati, N. C., Laorani, A., & Soares, S. R. (2018). Edukasi Masa Pubertas pada Remaja. *Journal of Community Engagement in Health*, 1(1), 1–3. <https://doi.org/10.30994/vol1iss1pp16>
- Lede, L. (2021). *Hubungan Peran Orang Tua Dengan Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Menarche Di SMP Negeri 12 Sikumana Kota Kupang*.
- Lubis, E. A., & Dani, D. (2019). *Sosialisasi Pengetahuan Remaja Tentang Dampak Psikososial Yang Akan Terjadi Pada Masa Remaja di SMP Paba Binjai*. 53–56.
- Lubis, S. (2025). The Role Of Family-Based Health Education In Preventing Adolescents Diseases. *An Idea Health Journal*, 5.
- Martin, A. J., & Steinbeck, K. (2017). The role of puberty in students' academic motivation and achievement. *Learning and Individual Differences*, 53, 37–46.
- Mesra, E., & Fauziah. (2016). Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Perilaku Seksual Remaja. *Jurnal Ilmiah Bidan*, 1(2).
- Naimah, K. (2019). Mengembangkan Kecerdasan Sosial Emosional Anak Usia Dini melalui Kegiatan Makan Bersama Di Sekolah. *Konik*, 7.
- Nasokha, S. A. M. B., Okfanisa, R. R., Tiara, R. S. N. J., Lisa, M., Nia, N., & Dewi, K. A. (2025). Edukasi Seksual Dan Kecerdasan Sosial-Emosional Untuk Remaja SMP Dalam Menghadapi Masalah Pubertas. *Jendela Akademika, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(01).
- Nastiti, F. D., Andayani, A., & Diah, M. (2013). *Hubungan Tingkat Pengetahuan Menarche Dengan Kesiapan Siswi Kelas V dan VI Menghadapi Menarche Di SD Negeri 1 Gedanganak*. Akademi Kebidanan Ngudi Waluyo.
- Nurfadhilah, S. N., Ika, P., & Nur, A. J. (2022). Peningkatan Kapasitas Orang Tua Tentang Pubertas. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LP Universitas Muhammadiyah Jakarta*.
- Nurhayati, M. (2023). Komunikasi Virtual Melalui Media Sosial Instagram di Kalangan Remaja. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6(1), 50–56.
- Nurmansyah, N. (2024). Pengaruh Media Sosial Pada Persepsi diri Remaja. *Journal of Multicultural Education and Social Studies*, 1(1).
- Organization, W. H. (2020). *New WHO guidelines on promoting mental health among adolescents*. World Health Organization. <https://www.who.int/news/item/28-09-2020-new-who-guidelines-on-promoting-mental-health-among-adolescents>
- Pomalingo, I., Ika, W., & Cindy, P. S. H. J. (2025). Hubungan Dukungan Keluarga dengan

- Kesiapan Remaja Putri dalam Menghadapi Menarche. *Gorontalo Journal of Public Health*, 8(1).
- Rahmawati, S. A. A., & Eggy, F. A. (2022). Dampak Mitos Menstruasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Kabupaten Probolinggo. *Lingua Franca*, 6(1).
- Saptowati, D. (2018). Hubungan pengetahuan ibu tentang kesehatan reproduksi remaja dengan upaya mempersiapkan masa pubertas pada anak. *Jurnal Hospital Science*, 2(1).
- Sarwono, S. W. (2010). *Psikologi Remaja*. Rajawali Press.
- Subekti, N. M., Prasetyani, D. K., & Nikmah, A. N. (2020). Gambaran Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Dalam Menghadapi Pubertas Pada Remaja. *Jurnal Mahasiswa Kesehatan*, 1(2), 159–165.
- Thapar, A., Collishaw, S., Pine, D. S., & Thapar, A. K. (2012). Depression in adolescence. *Lancet North America*, 379, 1056–1067.
- Triyanto, E., Setiyani, R., & Wulansari, R. (2014). Pengaruh Dukungan Keluarga Dalam Meningkatkan Perilaku Adaptif Remaja Pubertas. *Padjadjaran Nursing Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jkp.v2i1.76>
- Uberty, A. (2022). *Pencegahan Perilaku Kesehatan Reproduksi yang Beresiko pada Remaja*. PT. Nasya Expanding Management.
- Usraleli, U., & Magdalena, M. (2021). Pengaruh Terapi Kelompok Terapeutik Dan Pendidikan Kesehatan Terhadap Kecemasan Menghadapi Menarche Pada Siswi Di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 818.
- Wijayanti et al. (2022). *Hubungan Perilaku Sedentary, Dukungan Orang Tua, Perundungan Dan Gejala Depresi Pada Remaja Di Jawa: Analisis Data Sekunder GSHS 2015* (pp. 1–14).
- Wilujeng, C. S., Habibie, I. Y., & Ventyaningsih, A. D. I. (2023). Hubungan antar Jenis Kelamin dengan Kategori Stres pada Remaja di SMP Brawijaya Smart School. *Smart Society Empowerment Journal*, 3(1), 6.
- Yu, X., Kong, X., Cao, Z., Chen, Z., Zhang, L., & Yu, B. (2022). Social Support and Family Functioning during Adolescence: A Two-Wave Cross-Lagged Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(10), 6327.
- Yustika, K., Triyanto, E., & Kusumawardani, L. H. (2023). Hubungan Antara Dukungan Emosional Keluarga Dengan Perilaku Remaja Pengguna Media Sosial Facebook. *Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 18(1), 1–8.

CHAPTER 7

EVALUASI KESEHATAN DAN TUMBUH KEMBANG ANAK PEREMPUAN

Dr. Faridah, SST., Ns., M.Kes.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Masa pubertas merupakan periode transisi dari masa anak menuju remaja yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, emosional, dan sosial secara cepat. Menurut WHO masa menjelang pubertas sekitar usia 8-9 tahun hingga awal remaja usia 10-14 tahun (WHO & Unicef, 2023). Pada usia 8–13 tahun biasanya munculnya tanda-tanda perkembangan seksual sekunder seperti pembesaran payudara, pertumbuhan rambut pubis, percepatan pertumbuhan tinggi badan, hingga menstruasi pertama (*menarche*). Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi kondisi biologis, tetapi juga kesiapan psikologis dan sosial anak perempuan dalam menghadapi masa remaja (Agatha dkk., 2022; Deardorff, Marceau, Johnson, Reeves, Biro, Kubo, Greenspan, Laurent, Windham, Pinney, dkk., 2021; WHO, 2025; WHO & Unicef, 2023)

Pertumbuhan dan perkembangan anak perempuan menuju pubertas dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti status gizi, kondisi kesehatan, lingkungan keluarga, sosial ekonomi, aktivitas fisik, dan kesehatan mental. Nutrisi yang tidak adekuat maupun obesitas dapat memengaruhi waktu onset pubertas serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada masa remaja dan dewasa. Penelitian longitudinal menunjukkan bahwa asupan energi dan protein pada masa anak berhubungan dengan percepatan pubertas dan usia menarche yang lebih dini pada anak perempuan (Cheng dkk., 2022)

Di Indonesia, kesehatan remaja perempuan masih menjadi perhatian karena tingginya masalah anemia, kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi, serta keterbatasan edukasi pubertas yang sesuai usia. Studi pada remaja awal di Indonesia menunjukkan masih rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi dan adanya ketidaknyamanan dalam menghadapi perubahan tubuh selama pubertas (Kågesten dkk., 2021). Oleh karena itu, evaluasi kesehatan dan tumbuh kembang anak perempuan menjadi penting untuk mendeteksi dini gangguan pertumbuhan, masalah psikososial, maupun

gangguan pubertas sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat. Pemantauan berkala memungkinkan deteksi dini terhadap gangguan pertumbuhan, keterlambatan perkembangan, gangguan psikososial, maupun masalah kesehatan reproduksi sejak awal sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat (Agatha dkk., 2022).

Evaluasi kesehatan dan tumbuh kembang mencakup pemantauan pertumbuhan fisik, perkembangan emosional dan sosial, kesiapan menghadapi pubertas, serta identifikasi faktor risiko kesehatan. Pemantauan yang dilakukan secara berkala oleh keluarga, sekolah, dan tenaga kesehatan diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang optimal anak perempuan menuju masa remaja sehat dan berkualitas.

2. Tujuan Pembahasan

Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan konsep evaluasi kesehatan dan tumbuh kembang anak perempuan menuju pubertas.
- b. Mengidentifikasi komponen evaluasi pada anak perempuan usia pra-pubertas (8–9 tahun).
- c. Mengidentifikasi komponen evaluasi pada anak perempuan awal pubertas (10–14 tahun).
- d. Menjelaskan anticipatory guidance (bimbingan antisipatif) menuju pubertas

3. Pentingnya Evaluasi Kesehatan dan Tumbuh Kembang Anak Perempuan

Evaluasi kesehatan dan tumbuh kembang pada anak perempuan memiliki peranan penting dalam memastikan proses pertumbuhan berlangsung optimal sesuai tahap usia. Pemantauan berkala memungkinkan deteksi dini terhadap gangguan pertumbuhan, keterlambatan perkembangan, gangguan psikososial, maupun masalah kesehatan reproduksi sejak awal sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat (Agatha dkk., 2022). Pada masa menuju pubertas, anak perempuan mengalami perubahan hormonal yang memengaruhi kondisi fisik dan psikologis. Ketidaksiapan menghadapi perubahan tersebut dapat menyebabkan masalah emosional, rendahnya kepercayaan diri, gangguan citra tubuh, hingga kesulitan adaptasi sosial. Oleh sebab itu, evaluasi perkembangan emosional dan sosial menjadi bagian penting dalam pemantauan kesehatan remaja perempuan (Barendse dkk., 2022)

Evaluasi kesehatan juga berfungsi untuk memantau status gizi dan kesehatan reproduksi remaja perempuan. Permasalahan seperti anemia, gangguan menstruasi, pubertas dini, maupun pubertas terlambat dapat

memengaruhi kualitas hidup dan kesehatan reproduksi di masa mendatang. Pemeriksaan berkala melalui pengukuran antropometri, Tanner staging, dan skrining psikososial dapat membantu tenaga kesehatan menentukan kondisi perkembangan anak secara komprehensif (Cheng dkk., 2022).

Selain itu, keterlibatan keluarga dalam evaluasi kesehatan sangat diperlukan karena orang tua berperan dalam memberikan dukungan emosional, edukasi pubertas, pemenuhan nutrisi, serta membangun komunikasi yang positif dengan anak perempuan. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan tenaga kesehatan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang optimal anak perempuan menuju pubertas yang sehat.

B. Konsep Evaluasi Kesehatan dan Tumbuh Kembang Anak Perempuan Menuju Pubertas

1. Pengertian evaluasi kesehatan dan tumbuh kembang

Evaluasi kesehatan dan tumbuh kembang merupakan penilaian yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memantau kondisi kesehatan, pertumbuhan fisik, serta perkembangan anak sesuai tahapan usia. Evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan berlangsung optimal serta mendeteksi secara dini adanya penyimpangan atau gangguan yang dapat memengaruhi kualitas hidup anak pada masa mendatang (Marilyn J. Hockenberry. dkk., 2024). Menurut World Health Organization, kesehatan anak dan remaja merupakan keadaan kesejahteraan menyeluruh yang memungkinkan individu berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, evaluasi kesehatan pada anak perempuan perlu dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, serta kesiapan menghadapi perubahan menuju pubertas (WHO, 2025).

Dalam konteks tumbuh kembang, istilah pertumbuhan (*growth*) mengacu pada peningkatan ukuran fisik tubuh yang bersifat kuantitatif, seperti berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh (IMT), dan perubahan ukuran organ tubuh. Sementara itu, perkembangan (*development*) merupakan proses peningkatan kemampuan fungsi tubuh yang bersifat kualitatif, meliputi perkembangan motorik, bahasa, kognitif, sosial, emosional, dan perilaku (Kliegman & St Geme, 2019). Pada anak perempuan menuju pubertas, evaluasi tumbuh kembang menjadi semakin penting karena terjadi percepatan pertumbuhan (*growth spurt*) dan perubahan hormonal yang memengaruhi kondisi fisik maupun psikososial (WHO & Unicef, 2023).

Evaluasi tumbuh kembang anak perempuan menuju pubertas tidak hanya berfokus pada pengukuran antropometri, tetapi juga mencakup penilaian kesiapan emosional, hubungan sosial, citra diri, kemampuan adaptasi, dan perkembangan identitas diri. Masa prapubertas hingga pubertas awal merupakan periode yang sensitif karena anak mulai mengalami perubahan fisik, peningkatan kesadaran terhadap tubuh, serta perubahan perilaku yang memerlukan pendampingan dan pemantauan secara berkelanjutan (American Academy of Pediatrics, 2017). WHO menjelaskan bahwa masa menjelang pubertas (sekitar usia 8–9 tahun hingga awal remaja 10–14 tahun) merupakan fase transisi penting karena terjadi percepatan pertumbuhan, perubahan hormonal, dan perkembangan kemampuan kognitif serta sosial. Masa ini menjadi fondasi kesehatan sepanjang kehidupan (WHO & Unicef, 2023).

2. Tujuan Pemantauan Kesehatan Anak Perempuan

Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memperoleh gambaran kondisi kesehatan secara menyeluruh serta mendeteksi kemungkinan adanya gangguan yang memerlukan intervensi lebih lanjut. Menurut (American Academy of Pediatrics, 2017), pemantauan kesehatan anak dan remaja bertujuan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan optimal dan meningkatkan kualitas hidup pada masa dewasa. Tujuan utama pemantauan kesehatan anak perempuan adalah menilai kesesuaian pertumbuhan fisik dengan standar usia. Masa menjelang pubertas ditandai oleh peningkatan kebutuhan energi dan zat gizi sehingga pemantauan status pertumbuhan perlu dilakukan secara rutin (Kliegman & St Geme, 2019). Selain aspek fisik, pemantauan bertujuan menilai perkembangan psikologis dan sosial anak perempuan. Perubahan hormonal pada masa pubertas dapat memengaruhi kestabilan emosi, kepercayaan diri, hubungan sosial, serta citra tubuh. Evaluasi perkembangan psikososial penting dilakukan untuk mendeteksi adanya kecemasan, stres, gangguan perilaku, maupun masalah adaptasi sosial yang sering muncul pada remaja perempuan (Patton dkk., 2016).

Secara umum, tujuan pemantauan kesehatan anak perempuan meliputi:

- a. Memantau pertumbuhan fisik dan perkembangan mental;
- b. Mendeteksi dini masalah kesehatan, keterlambatan perkembangan, atau faktor risiko;
- c. Memberikan edukasi kesehatan dan antisipasi perubahan pubertas;
- d. Mendukung anak dan keluarga menghadapi perubahan biologis dan psikososial.

WHO menegaskan bahwa setiap kunjungan evaluasi harus mencakup promosi kesehatan, pencegahan penyakit, deteksi dini, dan anticipatory guidance (bimbingan antisipatif) sesuai usia perkembangan (WHO & Unicef, 2023).

3. Pentingnya deteksi dini kesehatan dan tumbuh kembang anak perempuan

Pada anak perempuan menuju pubertas, deteksi dini sangat penting karena masa ini ditandai dengan perubahan biologis dan psikososial yang cepat sehingga anak lebih rentan mengalami gangguan kesehatan maupun masalah perkembangan (Marilyn J. Hockenberry. dkk., 2024). Deteksi pertumbuhan selain aspek fisik, juga dilakukan deteksi dini perkembangan psikososial juga penting dilakukan. Anak perempuan yang mengalami perubahan pubertas lebih awal berisiko mengalami gangguan citra tubuh, kecemasan, depresi, dan rendahnya harga diri dibandingkan teman sebaya. Penelitian longitudinal menunjukkan bahwa pubertas dini berkaitan dengan peningkatan gejala depresi dan masalah emosional pada remaja perempuan (Deardorff, Marceau, Johnson, Reeves, Biro, Kubo, Greenspan, Laurent, Windham, & Pinney, 2021).

C. Komponen Evaluasi pada Anak Perempuan Usia Pra-Pubertas (8–9 tahun)

1. Evaluasi Pertumbuhan Fisik

Menurut WHO, evaluasi pertumbuhan fisik pada anak perempuan usia pra-pubertas (8–9 tahun) merupakan bagian penting dari *well-care visits* untuk memantau status kesehatan, pertumbuhan, dan kesiapan memasuki masa pubertas. Pada fase ini pertumbuhan anak relatif stabil sebelum memasuki percepatan pertumbuhan (*pubertal growth spurt*), sehingga pemantauan rutin diperlukan untuk mendeteksi dini gangguan pertumbuhan, masalah gizi, maupun perubahan awal pubertas (WHO, 2025; WHO & Unicef, 2023).

Dalam evaluasi pertumbuhan fisik, WHO merekomendasikan pemeriksaan antropometri yang meliputi **pengukuran berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh (*Body Mass Index/BMI*), plotting kurva pertumbuhan, serta pemantauan tanda awal pubertas**. Pengukuran tersebut digunakan untuk menilai status pertumbuhan, kecukupan nutrisi, serta mendeteksi secara dini gangguan pertumbuhan atau kelainan perkembangan pubertas. Evaluasi pertumbuhan juga menjadi bagian penting dalam sistem indikator kesehatan anak dan remaja karena pertumbuhan yang optimal merupakan indikator kualitas kesehatan sepanjang daur kehidupan (*life-course approach*) (WHO, 2024a).

a. Pengukuran berat badan

Pengukuran berat badan dilakukan untuk mengevaluasi status nutrisi dan perubahan massa tubuh selama masa transisi menuju pubertas. Pada anak perempuan, peningkatan berat badan sering kali mulai terlihat sebelum percepatan pertumbuhan tinggi badan karena adanya peningkatan jaringan lemak sebagai respons terhadap perubahan hormonal pubertas. Pemantauan berat badan secara berkala penting untuk mendeteksi kondisi **gizi kurang, obesitas, maupun perubahan pertumbuhan yang tidak sesuai usia**, mengingat status gizi berperan penting terhadap waktu *onset* pubertas dan maturasi seksual. Nutrisi adekuat selama masa transisi pubertas berperan penting dalam mendukung pertumbuhan fisik, kesehatan reproduksi, dan perkembangan psikososial.

WHO menempatkan pertumbuhan fisik sebagai indikator penting kesehatan sepanjang daur kehidupan.

b. Pengukuran tinggi badan

Pengukuran tinggi badan bertujuan memantau pertumbuhan linear anak dan mendeteksi terjadinya *growth spurt* pubertas. Anak perempuan umumnya mengalami percepatan pertumbuhan lebih awal dibandingkan laki-laki, yaitu sekitar 6–12 bulan sebelum menarke. Selama fase ini dapat terjadi peningkatan tinggi badan yang cepat akibat peningkatan hormon pertumbuhan, estrogen, dan faktor pertumbuhan lainnya. Pemantauan tinggi badan secara berkala diperlukan untuk melihat pola pertumbuhan individu. Penurunan kecepatan pertumbuhan atau tinggi badan yang tidak sesuai kurva dapat menjadi indikasi gangguan nutrisi, kelainan endokrin, keterlambatan pubertas, maupun kondisi kronis lain (WHO, 2024).

c. Pengukuran *Body Mass Index* (BMI) atau Indeks massa tubuh (IMT) sesuai usia

BMI dihitung dengan rumus:

$$\text{BMI} = \frac{\text{Berat Badan (kg)}}{(\text{Tinggi Badan (m)})^2}$$

BMI digunakan untuk menilai proporsi berat badan terhadap tinggi badan dan membantu menentukan status gizi anak. WHO merekomendasikan penggunaan *BMI-for-age* pada anak dan remaja usia 5–19 tahun dengan membandingkan hasil pengukuran terhadap standar pertumbuhan WHO. Pada anak perempuan menuju pubertas, interpretasi BMI dilakukan berdasarkan usia dan jenis kelamin, kemudian dibandingkan

dengan kurva pertumbuhan WHO. Pemantauan BMI penting karena peningkatan atau penurunan BMI berhubungan dengan waktu terjadinya pubertas. BMI yang tinggi sering dikaitkan dengan pubertas lebih dini, sedangkan malnutrisi dapat menyebabkan keterlambatan maturasi seksual. Oleh karena itu, evaluasi BMI bukan hanya indikator status nutrisi tetapi juga menjadi bagian dari evaluasi perkembangan pubertas dan kesehatan reproduksi remaja (WHO, 2025).

d. *Plotting* kurva pertumbuhan

Hasil pengukuran berat badan, tinggi badan, dan BMI selanjutnya dipetakan pada kurva pertumbuhan WHO (*growth chart plotting*). *Plotting* kurva dilakukan untuk melihat kecenderungan pertumbuhan anak dari waktu ke waktu dan membandingkannya dengan standar populasi sehat sesuai usia dan jenis kelamin (WHO, 2024a).

Kurva pertumbuhan membantu tenaga kesehatan dalam; menilai pola pertumbuhan normal, mendeteksi *growth faltering*, mengidentifikasi *overweight* dan obesitas, memantau percepatan pertumbuhan pubertas, mengevaluasi efektivitas intervensi kesehatan dan nutrisi.

e. Pemantauan tanda awal pubertas

Selain antropometri, evaluasi pertumbuhan fisik pada anak perempuan menjelang atau menuju pubertas perlu disertai pemantauan tanda awal pubertas. WHO menjelaskan bahwa masa remaja ditandai oleh perkembangan fisik, mental, dan perilaku yang cepat, sehingga perubahan biologis pubertas perlu dipantau sebagai bagian dari evaluasi kesehatan remaja (WHO, 2024a).

Pemantauan tanda awal pubertas pada anak perempuan meliputi:

- perkembangan payudara (*thelarche*) sebagai tanda pubertas pertama pada sebagian besar anak perempuan;
- percepatan pertumbuhan tinggi badan (*growth spurt*);
- perubahan komposisi tubuh dengan peningkatan jaringan lemak subkutan;
- pertumbuhan rambut pubis (*pubarche*);
- kesiapan menghadapi menstruasi (*menarche readiness*).

WHO juga menekankan pentingnya kesiapan anak perempuan menghadapi menarke melalui edukasi kesehatan reproduksi sebelum menstruasi pertama terjadi agar anak memahami perubahan tubuh dan mampu beradaptasi secara psikososial (WHO, 2024b).

Secara keseluruhan, evaluasi pertumbuhan fisik pada anak perempuan menuju pubertas dilakukan secara komprehensif dan longitudinal, melalui

kombinasi pengukuran antropometri dan pemantauan perubahan pubertas. Pendekatan ini memungkinkan deteksi dini gangguan pertumbuhan, masalah nutrisi, serta ketidaksesuaian perkembangan seksual sehingga intervensi dapat dilakukan sejak dini, lebih cepat dan tepat.

2. Evaluasi Perkembangan Sosial-emosional

Menurut WHO, evaluasi perkembangan sosial-emosional pada anak perempuan usia pra-pubertas (8–9 tahun) merupakan bagian penting dalam *well-care visits* karena periode ini menjadi masa transisi menuju remaja awal yang ditandai dengan peningkatan kemampuan regulasi emosi, interaksi sosial, kemandirian, pembentukan identitas diri, serta kesiapan menghadapi perubahan pubertas. WHO menekankan bahwa kesejahteraan anak dan remaja dipengaruhi oleh keterhubungan sosial (*connectedness*), kemampuan belajar, resiliensi, *agency*, serta kesehatan mental dan emosional. Oleh karena itu, evaluasi perkembangan sosial-emosional dilakukan secara komprehensif untuk menilai kesiapan anak memasuki masa pubertas (WHO, 2025; WHO & Unicef, 2023).

a. Perkembangan emosional dan pengendalian diri

Evaluasi perkembangan emosional dilakukan untuk menilai kemampuan anak dalam mengenali, mengekspresikan, dan mengendalikan emosi. Pada usia pra-pubertas, anak mulai menunjukkan peningkatan kemampuan *self-regulation* sehingga lebih mampu mengontrol respons terhadap situasi yang menimbulkan stres, frustrasi, maupun konflik sosial. Penilaian dilakukan terhadap kemampuan anak mengenali perasaan, mengelola kemarahan, menunjukkan empati, serta menyesuaikan respons emosi secara adaptif. Menurut WHO, penguatan *agency* dan resiliensi sejak masa kanak-kanak berperan dalam mendukung kesejahteraan psikologis pada masa remaja.

b. Perkembangan sosial dan hubungan pertemanan

Perkembangan sosial pada usia 8–9 tahun ditandai oleh meningkatnya peran teman sebaya dalam kehidupan anak. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemampuan anak membangun hubungan pertemanan, bekerja sama, berbagi, menyelesaikan konflik, serta mempertahankan interaksi sosial yang positif. WHO menjelaskan bahwa *connectedness* dengan keluarga, teman, sekolah, dan lingkungan merupakan faktor protektif penting yang mendukung kesejahteraan anak dan remaja. Hubungan sosial yang baik membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan meningkatkan kemampuan adaptasi selama masa pubertas (WHO, 2025).

c. Perkembangan kognitif dan kemampuan belajar

Evaluasi perkembangan kognitif bertujuan menilai kemampuan anak dalam berpikir logis, memecahkan masalah, berkonsentrasi, dan mengikuti proses pembelajaran. Pada usia pra-pubertas, anak mulai mengalami perkembangan kemampuan berpikir yang lebih kompleks serta peningkatan kemandirian dalam belajar. Penilaian dilakukan terhadap prestasi akademik, perhatian saat belajar, kemampuan mengambil keputusan sederhana, dan keterampilan pemecahan masalah. WHO menempatkan pendidikan, kompetensi, dan kemampuan belajar sebagai salah satu domain penting kesejahteraan remaja karena berkontribusi terhadap perkembangan jangka panjang (WHO, 2025).

d. Perkembangan citra diri dan kepercayaan diri

Menjelang pubertas, anak perempuan mulai menunjukkan perhatian terhadap penampilan fisik dan persepsi terhadap diri. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan untuk menilai penerimaan diri, rasa percaya diri, kemandirian, dan persepsi positif terhadap kemampuan diri. Penilaian ini penting karena perubahan fisik yang akan terjadi selama pubertas dapat memengaruhi citra diri anak. WHO menjelaskan bahwa penguatan agency membantu anak membangun identitas diri yang sehat dan meningkatkan kemampuan menghadapi perubahan perkembangan.

e. Kesiapan menghadapi perubahan pubertas

Evaluasi kesiapan pubertas bertujuan menilai sejauh mana anak memahami perubahan fisik, emosional, dan sosial yang akan terjadi selama pubertas. Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan mengenai perubahan tubuh, kesiapan menghadapi menstruasi (menarke), kemampuan berkomunikasi dengan orang tua, serta penerimaan terhadap perubahan perkembangan. WHO menekankan pentingnya pemberian edukasi sebelum perubahan terjadi melalui anticipatory guidance agar anak lebih siap menghadapi pubertas dan mampu beradaptasi secara positif.

Secara keseluruhan, evaluasi perkembangan sosial-emosional pada anak perempuan usia pra-pubertas dilakukan untuk memastikan anak memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik, hubungan sosial yang sehat, kemampuan belajar yang optimal, citra diri positif, dan kesiapan menghadapi perubahan pubertas. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka WHO yang memandang kesehatan anak dan remaja sebagai integrasi antara aspek fisik, psikologis, sosial, dan kesejahteraan.

3. Evaluasi Hubungan Sosial dan Lingkungan

Menurut WHO, evaluasi hubungan sosial dan lingkungan pada anak perempuan usia pra-pubertas (8–9 tahun) penting dilakukan karena lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat berperan besar dalam pembentukan kesehatan, perkembangan sosial-emosional, serta kesiapan menghadapi pubertas. WHO menekankan bahwa kesejahteraan anak dan remaja dipengaruhi oleh *connectedness*, lingkungan yang aman dan suportif, serta faktor protektif yang mendukung perkembangan optimal. Sebaliknya, paparan faktor risiko dapat meningkatkan kerentanan terhadap masalah kesehatan fisik, psikososial, maupun mental (WHO, 2025; WHO & Unicef, 2023).

a. Faktor protektif

Faktor protektif merupakan kondisi atau sumber dukungan yang membantu anak beradaptasi secara positif dan meningkatkan ketahanan (*resilience*) selama masa transisi menuju pubertas.

- Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga merupakan faktor protektif utama dalam perkembangan anak perempuan usia pra-pubertas. Evaluasi dilakukan terhadap kualitas hubungan dengan orang tua, komunikasi keluarga, keterlibatan orang tua dalam aktivitas anak, serta dukungan emosional yang diberikan. WHO menjelaskan bahwa hubungan keluarga yang positif membantu meningkatkan kesejahteraan psikologis, rasa aman, dan kemampuan anak menghadapi perubahan perkembangan.

- Dukungan Teman Sebaya

Pada usia 8–9 tahun, peran teman sebaya mulai meningkat sebagai sumber interaksi sosial dan pembelajaran perilaku. Evaluasi dilakukan terhadap kemampuan anak membangun pertemanan, memperoleh dukungan sosial, bekerja sama, dan mempertahankan hubungan yang sehat. Hubungan pertemanan yang positif berkontribusi terhadap perkembangan keterampilan sosial dan adaptasi psikososial anak.

- Harga Diri dan Kepercayaan Diri

Evaluasi juga mencakup penilaian terhadap penerimaan diri, rasa percaya diri, serta persepsi positif terhadap kemampuan yang dimiliki anak. Menurut WHO, *agency* dan *self-worth* merupakan bagian penting dalam kesejahteraan remaja karena membantu anak membangun identitas diri yang sehat dan meningkatkan kesiapan menghadapi perubahan pubertas.

- Keterhubungan Sosial (*Connectedness*)

WHO menempatkan *connectedness* sebagai salah satu komponen utama kesejahteraan anak dan remaja. Evaluasi dilakukan terhadap keterhubungan anak dengan keluarga, teman, sekolah, dan lingkungan sekitar. Anak yang memiliki hubungan sosial yang baik umumnya menunjukkan adaptasi yang lebih positif, resiliensi yang lebih tinggi, dan risiko masalah psikososial yang lebih rendah.

b. Faktor Risiko

Faktor risiko merupakan kondisi yang dapat mengganggu perkembangan fisik, sosial-emosional, dan kesehatan mental anak sehingga perlu diidentifikasi sejak dini.

- Kekerasan dalam Keluarga

Paparan kekerasan fisik, verbal, maupun emosional dalam keluarga dapat memengaruhi perkembangan psikologis dan kesejahteraan anak. Evaluasi dilakukan terhadap kondisi lingkungan rumah, pola interaksi keluarga, serta adanya tanda stres atau ketakutan pada anak. WHO menegaskan bahwa lingkungan yang aman merupakan faktor penting dalam mendukung kesehatan anak dan remaja.

- Paparan Media Digital Berlebihan

Penggunaan media digital yang berlebihan dapat memengaruhi pola tidur, konsentrasi belajar, interaksi sosial, dan kesehatan mental anak. Evaluasi meliputi durasi penggunaan gawai, jenis aktivitas digital, serta pengawasan orang tua terhadap penggunaan media. WHO mendorong penggunaan media digital yang sehat dan seimbang pada anak dan remaja.

- Perundungan (*Bullying*) dan Isolasi Sosial

Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi adanya pengalaman perundungan, penolakan sosial, atau kesulitan membangun hubungan dengan teman sebaya. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan emosional, penurunan harga diri, dan kesulitan adaptasi sosial menjelang pubertas.

- Lingkungan Tidak Mendukung

Lingkungan yang tidak aman, kurang dukungan sosial, kemiskinan, maupun keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan dapat memengaruhi perkembangan anak. WHO menjelaskan bahwa faktor sosial dan lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup anak serta remaja.

- Tekanan Akademik dan Masalah Sekolah

Evaluasi juga dilakukan terhadap tekanan belajar, tuntutan akademik, dan adaptasi anak di lingkungan sekolah. Beban akademik yang berlebihan dapat memengaruhi kesehatan mental, meningkatkan stres, dan mengganggu perkembangan sosial anak.

Secara keseluruhan, evaluasi hubungan sosial dan lingkungan pada anak perempuan usia pra-pubertas bertujuan mengidentifikasi faktor protektif yang perlu diperkuat dan faktor risiko yang perlu dicegah. Pendekatan ini mendukung terciptanya lingkungan yang aman, suportif, dan kondusif bagi pertumbuhan, perkembangan, serta kesiapan anak menghadapi masa pubertas.

D. Komponen Evaluasi Anak Perempuan Awal Pubertas (10–14 tahun)

Menurut WHO, usia 10–14 tahun termasuk dalam kategori remaja awal (*early adolescence*), yaitu fase transisi yang ditandai dengan perubahan cepat pada aspek biologis, reproduksi, psikososial, dan kesehatan mental. Masa ini merupakan periode kritis karena terjadi aktivasi hormonal pubertas, percepatan pertumbuhan, perkembangan identitas diri, serta peningkatan kebutuhan dukungan kesehatan dan psikososial.

1. Pemantauan pubertas dan perkembangan fisik

Pemantauan pubertas pada anak perempuan usia 10–14 tahun bertujuan menilai kesesuaian perkembangan biologis dan mendeteksi dini gangguan pertumbuhan maupun maturasi seksual. Menurut WHO, kesehatan fisik dan nutrisi merupakan domain utama kesejahteraan remaja (*good health and optimum nutrition*), sehingga evaluasi perkembangan pubertas menjadi bagian integral dalam pemantauan kesehatan remaja.

Pemantauan perkembangan fisik sama juga dengan pemantauan pada anak prapubertas yaitu melalui evaluasi; berat badan dan tinggi badan untuk menilai percepatan pertumbuhan (*growth spurt*), *Body Mass Index* (BMI) untuk menilai status gizi, kurva pertumbuhan untuk memantau pola pertumbuhan longitudinal, tanda pubertas sekunder, perkembangan organ reproduksi.

Pada anak perempuan awal pubertas, tanda pubertas yang dipantau meliputi:

- a. Perkembangan payudara (*thelarche*)
Merupakan tanda pubertas paling awal, umumnya muncul usia 8–13 tahun akibat stimulasi estrogen.
- b. Pertumbuhan rambut pubis (*pubarche*)
Terjadi akibat peningkatan androgen adrenal dan ovarium.
- c. *Growth spurt*

Anak perempuan mengalami percepatan tinggi badan lebih awal dibandingkan laki-laki, biasanya sebelum menarke.

d. Perubahan komposisi tubuh

Terjadi peningkatan lemak subkutan pada panggul, paha, dan payudara.

e. Menarke

Merupakan indikator maturasi reproduksi dan umumnya terjadi sekitar 2–3 tahun setelah perkembangan payudara awal.

2. Evaluasi kesehatan reproduksi dan kesiapan menstruasi

Masa awal pubertas merupakan periode penting untuk memberikan edukasi sebelum menstruasi pertama (menarke) terjadi agar anak tidak mengalami kecemasan maupun ketidaksiapan.

Evaluasi kesehatan reproduksi meliputi:

a. Pengetahuan tentang pubertas dan perubahan reproduksi

Evaluasi dilakukan terhadap pemahaman anak mengenai; perubahan bentuk tubuh, fungsi menstruasi, perubahan hormonal, kebersihan reproduksi, kesehatan organ reproduksi. Anak perempuan yang memahami proses pubertas cenderung lebih siap menghadapi perubahan dan memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah.

b. Kesiapan menghadapi menstruasi (*menarche readiness*)

Kesiapan menstruasi dievaluasi melalui; pengetahuan mengenai menstruasi, kesiapan emosional, kemampuan menggunakan pembalut, pemahaman kebersihan menstruasi, kemampuan mencari dukungan saat mengalami menarke.

c. Praktik kebersihan menstruasi (*menstrual hygiene*)

Evaluasi juga dilakukan terhadap; penggunaan pembalut, frekuensi penggantian pembalut, kebersihan genital, akses fasilitas sanitasi, pengetahuan pembuangan limbah menstruasi.

3. Evaluasi psikososial (HEADSSS)

WHO merekomendasikan penggunaan pendekatan **HEADSSS** dalam asesmen kesehatan remaja untuk mengevaluasi aspek psikososial secara komprehensif. Pendekatan ini membantu identifikasi faktor protektif maupun faktor risiko pada remaja awal. Evaluasi dilakukan melalui wawancara terstruktur dan observasi.

Komponen HEADSSS meliputi:

Komponen	Evaluasi yang dilakukan
H – Home (Rumah dan keluarga)	• hubungan dengan orang tua; • pola komunikasi keluarga; • dukungan emosional; • keamanan lingkungan rumah.
E – Education (Pendidikan)	• prestasi belajar; • adaptasi sekolah; • motivasi belajar; • kehadiran sekolah; • hubungan dengan guru.
A – Activities (Aktivitas)	• kegiatan ekstrakurikuler; • olahraga; • aktivitas digital; • interaksi sosial.
D – Drugs (Penggunaan zat)	• paparan rokok; • alkohol; • zat adiktif; • pengaruh lingkungan.
S – Suicide/Depression	• perubahan suasana hati; • perasaan sedih berkepanjangan; • ide menyakiti diri; • gejala depresi.
S – Sexuality	• pemahaman perubahan reproduksi; • identitas diri; • persepsi tubuh; • kesehatan seksual.
S – Safety (Keamanan)	• kekerasan; • perundungan (<i>bullying</i>); • keamanan digital; • perlindungan sosial

4. Evaluasi kesehatan mental

Evaluasi kesehatan mental pada anak perempuan usia 10–14 tahun perlu dilakukan secara rutin untuk mendeteksi dini masalah psikologis dan mendukung adaptasi selama masa pubertas (WHO, 2024a, 2025).

a. Skrining Kondisi Emosional

Skrining kondisi emosional dilakukan untuk menilai respons psikologis anak terhadap perubahan pubertas. Evaluasi meliputi identifikasi adanya kecemasan, gejala depresi, perubahan suasana hati (*mood*), iritabilitas, dan stres.

b. Penilaian Fungsi Sosial

Penilaian fungsi sosial bertujuan mengevaluasi kemampuan anak beradaptasi dalam lingkungan sosial dan sekolah. Aspek yang dinilai meliputi hubungan pertemanan, kemampuan berinteraksi, partisipasi dalam kegiatan sekolah, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial.

c. Penilaian Harga Diri dan Resiliensi

WHO menjelaskan bahwa *agency* dan resilience berkembang selama masa remaja dan berperan dalam mendukung kesejahteraan psikologis. Evaluasi dilakukan terhadap penerimaan diri, kepercayaan diri, kemampuan menyelesaikan masalah, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan fisik dan emosional. Resiliensi yang baik membantu anak perempuan menghadapi tantangan pubertas secara lebih adaptif.

d. Penilaian Faktor Risiko Psikososial

Penilaian faktor risiko psikososial dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi yang dapat memengaruhi kesehatan mental anak. Evaluasi mencakup paparan perundungan (bullying), kekerasan, isolasi sosial, tekanan akademik, dan masalah keluarga.

WHO menekankan bahwa kesehatan remaja dipengaruhi oleh keterkaitan antara faktor fisik, mental, sosial, pendidikan, dan lingkungan pendukung. Secara keseluruhan, evaluasi anak perempuan awal pubertas (10–14 tahun) dilakukan secara holistik, mencakup pemantauan perubahan biologis pubertas, kesiapan reproduksi, kondisi psikososial, serta kesehatan mental. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka WHO yang memandang kesejahteraan remaja sebagai kemampuan untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai potensi optimalnya.

E. Anticipatory Guidance (bimbingan antisipatif) Menuju Pubertas

Menurut WHO, anticipatory guidance atau bimbingan antisipatif merupakan komponen penting dalam well-care visits yang bertujuan mempersiapkan anak dan keluarga menghadapi perubahan perkembangan sebelum perubahan tersebut terjadi. Pada anak perempuan menuju pubertas, bimbingan antisipatif diberikan untuk membantu anak memahami perubahan fisik, psikologis, sosial, dan reproduksi sehingga proses transisi menuju remaja berlangsung sehat dan adaptif. WHO menekankan bahwa pendekatan ini merupakan bagian dari promosi kesehatan, pencegahan masalah kesehatan, serta penguatan kapasitas anak untuk mencapai kesejahteraan optimal (WHO & Unicef, 2023).

WHO juga melalui *Adolescent Well-being Framework (AWF)* menegaskan bahwa kesejahteraan remaja tidak hanya dipengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga hubungan sosial, lingkungan yang suportif, pendidikan, resiliensi, dan kemampuan mengambil keputusan, sehingga pelaksanaan bimbingan antisipatif perlu dilakukan secara holistik dengan melibatkan anak, keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial (WHO, 2025; WHO & Unicef, 2023)

1. Antisipasi Perubahan Fisik dan Pubertas

Bimbingan antisipatif pada perubahan fisik bertujuan mempersiapkan anak perempuan memahami perubahan biologis yang akan terjadi selama pubertas sehingga anak tidak mengalami kecemasan atau kebingungan saat perubahan mulai muncul. Edukasi diberikan mengenai perkembangan payudara (*thelarche*), pertumbuhan rambut pubis (*pubarche*), percepatan pertumbuhan tinggi badan (*growth spurt*), perubahan bentuk tubuh, serta munculnya menstruasi (menarke).

WHO menekankan bahwa masa remaja awal merupakan periode pertumbuhan dan perubahan cepat sehingga edukasi perlu dilakukan lebih dini agar anak memiliki kesiapan fisik dan psikologis (WHO, 2025). Pemberian informasi sebelum pubertas juga membantu mengurangi rasa takut, kebingungan, dan kecemasan yang sering muncul saat anak pertama kali mengalami perubahan tubuh.

2. Antisipasi Kesehatan Reproduksi dan Menstruasi

Bimbingan antisipatif pada kesehatan reproduksi difokuskan pada peningkatan kesiapan anak perempuan menghadapi menarke dan perubahan fungsi reproduksi. Edukasi meliputi pengertian menstruasi, siklus menstruasi, kebersihan menstruasi (*menstrual hygiene*), penggunaan pembalut, serta perawatan diri selama menstruasi. WHO menekankan bahwa edukasi sebelum menarke penting untuk mengurangi rasa takut, malu, dan kecemasan sehingga anak mampu menerima menstruasi sebagai proses fisiologis yang normal.

3. Antisipasi Perubahan Psikososial dan Emosional

Pubertas juga disertai perubahan emosi dan hubungan sosial sehingga anak perlu dibimbing untuk mengenali serta mengelola perubahan tersebut. Bimbingan diberikan melalui penguatan kemampuan regulasi emosi, pengelolaan stres, pengembangan resiliensi, dan pembentukan hubungan sosial yang sehat dengan keluarga maupun teman sebaya. Menurut WHO,

penguatan *agency*, resiliensi, dan keterhubungan sosial (*connectedness*) merupakan faktor penting dalam mendukung kesejahteraan remaja.

4. Antisipasi Perkembangan Identitas Diri dan Kepercayaan Diri

Menjelang pubertas, anak perempuan mulai memperhatikan perubahan tubuh dan membentuk identitas diri. Pada fase ini dapat muncul ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh, penurunan kepercayaan diri, atau kekhawatiran terhadap penerimaan sosial. Perubahan fisik selama pubertas dapat memengaruhi persepsi anak terhadap dirinya. Oleh karena itu, bimbingan antisipatif diarahkan pada pembentukan citra diri positif, penerimaan terhadap perubahan tubuh, peningkatan harga diri, dan penguatan kepercayaan diri. Pendampingan yang tepat membantu anak perempuan membangun identitas diri yang sehat dan meningkatkan kemampuan beradaptasi selama masa pubertas.

5. Antisipasi Perilaku Hidup Sehat

WHO menempatkan *good health and optimum nutrition* sebagai domain utama kesejahteraan remaja. Oleh karena itu, bimbingan antisipatif juga diarahkan pada pembentukan perilaku hidup sehat sejak awal pubertas. Bimbingan antisipatif juga bertujuan membentuk perilaku hidup sehat sebagai dasar pertumbuhan optimal selama pubertas. Edukasi diberikan mengenai kebutuhan gizi seimbang, aktivitas fisik rutin, pola tidur yang adekuat, kebersihan diri, serta pencegahan perilaku berisiko seperti merokok, konsumsi alkohol, dan penggunaan media digital yang berlebihan. WHO menempatkan kesehatan fisik dan nutrisi sebagai komponen utama kesejahteraan remaja.

6. Antisipasi Peran Keluarga dan Lingkungan

Keluarga dan lingkungan memiliki peran penting dalam mendukung anak menghadapi pubertas. Bimbingan antisipatif tidak hanya diberikan kepada anak, tetapi juga kepada orang tua agar mampu memberikan dukungan emosional, membangun komunikasi terbuka, serta mendampingi perubahan fisik dan psikososial anak secara positif. WHO menegaskan bahwa lingkungan yang aman dan suportif berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan remaja secara menyeluruh. Lingkungan yang suportif membantu anak perempuan menghadapi pubertas dengan lebih adaptif dan menurunkan risiko gangguan emosional.

Secara keseluruhan, anticipatory guidance menuju pubertas menurut WHO bertujuan mempersiapkan anak perempuan agar memahami perubahan

tubuh, memiliki kesiapan reproduksi, mampu mengelola emosi, membangun identitas diri positif, menerapkan perilaku sehat, serta memperoleh dukungan keluarga dan lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep WHO bahwa kesejahteraan remaja merupakan hasil interaksi antara kesehatan fisik, mental, sosial, pendidikan, dan lingkungan pendukung.

F. Referensi

- Agatha, D., Titilola, G., Abideen, S., Oluwatosin, O., Agatha, W., Sabdat, E., Tomilola, M.-M., Priscilla, E., Ebiere, H., & Oliver, E. (2022). Growth and pubertal development among HIV infected and uninfected adolescent girls in lagos, Nigeria: a comparative cross-sectional study. *Global Pediatric Health*, 9, 2333794X221082784.
- American Academy of Pediatrics. (2017). *Bright Futures Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents*, 4th Ed. American Academy of Pediatrics. <https://doi.org/10.1542/9781610020237>
- Cheng, T. S., Sharp, S. J., Brage, S., Emmett, P. M., Forouhi, N. G., & Ong, K. K. (2022). Longitudinal associations between prepubertal childhood total energy and macronutrient intakes and subsequent puberty timing in UK boys and girls. *European Journal of Nutrition*, 61(1), 157–167. <https://doi.org/10.1007/s00394-021-02629-6>
- Deardorff, J., Marceau, K., Johnson, M., Reeves, J. W., Biro, F. M., Kubo, A., Greenspan, L. C., Laurent, C. A., Windham, G. C., & Pinney, S. M. (2021). Girls' pubertal timing and tempo and mental health: A longitudinal examination in an ethnically diverse sample. *Journal of Adolescent Health*, 68(6), 1197–1203.
- Deardorff, J., Marceau, K., Johnson, M., Reeves, J. W., Biro, F. M., Kubo, A., Greenspan, L. C., Laurent, C. A., Windham, G. C., Pinney, S. M., Kushi, L. H., & Hiatt, R. A. (2021). Girls' Pubertal Timing and Tempo and Mental Health: A Longitudinal Examination in an Ethnically Diverse Sample. *Journal of Adolescent Health*, 68(6), 1197–1203. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.01.020>
- Kågesten, A. E., Pinandari, A. W., Page, A., Wilopo, S. A., & van Reeuwijk, M. (2021). Sexual wellbeing in early adolescence: a cross-sectional assessment among girls and boys in urban Indonesia. *Reproductive Health*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s12978-021-01199-4>
- Kliegman, R., & St Geme, J. W. (2019). *Nelson textbook of pediatrics* (21th ed). Elsevier.
- Marilyn J. Hockenberry., Elizabeth A. Duffy., & Karen Gibbs. (2024). *Wong's Nursing Care of Infants and Children*, 12th Edition. Elsevier.

- Patton, G. C., Sawyer, S. M., Santelli, J. S., Ross, D. A., Afifi, R., Allen, N. B., Arora, M., Azzopardi, P., Baldwin, W., & Bonell, C. (2016). Our future: a Lancet commission on adolescent health and wellbeing. *The Lancet*, 387(10036), 2423–2478.
- WHO, & Unicef. (2023). Improving the health and wellbeing of children and adolescents: guidance on scheduled child and adolescent well-care visits. World Health Organization, & United Nations Children’s Fund.
- WHO. (2024a). Maternal, newborn, child, adolescent health and ageing and quality of care indicator metadata toolkit Indicator validation guide. World Health Organization.
- WHO. (2024b). The adolescent health indicators recommended by the Global Action for Measurement of Adolescent health Guidance for monitoring adolescent health at country, regional and global levels. World Health Organization.
- WHO. (2025). Guidance for countries to assess adolescent health and well-being. World Health Organization.

G. Glosarium

AWF	= <i>Adolescent Well-being Framework</i>
BMI	= <i>Body Mass Index</i>
IMT	= indeks massa tubuh
WHO	= <i>World Health Organization</i>

PROFIL PENULIS



Rini Jusriani. Penulis lahir di Bulukumba tanggal 30 Mei 1990. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Gizi Institut Teknologi dan Kesehatan Tri Tunas Nasional. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Kesehatan Masyarakat (peminatan Gizi) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2012. Penulis melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat (peminatan Gizi) dan selesai pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013 menjadi fasilitator gizi pada Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU. Mengawali aktifitas mengajar sebagai dosen pada tahun 2016 di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Institut Teknologi dan Kesehatan Tri Tunas Nasional Makassar dan mengembangkan diri melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang Gizi dan Antropologi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rini.jusriani@tritunas.ac.id



ZULFITRAWATI, S. Gz., M. Gz, Lahir di Baraka, 20 November 1995. Telah menyelesaikan Studi Program Magister Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin dengan Judul Tesis Analisis Determinan Anemia Pada Remaja Putri di SMAN 9 Makassar. Ia adalah Dosen Tetap Program Studi S1 Gizi, Institut Teknologi dan Kesehatan Tri Tunas Nasional. Mengampu Mata Kuliah Riview Program Gizi yang membekali mahasiswa dengan menyusun, merancang dan mengelola program-program gizi di tingkat individu, masyarakat ataupun institusi dan juga mengampuh mata kuliah Perencanaan Intervensi, Evaluasi dan Pemantauan Gizi yang mengajarkan bagaimana menerapkan proses asuhan gizi secara sistematis dan berkesinambungan kepada Individu maupun Kelompok. Selama ini terlibat aktif sebagai dosen pembimbing mahasiswa Gizi dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL), dan juga terlibat aktif dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Profesi yang dimana Prodi S1 Gizi di Kampus ITEKES merujuk pada ilmu teknologi dan kesehatan Gizi Kerja yang berfokus pada penerapan ilmu Gizi di lingkungan kerja, Industri dan tempat kerja lainnya demi meningkatkan status Gizi serta Kesehatan Tenaga Kerja. Email: zulfitrawati@gmail.com

Motto: "She grows, she learns, she becomes"

PROFIL PENULIS



Nina Isywara Kusuma, Lahir di Makassar, 14 September 1986.

Telah menyelesaikan Studi Program Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin. Ia adalah Dosen Tetap Program Studi S1 Gizi, Institut Teknologi dan Kesehatan Tri Tunas Nasional.

Dalam menjalankan tugas akademiknya, beliau aktif dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan perempuan, gizi masyarakat, kesehatan reproduksi, serta edukasi tumbuh kembang anak dan remaja.

Sebagai seorang pendidik, beliau memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing melalui pendidikan kesehatan yang aplikatif dan berbasis masyarakat. Selain aktif mengajar, beliau juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah, penyuluhan kesehatan, serta pendampingan mahasiswa dalam pengembangan penelitian dan kegiatan lapangan. Dedikasi beliau di dunia pendidikan dan kesehatan menjadi bentuk nyata pengabdian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat sejak usia dini, terutama pada anak perempuan dalam menghadapi masa pubertas dan perkembangan reproduksi yang sehat.

Email: ninaisywara14@yahoo.co.id

Motto: "Educating with care, inspiring for healthier generations"

PROFIL PENULIS



(Norlaila Sofia, S.Si.T., M.Keb.) adalah dosen pada Program Studi Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma IV Bidan Pendidik di STIKES Ngudi Waluyo Semarang dan Magister Kebidanan di Universitas Padjadjaran Bandung.

Memiliki kepakaran dalam asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, penulis aktif dalam pengembangan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak, serta upaya promotif–preventif kesehatan reproduksi dan tumbuh kembang anak sejak dini. Dalam kegiatan akademik dan pendidikan, penulis mengampu berbagai mata kuliah inti kebidanan, termasuk asuhan kebidanan neonatal dan kegawatdaruratan maternal neonatal.

Selain aktif dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis juga terlibat dalam penulisan buku dan publikasi ilmiah di bidang kebidanan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: fia.bjm@gmail.com

Motto: *"Always Smile, Stay Positive"*



Darah Ifalahma, SST, M.Kes. lahir di Semarang 18 Oktober 1987. Menempuh pendidikan D3 dan D4 Kebidanan di Universitas Sebelas Maret Surakarta lulus tahun 2010, S2 Magister Kedokteran Keluarga di Universitas Sebelas Maret Surakarta lulus tahun 2014. Mata kuliah yang diampu adalah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi Balita, Gawatdarurat Maternal Neonatal, Kesehatan Perempuan dan Perencanaan

Keluarga, Pengantar Asuhan Kebidanan, Keterampilan Dasar Praktek Kebidanan, dan Keterampilan klinik Praktek Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar/ prosiding, Hak cipta (HaKI), dll. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: darah_ifa@udb.ac.id

Motto: *"Beriman, berilmu, beruntung dan bersyukur"*

PROFIL PENULIS



Prastiwi Putri Basuki, S.K.M., M.Si lahir di Klaten, 29 Januari 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro tahun 2001. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Gizi, Universitas Sebelas Maret dan lulus tahun pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2002 sebagai dosen di STIKES Wira Husada Yogyakarta. Saat ini penulis merupakan dosen di bidang Gizi Kesehatan Masyarakat Program Studi Kesehatan

Masyarakat Program Sarjana. Mata kuliah yang diampu antara lain: Ilmu Gizi Dasar, Gizi Kesehatan Masyarakat, Penilaian Status Gizi, Ekologi Pangan dan Gizi, Dasar Promosi Kesehatan, Epidemiologi Dasar, Gizi Kerja dan Metodologi Penelitian. Memiliki pengalaman akademik dan penelitian dalam topik gizi anak, gizi remaja, gizi ibu hamil, perilaku makan, status gizi, anemia, stunting, serta edukasi gizi berbasis masyarakat. Penulis aktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah terkait dengan status gizi, pola makan, aktivitas fisik, dan faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM). Selain itu, penulis juga terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program edukasi gizi, pemberdayaan kader kesehatan, serta intervensi promotif dan preventif di tingkat komunitas. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: tiwibasuki19@gmail.com
Motto: "Mendidik bukan hanya mengajar, melainkan membentuk karakter"

PROFIL PENULIS



Dr. Faridah, SST., Ns., M. Kes. Penulis berasal dari Kora Surabaya dan berkarir di bidang keperawatan dan kesehatan masyarakat. Menyelesaikan pendidikan DIII Keperawatan, DIV Keperawatan Pendidik dengan peminatan keperawatan anak dan pendidikan profesi perawat. Pada 2009, penulis meraih gelar S2, dan pada 2023, S3 Kesehatan Masyarakat di Universitas Diponegoro Semarang dengan fokus Kesehatan Ibu dan Anak.

Karir profesional penulis dimulai di NGO Helen Keller International (1996-1999) sebelum beralih ke dunia akademis. Pada tahun 2004, ia menjadi Dosen DPK di LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur. Sejak tahun 2019, penulis diperbantukan di STIKES Hang Tuah Surabaya, di mana ia aktif berkontribusi dalam pendidikan dan penelitian.

Penulis memiliki rekam jejak penelitian dengan karya yang dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional. Berperan aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat, bekerja sama dengan civitas academica di lingkungan kampus untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: faridah@stikeshangtuah-sby.ac.id

Motto: "Living, learning, blooming within"

Sinopsis

Bunga Rampai “Kesehatan dan Tumbuh Kembang Anak Perempuan Menuju Pubertas” membahas secara komprehensif proses pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan anak perempuan pada masa transisi menuju pubertas. Buku ini diawali dengan pembahasan konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan anak perempuan, meliputi tahapan perkembangan, indikator tumbuh kembang normal, pentingnya pemantauan kesehatan, serta peran keluarga dalam mendukung proses tumbuh kembang anak. Pembahasan juga diperkuat dengan kajian mengenai hubungan asupan zat besi, perilaku jajan, dan pengetahuan ibu terhadap kejadian anemia pada anak sekolah sebagai bagian dari perhatian terhadap kesehatan anak perempuan sejak dini.

Selanjutnya, buku ini menguraikan perubahan fisik dan psikologis menjelang pubertas, termasuk perubahan hormonal, emosional, sosial, serta peran orang tua dalam mendampingi anak menghadapi masa pubertas. Pembahasan dilanjutkan dengan pentingnya pemenuhan nutrisi untuk mendukung tumbuh kembang optimal, pola makan seimbang, dampak kekurangan dan kelebihan nutrisi, serta peran keluarga dalam menjaga kesehatan anak perempuan. Buku ini juga membahas kebersihan diri dan kesehatan organ reproduksi sejak dini, praktik personal hygiene, tanda-tanda masalah kesehatan reproduksi, strategi edukasi sesuai usia, serta peran bidan dalam memberikan pendampingan dan edukasi kesehatan reproduksi pada anak perempuan.

Pada bagian akhir, buku ini membahas pencegahan anemia dan berbagai masalah kesehatan pada anak perempuan, termasuk faktor risiko, dampak anemia, strategi pencegahan, dan program penatalaksanaan yang dapat dilakukan sejak usia sekolah. Selain itu, buku ini mengulas peran keluarga dalam pendampingan anak perempuan menuju pubertas serta evaluasi kesehatan dan tumbuh kembang anak berdasarkan tahapan usia. Dengan penyajian materi yang sistematis dan aplikatif, buku ini sangat relevan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, bidan, guru, orang tua, dan masyarakat sebagai referensi dalam mendukung kesehatan, kesiapan, dan tumbuh kembang optimal anak perempuan menuju masa pubertas.

Bunga Rampai “Kesehatan dan Tumbuh Kembang Anak Perempuan Menuju Pubertas” membahas secara komprehensif proses pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan anak perempuan pada masa transisi menuju pubertas. Buku ini diawali dengan pembahasan konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan anak perempuan, meliputi tahapan perkembangan, indikator tumbuh kembang normal, pentingnya pemantauan kesehatan, serta peran keluarga dalam mendukung proses tumbuh kembang anak. Pembahasan juga diperkuat dengan kajian mengenai hubungan asupan zat besi, perilaku jajan, dan pengetahuan ibu terhadap kejadian anemia pada anak sekolah sebagai bagian dari perhatian terhadap kesehatan anak perempuan sejak dini.

Selanjutnya, buku ini menguraikan perubahan fisik dan psikologis menjelang pubertas, termasuk perubahan hormonal, emosional, sosial, serta peran orang tua dalam mendampingi anak menghadapi masa pubertas. Pembahasan dilanjutkan dengan pentingnya pemenuhan nutrisi untuk mendukung tumbuh kembang optimal, pola makan seimbang, dampak kekurangan dan kelebihan nutrisi, serta peran keluarga dalam menjaga kesehatan anak perempuan. Buku ini juga membahas kebersihan diri dan kesehatan organ reproduksi sejak dini, praktik personal hygiene, tanda-tanda masalah kesehatan reproduksi, strategi edukasi sesuai usia, serta peran bidan dalam memberikan pendampingan dan edukasi kesehatan reproduksi pada anak perempuan.

Pada bagian akhir, buku ini membahas pencegahan anemia dan berbagai masalah kesehatan pada anak perempuan, termasuk faktor risiko, dampak anemia, strategi pencegahan, dan program penatalaksanaan yang dapat dilakukan sejak usia sekolah. Selain itu, buku ini mengulas peran keluarga dalam pendampingan anak perempuan menuju pubertas serta evaluasi kesehatan dan tumbuh kembang anak berdasarkan tahapan usia. Dengan penyajian materi yang sistematis dan aplikatif, buku ini sangat relevan bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, bidan, guru, orang tua, dan masyarakat sebagai referensi dalam mendukung kesehatan, kesiapan, dan tumbuh kembang optimal anak perempuan menuju masa pubertas.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-21-3 (PDF)

